



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JUNI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
2024**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan
Telp. 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo..... 2

2.1 Visi..... 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 5

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 5

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO..... 5

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 5

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 5

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 5

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 5

3.3.2 Rawat Inap 5

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)..... 5

3.3.4 Maternitas..... 5

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)..... 5

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)..... 5

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 7

3.4.1 Instalasi Farmasi 7

3.4.2 Laboratorium 7

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 7

3.4.4 Radiologi 7

3.4.5 Gizi..... 7

3.4.6 CSSD - Laundry 7

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan..... 8

3.5.1 MFK dan K3RS 7

3.5.2 Security..... 7

3.5.3 Parkir 7

3.5.4 Humas Marketing 7

3.5.5 Penjaminan..... 7

3.5.6 PIPP – MOD - MPP..... 7

3.5.7 *Cleaning Service* 7

3.6 Komite dan Tim..... 7

3.6.1 Komite Mutu..... 7

3.6.2 Komite PPI 7

3.6.3 Tim PKRS 7

3.6.5 Tim Prognas 7

3.7 Klaim Pending..... 10

3.7.1 Analisis	10
3.7.2 Tindak Lanjut	10
3.8 Permasalahan Rumah Sakit.....	44
3.9 Profil SDM	48
3.9.1 Komposisi dan Distribusi SDM	48
3.9.2 Update STR/SIP	51
3.10 Kemajuan Piutang.....	52
3.10.1 Data Piutang yang Belum Terbayar	52
3.10.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang	53
3.10.3 Update IKS	54
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	104
Bab VI Penutup	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juni Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

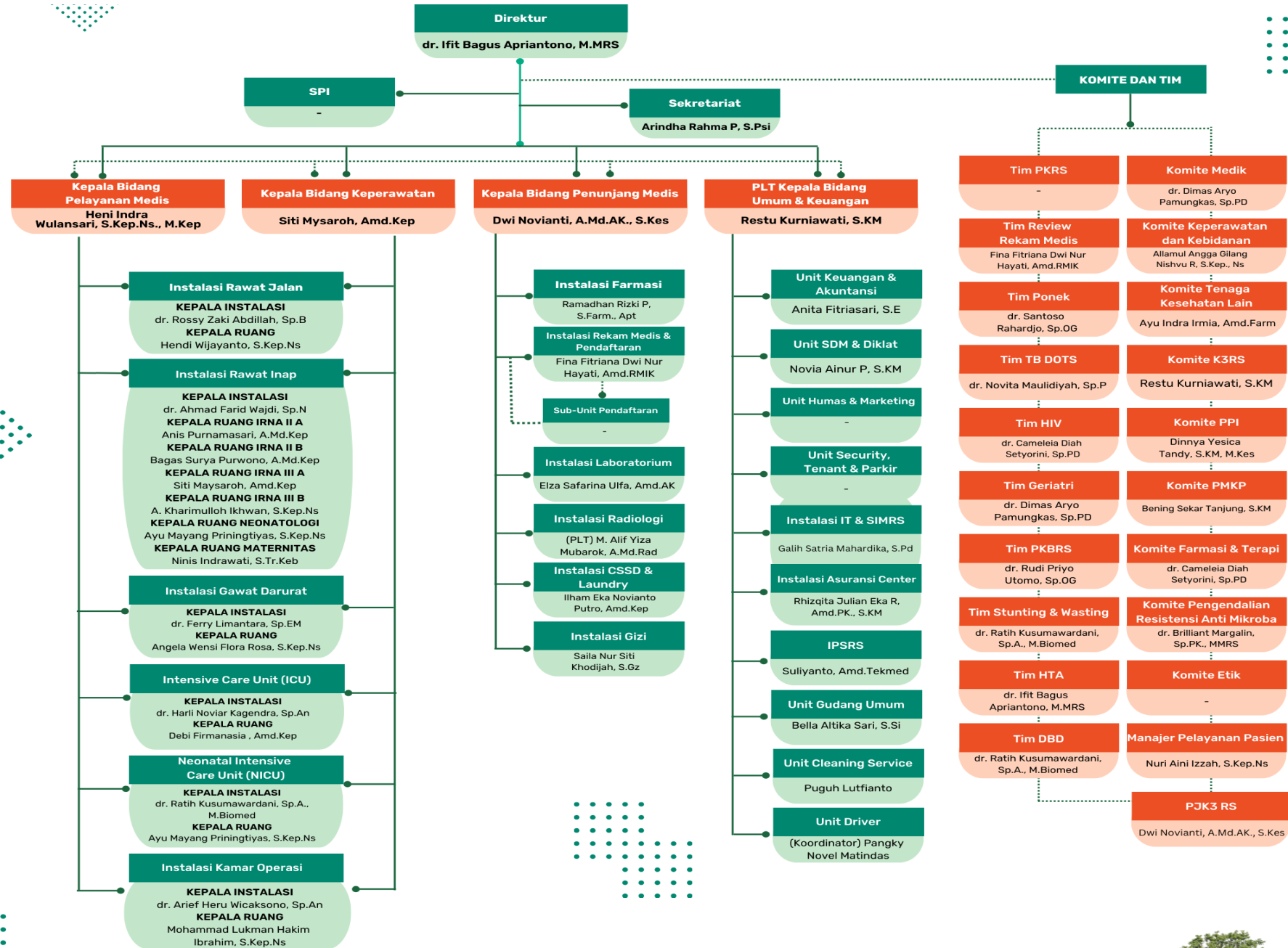
Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Dipercaya
3. Tanggung Jawab
4. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut :



BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT,BOR,ALOS,BTO,TOI)

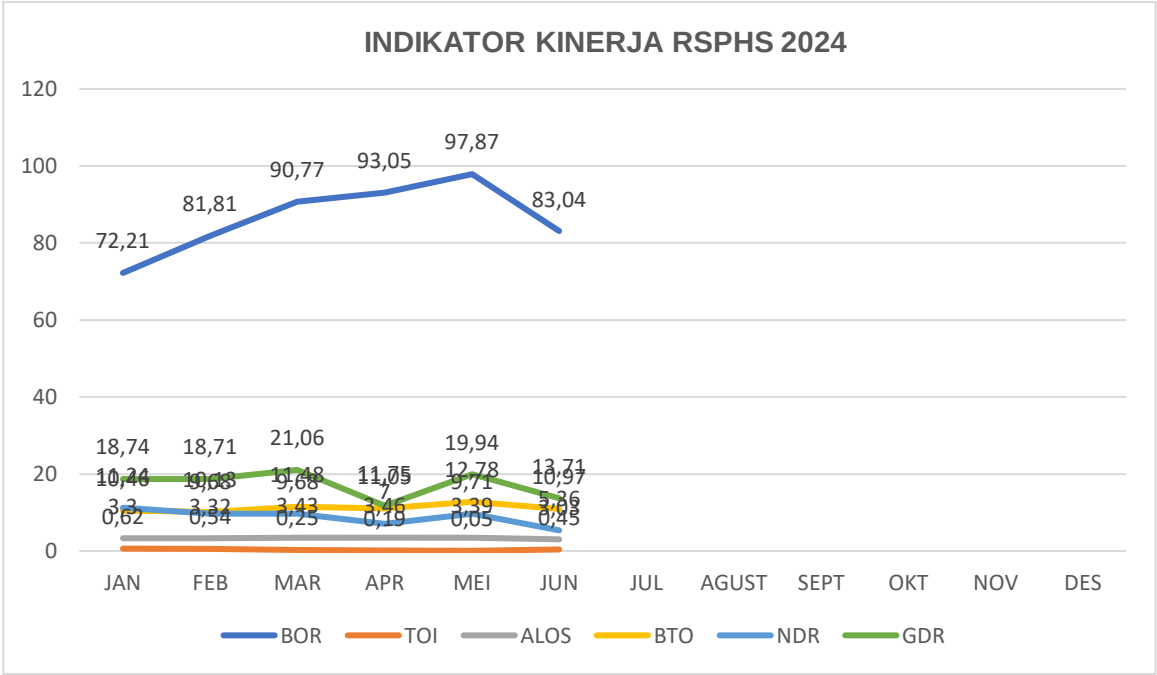
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO

No	Indikator RS	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	BOR	79.21	81.81	90.77	93.05	97,87	83,4						
2	TOI	0.62	0.54	0.25	0.19	0,05	0,45						
3	ALOS	3.3	3.32	3.43	3.46	3,39	3,3						
4	BTO	10.46	10.13	11.48	11.05	12,78	10,97						
5	NDR	11.24	9.68	9.68	7	9,71	5,36						
6	GDR	18.74	18.71	21.06	17.75	19,94	13,71						

Berdasarkan hasil perhitungan statistic Rumah Sakit pada bulan Juni 2024, didapatkan nilai indicator sebagai berikut :

- 1. BOR sebesar 83,4% (standar : 60-85%)
- 2. LOS sebesar 3,3 hari sesuai dengan standar Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo terkait SE dari PT Disa Prima Medika khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
- 3. TOI sebesar 0,45 hari (standar : 1-3 hari)
- 4. BTO sebesar 10,97 kali (standar : 40-50 kali)

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

- A. Analisa :
Adanya penurunan BOR di Bulan Juni 2024 dibandingkan dengan Bulan Mei 2024 sebesar 17,3 %. Hal ini dikarenakan jumlah hari pada bulan Juni sejumlah 30 dan adanya 2 hari besar umat muslim dan umat Hindu yang menyebabkan pasien enggan untuk berobat ke rumah sakit. Penurunan capaian ini masih dalam standart BOR yang ditetapkan oleh Kemenkes yaitu antara 60% – 85 %
- B. Masalah
Indikator TOI dan BTO belum memenuhi standar, terkait TOI sebesar 0.45 hari menandakan bahwa waktu tempat tidur tidak terisisangat pendek, ini bisa menjadi salah satu faktor *nosocomial*, begitupun dengan beban kerja perawat yang cukup tinggi. Sedangkan BTO standar tersebut digunakan untuk satu tahun penuh, angka 10.97 mencerminkan bahwa 1 tempat tidur bisa digunakan 10.97 kali perawatan dalam sebulan.

- C. Tindak Lanjut
1. Mengevaluasi jumlah tempat tidur sesuai kebutuhan di rumah sakit, dengan adanya penggunaan yang signifikan setiap bulan agar penggunaan tempat tidur sesuai standar

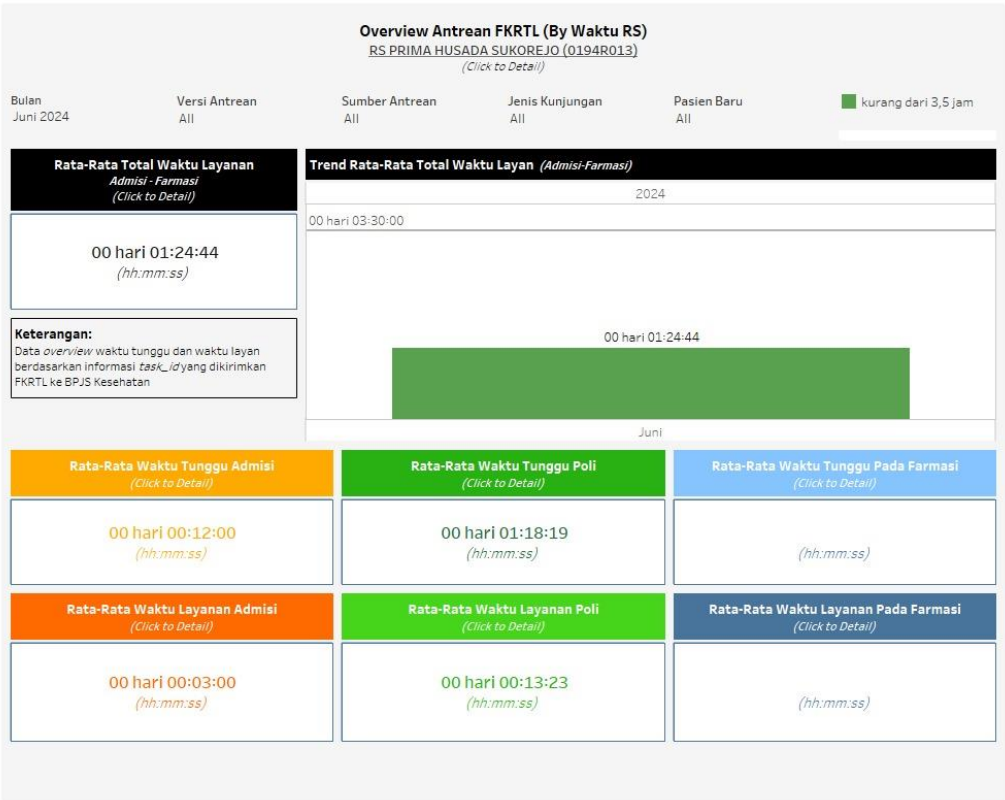
2. Mengusulkan jumlah TT ditambahkan sehingga sesuai dengan fakta dilapangan sepanjang jumlah perawat memenuhi perhitungan sesuai standard

3. Meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap dan menjalankan sasaran keselamatan pasien agar mutu pelayanan tetap sesuai standar

3.1.4 Antrian Online BPJS Kesehatan

A. Profil Pelayanan Antrian Online

Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online Bulan Juni 2024



3	IKO	1. Ruang Tunggu Kamar Operasi dengan Sistem Informasi Daftar Tunggu Pelayanan Operasi dan Edukasi Keluarga secara elektronik 2. Pelayanan Kamar Operasi dengan C-Arm	√		
4	IRJA	Pelayanan Poli Eksekutif		√	Masih dalam perencanaan ulang. Target tahun 2025
5	Maternitas	Pembukaan layanan Mom SPA untuk ibu hamil dan pasca melahirkan		√	Masih dalam tahap pengajuan tarif ke PT Disa Prima Medika
6	Neonatologi	1. Layanan Baby SPA  2. Layanan photo new born 	√		
7	NICU	Ruang tunggu untuk ibu yang bayinya sakit dengan dilengkapi fasilitas untuk memompa ASI (ruang ibu menyusui)	√		Ruang Ponpa ASI dapat dilakukan di ruang Neonatologi
8	IRNA 2A	1. Adanya smart lock door untuk ruang isolasi 2. Ruang KIE yang nyaman untuk keluarga pasien yang privasi		√	Masih menunggu proses pembangunan selesai gedung baru, rencana Desember 2024
9	IRNA 2B	Nurse station yang layak dan nyaman disertai dengan ruang edukasi yang nyaman bagi keluarga pasien yang privasi	√		
10	IRNA 3A	Membuat playground untuk pasien anak 	√		

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

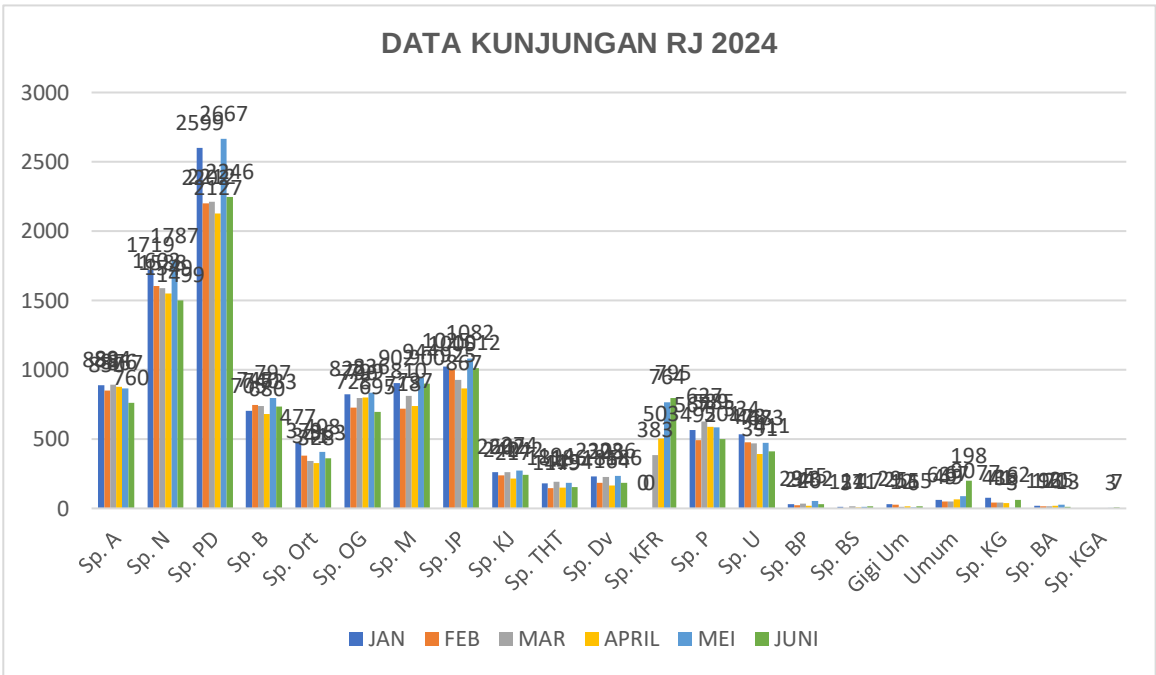
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Jalan Juni 2024

No	Nama Poli	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Presentase
1	Anak	800	888	850	894	876	867	760	↓ 1,07%
2	Saraf	1000	1719	1603	1588	1549	1787	1499	↓ 2,88%
3	Penyakit Dalam	2000	2599	2202	2212	2127	2667	2246	↓ 4,21%
4	Bedah Umum	700	705	745	740	680	797	733	↓ 0,64%
5	Orthopedi	300	477	379	341	328	408	363	↓ 0,45%
6	Kandungan	500	822	728	796	799	836	695	↓ 1,41%

7	Mata	500	902	718	810	737	944	900	↓ 0,44%
8	Jantung	600	1025	1005	925	867	1082	1012	↓ 0,7%
9	Jiwa	200	260	240	262	217	274	242	↓ 0,32%
10	THT	150	181	147	194	149	186	154	↓ 0,32%
11	Kulit Dan Kelamin	200	230	185	228	164	236	186	↓ 0,5%
12	Rehab Medik	200	0	0	383	503	764	795	↑ 0,31%
13	Paru	400	567	492	627	589	585	501	↓ 0,84%
14	Urologi	400	534	478	468	391	473	411	↓ 0,62%
15	Bedah Plastik	25	29	24	34	20	55	32	↓ 0,23%
16	Bedah Syaraf	10	12	5	14	7	11	17	↑ 0,06%
17	Gigi Umum	10	29	25	12	15	6	15	↑ 0,09%
18	Umum Dan MCU	30	63	49	49	67	90	198	↑ 1,08%
19	Konservasi Gigi	30	77	41	41	38	3	62	↑ 0,59%
20	Bedah Anak	10	19	17	16	20	25	13	↓ 0,12%
21	Gigi Anak	20					3	7	↑ 0,04%
TOTAL		8065	11138	9933	10634	10143	12100	10834	↓ 12,66%

B. Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2024



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
 Berdasarkan gambar diatas menunjukkan kunjungan Rawat Jalan pada bulan Juni mengalami penurunan sebanyak 12,66% jumlah kunjungan dibanding dengan bulan sebelumnya. Penurunan kunjungan Rawat Jalan terjadi karena adanya 2 hari besar keagamaan dan jumlah hari pada Bulan Juni adalah 30 hari. Jumlah keseluruhan kunjungan pasien adalah 10.834 . Pada bulan Juni kunjungan paling banyak berada pada Poli Penyakit Dalam yaitu 2.246, diikuti dengan Poli Syaraf sebanyak 1.499, dan Poli Jantung pada urutan ke tiga yaitu 1.012.

Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Promosi melalui media sosial dan secara langsung terkait pelayanan dokter-dokter baru dan pelayanan tambahan	Memperkenalkan dokter baru di RS Prima Husada Sukorejo sehingga dapat meningkatkan kunjungan di RS Prima Husada Sukorejo dan juga meningkatkan pendapatan RS.	1. Seluruh Poliklinik 2. Dokter spesialis baru	1. Membuat flyer di semua media sosial RS dengan foto dokter baru 2. Sosialisasi kepada perusahaan rekanan 3. Sosialisasi di setiap TV ruang tunggu di RS	1. PKRS 2. Humas dan Marketing	1 Bulan

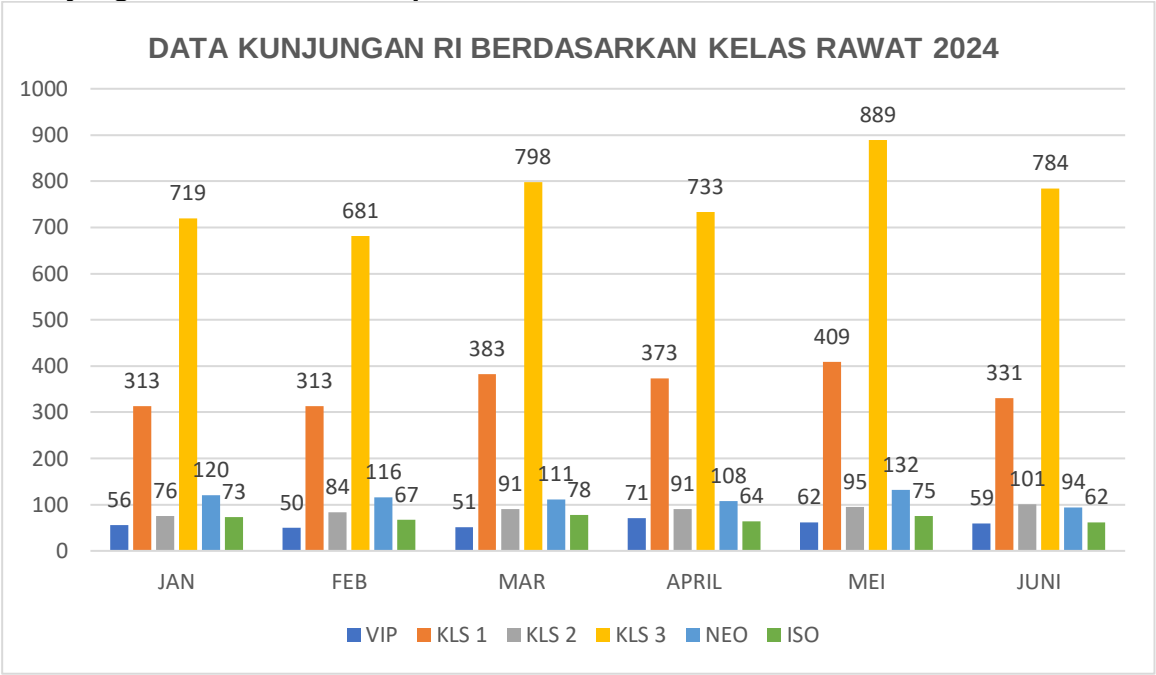
	baru					
2	Promosi terkait layanan poli malam	Meningkatkan utilitas Rawat Jalan dan kunjungan Rawat Jalan	Seluruh Poliklinik	1. Membuat flyer dan disosialisasikan di semua sosial media RS dengan menyertakan jadwal praktek dokter poli malam 2. Pemanfaatan media TV untuk menunjukkan layanan tambahan di RS Prima Husada Sukorejo 3. Kunjungan perusahaan	PKRS	1 Bulan
3	Promosi alat kesehatan penunjang pemeriksaan baru	Meningkatkan pelayanan pada pasien sesuai kebutuhan pasien sehingga dapat meningkatkan kunjungan juga di Rawat Jalan	Seluruh Poliklinik	1. Membuat flyer dan disosialisasikan di semua sosial media RS dengan menyertakan foto layanan penunjang kesehatan baru 2. Pemanfaatan media TV untuk menunjukkan layanan tambahan di RS Prima Husada Sukorejo 3. Kunjungan perusahaan	Humas dan Marketing	1 Bulan

3.3.2 Rawat Inap

A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar Juni 2024

No	Kelas Perawatan	Jumlah Pasien								
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	JR	PT	BPJS Ikut Ibu	Total	%
1	VIP	17	22	0	11	0	9	0	59	4
2	Kelas I	7	313	0	9	2	0	0	331	23
3	Kelas 2	11	65	22	1	2	0	0	101	7
4	Kelas 3	21	750	0	1	12	0	0	784	54,7
5	Neonatologi	4	24	0	1	0	0	65	94	6,5
6	Isolasi	1	61	0	0	0	0	0	62	4,3
TOTAL		61	1235	22	23	16	9	65	1431	100

B. Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Kelas Rawat 2024



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa:
Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah pasien di bulan Juni hampir disetiap kelas rawat dibanding dengan bulan Mei. Jumlah Pasien Rawat Inap pada bulan Mei sejumlah 1.662 pasien dan pada bulan Juni sebanyak 1.431pasien. adanya penurunan jumlah kunjungan di Rawat Inap di pengaruhi beberapa faktor salah satunya adanya hari besar yaitu peringatan idul adha dan hari Raya Nyepi sehingga masyarakat enggan untuk datang periksa dan lebih memilih perayaan hari besar di Rumah.

Rencana Tinjak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Membuat promosi di media sosial terkait pelatihan yang dilakukan di Bulan Juni seperti pelatihan BHD oleh Spesialis emergency	Meningkatkan mutu SDM tenaga kesehatan RS Prima Husada Sukorejo	Seluruh tenaga kesehatan RS Prima Husada Sukorejo	1. Melakukan perekaman pada saat pelatihan 2. Menyebarkan Foto melalui media sosial rumah sakit	SDM	1 Bulan
2	Membuat agenda doa bersama setiap jam 08.00 yang disiarkan melalui speaker rumah sakit oleh CSO	Meningkatkan kepercayaan kepada pasien bahwa RS Prima Husada adalah rumah sakit yang menjunjung tinggi Hak pasien	Pasien RS Prima Husada Sukorejo	1. Membuat Surat pemberitahuan terkait doa bersama setiap pukul 8.00 yang di speaker oleh CSO 2. Membuat SPO pelaksanaan doa pagi melalui	CSO	1 Bulan

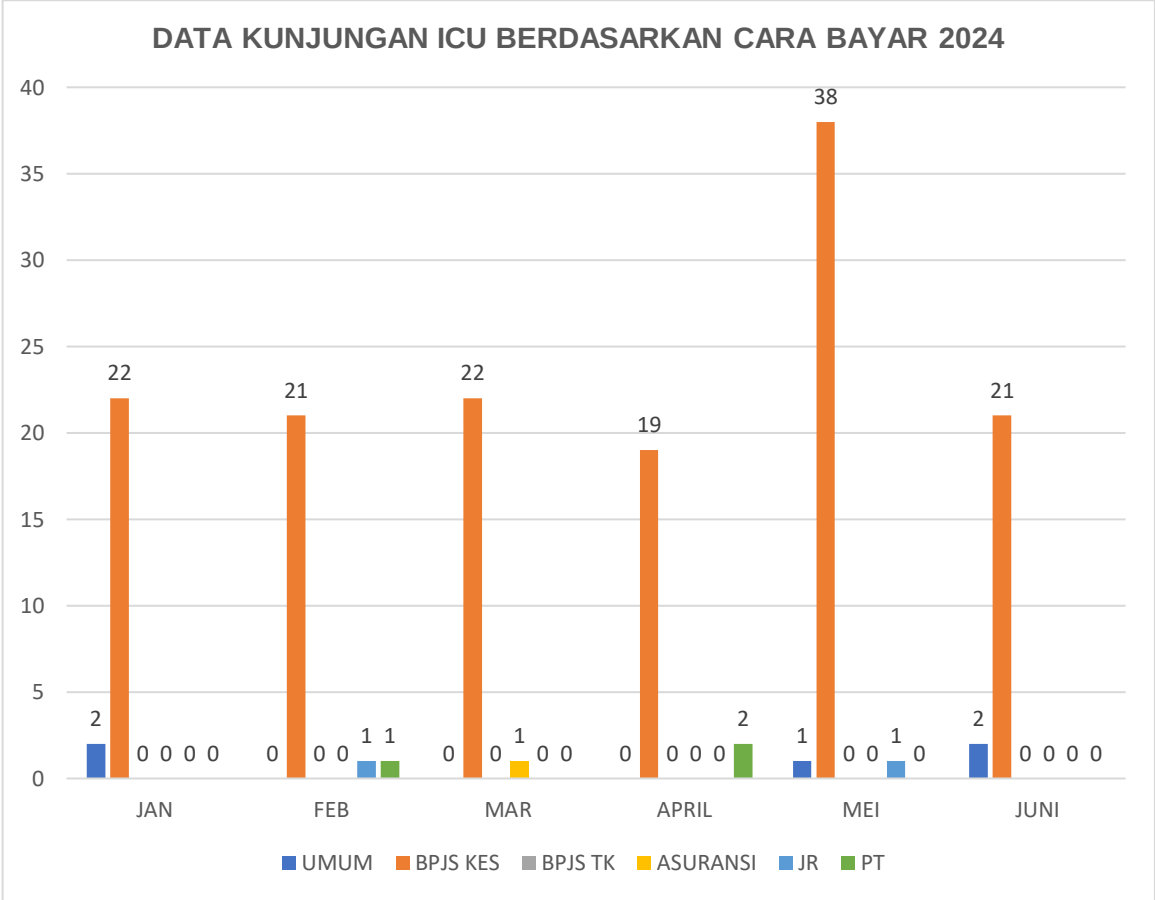
				speaker		
3	Melakukan upgrade dan maintenance pada sarana prasarana yang ada di RS.	Meningkatkan kepuasan kepada pasien dan keluarga sehingga bisa meningkatkan kunjungan pada RS.	Sarana dan Prasarana di RS Prima Husada Sikorejo	1. Meminta jadwal pada IPSRS 2. Segera lapor saat terjadi kerusakan	Staf Rawat Inap Staf IPSRS	1 Bulan

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

A. Tabel Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar Juni 2024

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jumlah	Prosentase
1	Umum	4	2	0	0	0	1	2	5	↑ 0,01%
2	BPJS Kes	20	22	21	22	19	38	21	143	↓ 0,17%
3	BPJS TK	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	Asuransi Swasta	1	0	0	1	0	0	0	1	0%
5	JR	1	0	1	0	0	1	0	2	↓ 0,01%
6	Perusahaan	1	0	0	0	2	0	0	2	0%
TOTAL		28	24	22	23	21	40	22	152	↓ 0,18%

B. Grafik Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar 2024



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
 Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan jumlah pasien pada bulan Juni yaitu sebanyak 0,17% dibanding dengan bulan Mei. Jumlah pasien ICU pada bulan Mei sejumlah 40 pasien dan pada bulan Juni 22 pasien. Terjadinya penurunan jumlah pasien disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah kunjungan pada unit Rawat inap dan IGD juga menurun.

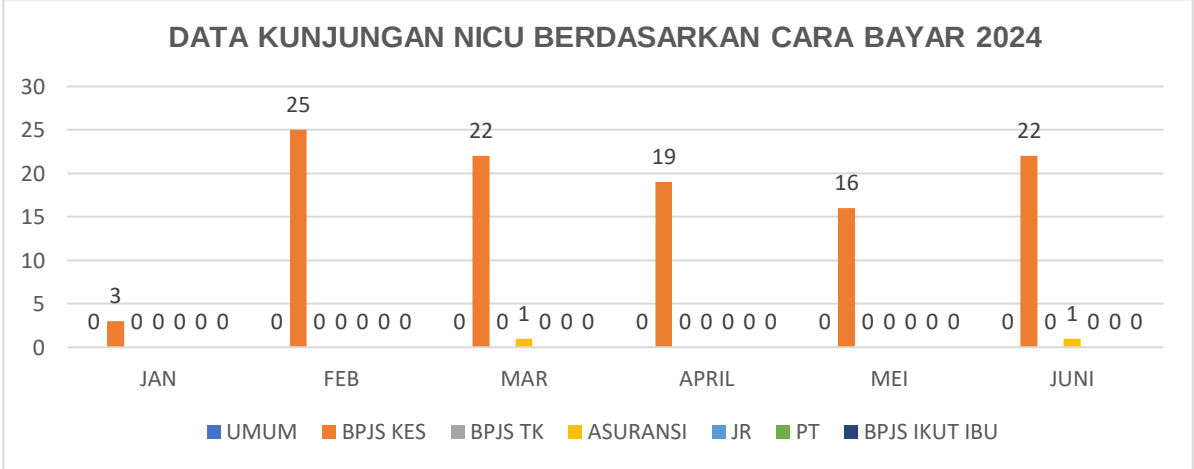
Rencana Tindak Lanjut						
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menambah waktu jam besuk pasien tahap akhir kehidupan	Memberikan kenyamanan kepada keluarga pasien sehingga dapat meningkatkan kunjungan.	Keluarga pasien di ICU	1. Menambah di jam besuk pagi yaitu dari mulai pukul 10.00 – 13.00 (lebih 1 jam dari waktu biasanya) 2. Membuat pemberitahuan kepada seluruh staf di RS Prima Husada Sukorejo 3. Membuat pemberitahuan yang tertempel di pintu masuk ICU	Staf ICU Sekertariat RS	1 Bulan
2	Melakukan pendampingan spiritual pada pasien	Memberikan rasa kenyamanan dari segi spiritual dan keihlasan kepada pasien dan keluarga sehingga bisa menerima sakitnya	Pasien dan keluarga di ICU serta perawat di ICU	1. Membuat jadwal pendampingan spiritual 2. Membuat pemberitahuan bahwa ada layanan spiritual bagi pasien akhir kehidupan	Staf ICU PJ Kerohaniawan	1 Bulan

3.3.4 NICU

A. Tabel Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar Juni 2024

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jumlah	Prosentase
1	Umum	1	0	2	0	0	1	1	4	0%
2	BPJS Kes	5	3	25	22	19	16	22	107	↑ 0,01%
3	BPJS TK	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	Asuransi Swasta	1	0	0	1	0	0	1	2	0%
5	JR	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	Perusahaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		10	3	27	23	19	17	24	113	↑ 0,01%

B. Grafik Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar 2024



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
 Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan terjadi kenaikan 0,01% dibanding dengan bulan Mei dimana kunjungan 2 pasien. Pada bulan Juni ini

ada 3 pasien dengan pembayaran BPJS Kesehatan. Adapun kenaikan jumlah pasien di pengaruhi beberapa faktor salah satunya tersedianya peralatan yang memadai di ruang NICU.

Rencana Tindak Lanjut

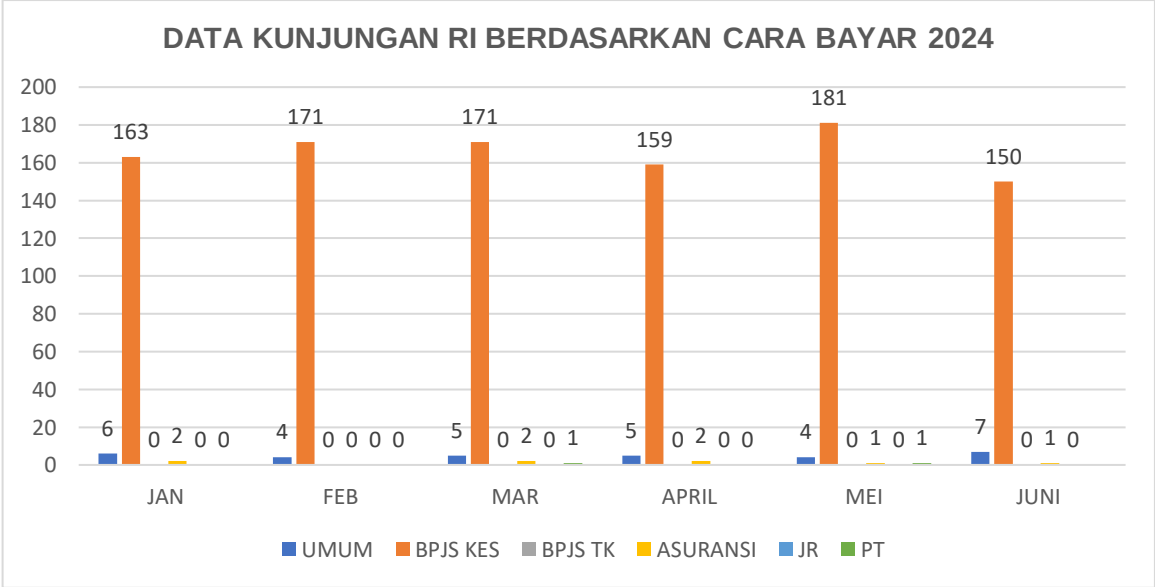
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Promosi layanan NICU	Menambah kunjungan dengan ketertarikan adanya layanan NICU di RS Prima Husada Sukorejo	Masyarakat luas	1. Membuat flyer layanan NICU yang disebarakan melalui semua media sosial RS 2. Membuat vidio ruangan NICU lengkap beserta alat kesehatan	PKRS	1 Bulan
2	Menyebarkan layanan NICU pada RS atau Klinik rekanan	Menambah kunjungan dengan cara menerima rujukan-rujukan dari RS lain yang membutuhkan NICU	Fasilitas kesehatan tingkat pertama	Membuat flyer layanan NICU di RS Prima Husada Sukorejo	Humas dan Marketing	1 Bulan

3.3.5 Maternitas

A. Tabel Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar Juni 2024

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Jumlah	Prosentase
1	Umum	4	6	4	5	5	4	7	31	↑ 0,03%
2	BPJS Kes	150	163	171	171	159	181	150	995	↓ 0,31%
3	BPJS TK	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	Asuransi Swasta	5	2	0	2	2	1	1	8	0,0%
5	JR	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	Perusahaan	5	0	0	1	0	1	0	2	↓ 0,01%
TOTAL		167	171	175	179	166	187	158	1.036	↓ 0,29%

B. Grafik Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar 2024



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan jumlah pasien pada bulan Juni yaitu sebanyak 0,29% dibanding dengan bulan Mei. Jumlah pasien Maternitas pada bulan Mei sejumlah 187 pasien dan pada bulan Juni sebanyak 158 pasien. Adanya penurunan jumlah pasien di ruang maternitas di pengaruhi beberapa beberapa faktor antara lain tidak ada tanggal cantik pada bulan Juni dan Jumlah tanggal pada Bulan Juni sejumlah 30 hari.

Rencana Tindak Lanjut

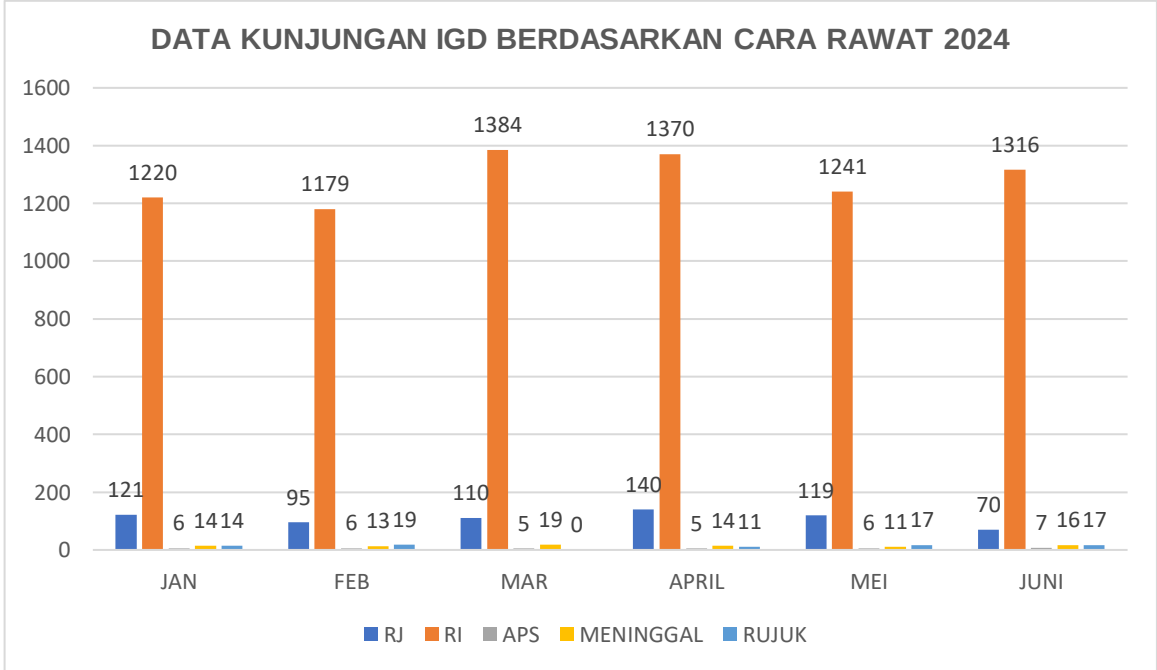
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melakukan promosi terkait layanan tambahan	Menambah kunjungan pasien dan kepuasan pasien	Seluruh pasien dan keluarga pasien	1. Membuat flyer tambahan layanan di Maternitas, termasuk senam ibu hamil dan foto new born 2. Membuat flyer USG terbaru yang ada di Poli	Staf Maternitas Humas dan Marketing	1 Bulan
2	Memberikan service excelent kepada pasien	Menambah kenyamanan dan tingkat kepuasan kepada pasien	Seluruh staf Maternitas	1. Memberikan pelatihan kepada staf Maternitas dalam melayani pasien dengan service excellent	Bagian Diklat Staf Maternitas	1 Bulan

3.3.6 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

A. Tabel Kunjungan Pasien IGD 2024

No	Bulan	Target	Jumlah	Keterangan					Prosentase
				RJ	RI	APS	Meninggal	Rujuk	
1	Jan	1200	1341	121	1220	6	14	14	↑ 1,41%
2	Feb	1200	1274	95	1179	6	13	19	↑ 0,74%
3	Mar	1200	1494	110	1384	5	19	0	↑ 2,94%
4	April	1200	1510	140	1370	5	14	11	↑ 3,1%
5	Mei	1200	1637	119	1241	6	11	17	↑ 4,37%
6	Juni	1200	1386	70	1316	7	16	17	↓ 1,86%

B. Grafik Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Cara Rawat 2024



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan grafik di atas pada bulan Juni kunjungan pasien berdasarkan cara bayar mengalami penurunan sebanyak 1,86% dibanding dengan bulan

Mei dengan jumlah kunjungan pada bulan Juni sebanyak 1386 dan bulan Mei sebanyak 1637 pasien, Berdasarkan analisa penurunan kunjungan berdasarkan cara rawat di IGD dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adanya peringatan hari besar pada bulan Juni ini sehingga masyarakat enggan untuk pergi periksa dan memilih perayaan di Rumah.

Rencana Tindak Lanjut

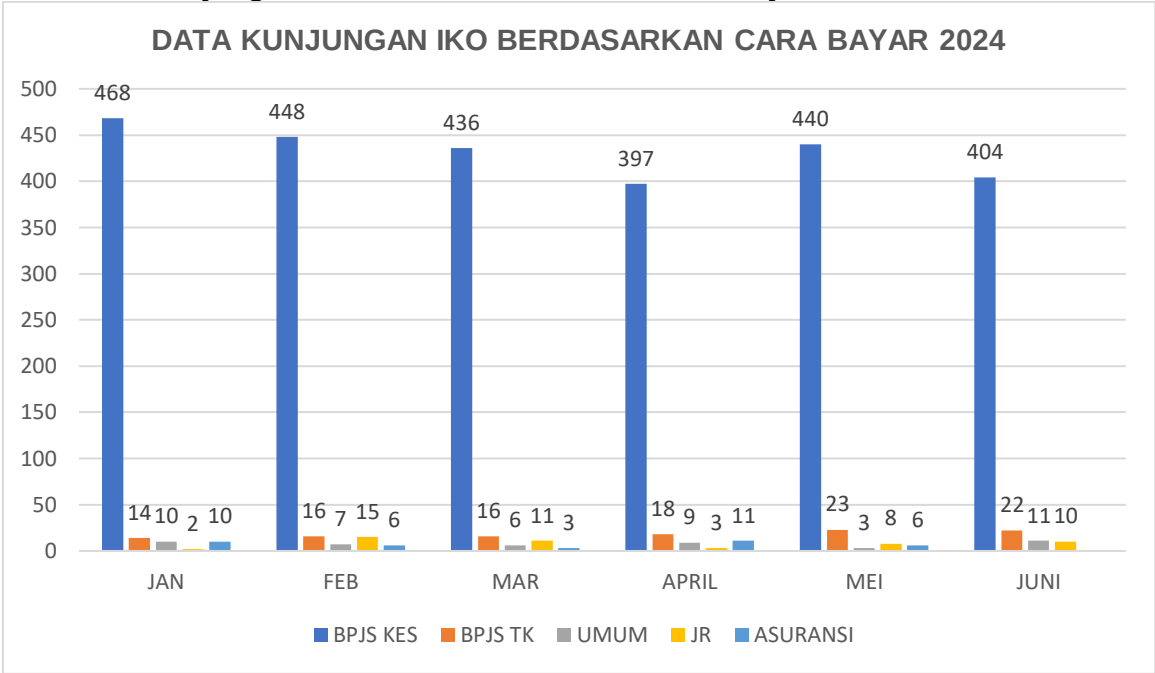
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melakukan promosi terkait layanan tambahan	Menambah kunjungan pasien dan kepuasan pasien	Seluruh pasien dan keluarga pasien	1. Membuat flyer tambahan layanan di Maternitas, termasuk senam ibu hamil dan foto new born 2. Membuat flyer USG terbaru yang ada di Poli	Staf IGD Humas dan Marketing	1 Bulan
2	Memberikan service excelent kepada pasien	Menambah kenyamanan dan tingkat kepuasan kepada pasien	Seluruh staf IGD	Memberikan pelatihan kepada staf IGD dalam melayani pasien dengan service excellent	Bagian Diklat Staf IGD	1 Bulan
3	Melakukan percepatan perpindahan pasien rawat ke ruangan rawat inap	Menambah kenyamanan dan tingkat kepuasan kepada pasien	Seluruh staf IGD Seluruh perawat dna bidan Rawat Inap	1. Melakukan rekapitulasi pada setiap akhir shift oleh perawat ruangan kepada perawat IGD kamar ready 2. Melakukan konfirmasi/ jemput bola oleh perawat rawat inap kepada perawat IGD 3. Mematok waktu tunggu maximal pasien di IGD	Staf IGD Staf perawat dan bidan rawat inap	1 Bulan

3.3.7 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

A. Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar 2024

No	Bulan	Target	Jumlah	Keterangan					Prosentase
				BPJS Kes	BPJS TK	Umum	JR	Asuransi Lain	
1	Jan	400	504	468	14	10	2	10	↑1%
2	Feb	400	492	448	16	7	15	6	↑ 0,9%
3	Mar	400	472	436	16	6	11	3	↑ 0,7%
4	April	400	438	397	18	9	3	11	↑ 0,3%
5	Mei	400	480	440	23	3	8	6	↑ 0,8%
6	Juni	400	452	404	22	11	10	5	↓ 0,5%

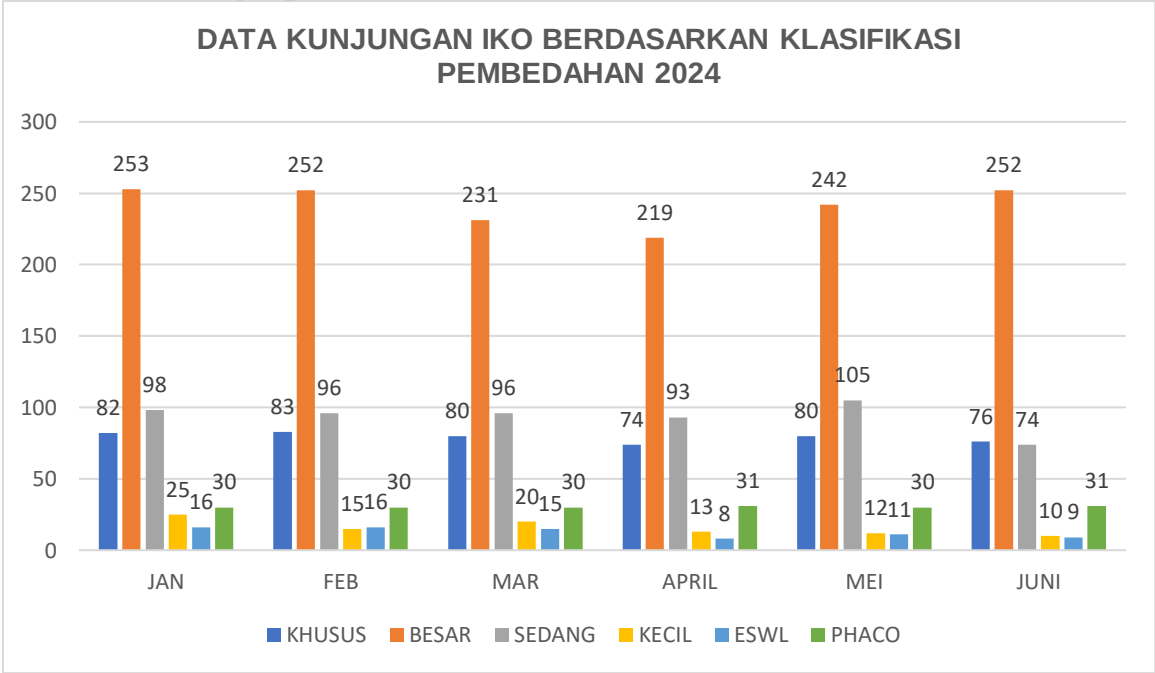
B. Grafik Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar 2024



C. Tabel Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan 2024

No	Bulan	Target	Jumlah	Keterangan						Prosentase
				Khusus	Besar	Sedang	Kecil	ESWL	Phaco	
1	Jan	400	504	82	253	98	25	16	30	↑1%
2	Feb	400	492	83	252	96	15	16	30	↑ 0,9%
3	Mar	400	472	80	231	96	20	15	30	↑ 0,7%
4	April	400	438	74	219	93	13	8	31	↑ 0,3%
5	Mei	400	480	80	242	105	12	11	30	↑ 0,8%
6	Juni	400	452	76	252	74	10	9	31	↓ 0,5%

D. Grafik Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan



E. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan grafik dan tabel di atas terjadi penurunan jumlah pasien, pada bulan Juni sebanyak 0,5% dibanding dengan bulan Mei dengan jumlah 0,8 % di bulan Mei jumlah angka operasi mencapai 480 dan pada bulan Juni sebanyak 452. Berdasarkan analisa turunya angka operasi salah satu nya adalah turunya kunjungan pasien poli dan kunjungan pasien IGD juga menurun sehingga mempengaruhi kunjungan di kamar operasi.

Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Promosi layanan baru C-Arm	Meningkatkan jumlah kunjungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Masyarakat luas	Membuat flyer dan disebarluaskan di semua media sosial RS	PKRS Humas dan marketing	1 Bulan
2	Promosi operasi aman cepat akurat	Meningkatkan jumlah kunjungan dan kepuasan pasien	Masyarakat luas	1. Membuat video testimoni terkait kepuasan pasien yang mnejalani operasi di RS Prima Husada Sukorejo 2. Menyebarluaskan video testimoni kepada masyarakat luas melalui media sosial RS	PKRS Humas dan marketing	1 Bulan

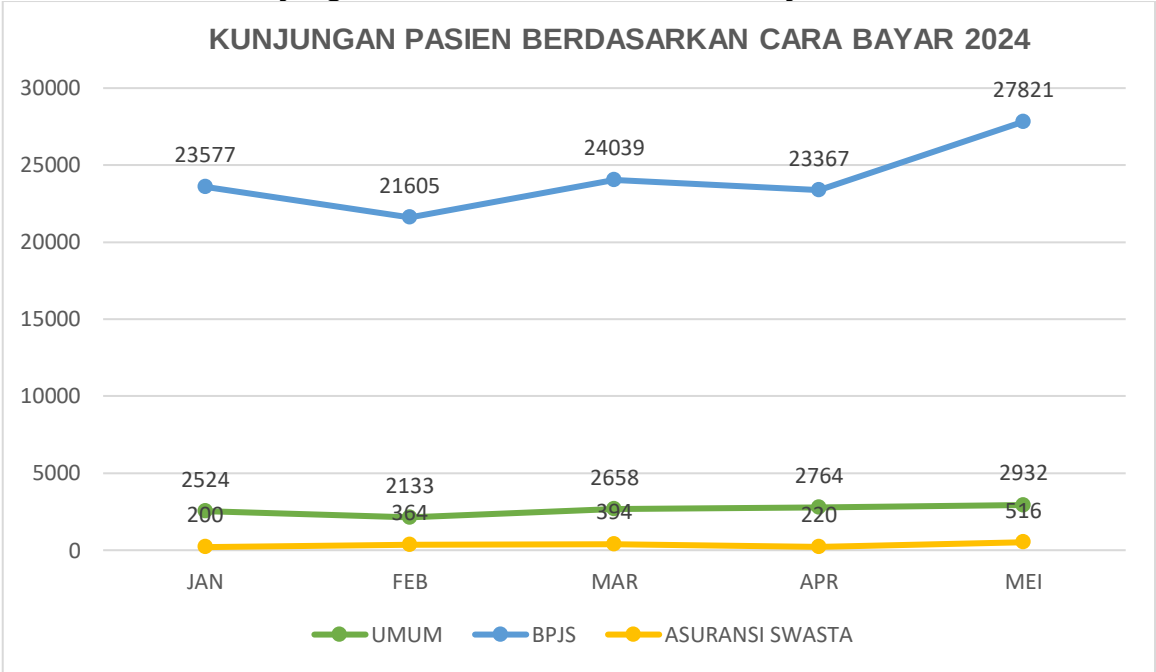
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

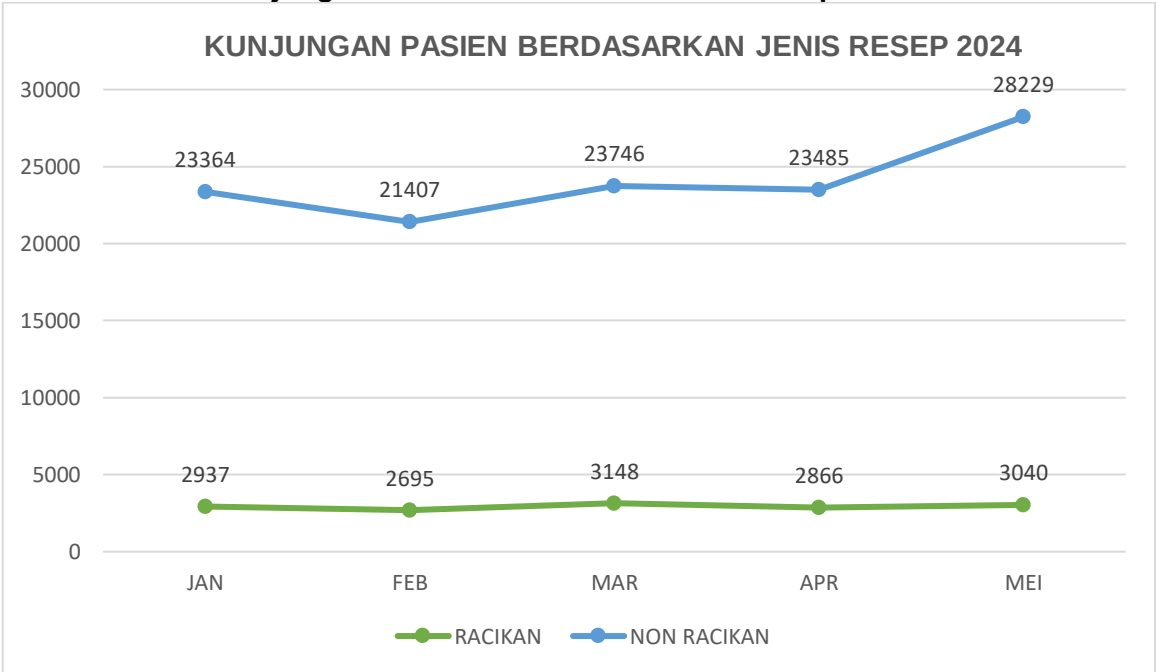
Rekap Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar & Jenis Resep Mei 2024

N o	Bulan	Jenis Resep Depo Farmasi						Total Resep
		Umum		BPJS		Asuransi Swasta		
		Racikan	Non Racikan	Racikan	Non Racikan	Racikan	Non Racikan	
1	Januari	373	2151	2564	21013	0	200	26301
		2524		23577		200		
2	Februari	356	1777	2333	19272	6	358	24102
		2133		21605		364		
3	Maret	422	2236	2726	21313	0	197	27091
		2658		24039		394		
4	April	387	2377	2479	20888	0	220	26351
		2764		23367		220		
5	Mei	391	2541	2647	25174	2	514	32049
		2932		27821		516		

Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Mei 2024



Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Jenis Resep Mei 2024

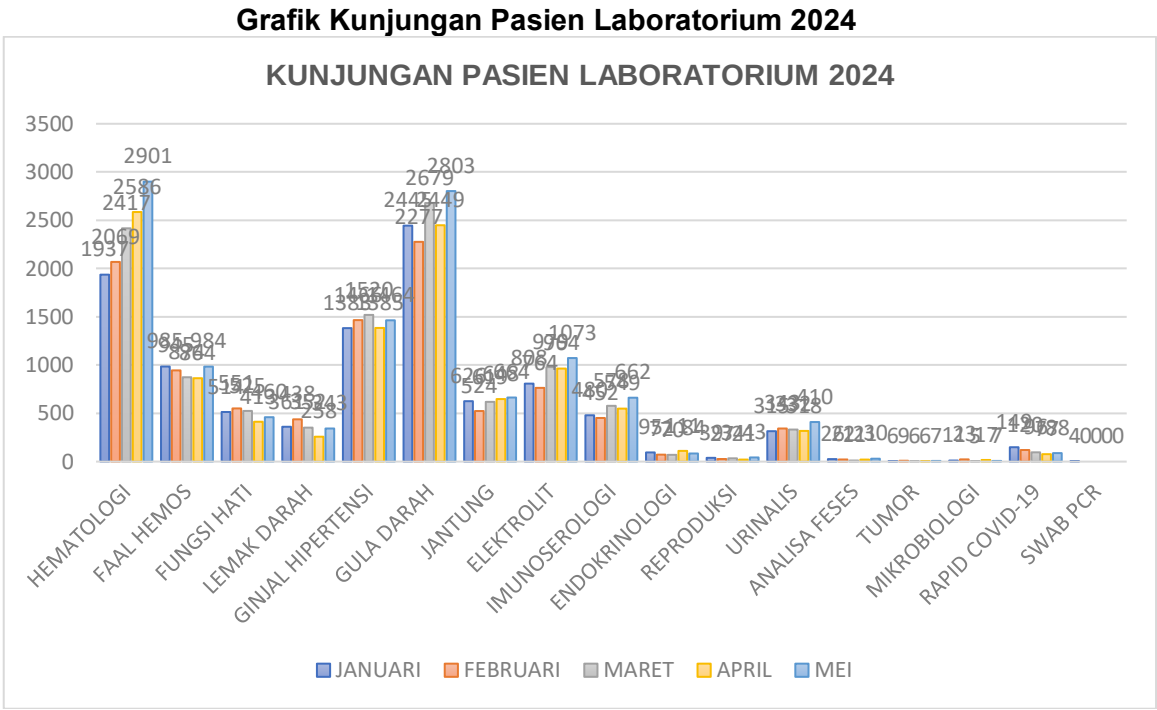


Tabel Permasalahan Farmasi Mei 2024

No	Permasalahan	Analisa	
1	Tata ruang farmasi yang kurang lebar.	P	1. Melakukan perencanaan untuk pelebaran ruangan farmasi 2. Melakukan koordinasi dengan IPSRS untuk seting tempat dan perbaikan sarpras 3. Koordinasi dengan dirut PT 4. Koordinasi dengan IT untuk penempatan jaringan internet dan komputer
		D	1. Rapat koordinasi dengan dirut PT, IPSRS, dan IT 2. Melakukan perpindahan ruang gudang farmasi dan depo farmasi
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	1. Rapat koordinasi dengan dirut PT, IPSRS dan IT 2. Perpindahan peletakan komputer, dan jaringan 3. Perpindahan depo farmasi dan Gudang farmasi pada tanggal...
2	Penyediaan obat sertim > jam 12.00 yang menyebabkan pemberian obat ke pasien menjadi terlambat	P	1. Melakukan koordinasi dengan karu irna, kasir, dirut PT untuk melakukan perbaikan spo sertim obat 2. Melakukan sosialisasi perubahan spo sertim
		D	1. Rapat koordinasi dengan karu irna, kasir, dirut PT 2. Review SPO sertim 3. Sosialisasi SPO bar uke irna, dan farmasi
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	1.

3.4.2. LABORATORIUM
Tabel Kunjungan Pasien Laboratorium 2024

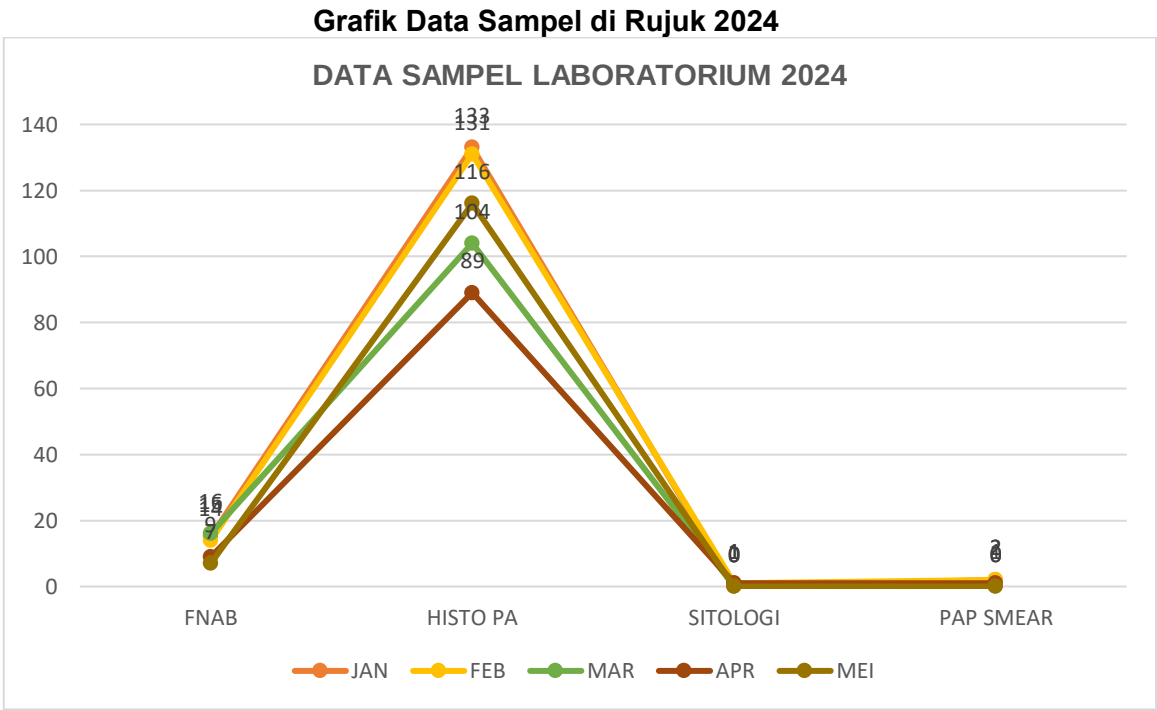
No	Jenis Pemeriksaan	Bulan					Persentase Terhadap Bulan Sebelumnya
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	
1	Hematologi	1937	2069	2417	2586	2901	↑ 10,8%
2	Faal Hemostasis	985	945	874	864	984	↑ 12,1%
3	Fungsi Hati	514	551	525	413	460	↑ 10,2%
4	Lemak Darah	361	438	352	258	343	↑ 24,7%
5	Ginjal Hipertensi	1383	1466	1520	1385	1464	↑ 5,3%
6	Gula Darah	2445	2277	2679	2449	2803	↑ 12,6%
7	Jantung	626	524	619	648	664	↑ 2,4%
8	Elektrolit	808	764	979	964	1073	↑ 10,1%
9	Imunoserologi	480	452	578	549	662	↑ 17%
10	Endokrinologi	95	72	70	111	84	↓ 32%
11	Reproduksi	39	27	34	21	43	↑ 51,1%
12	Urinalis	315	343	332	318	410	↑ 22,4%
13	Analisa Feses	26	22	11	21	30	↑ 30%
14	Tumor	6	9	6	6	7	↑ 85%
15	Mikrobiologi	11	23	5	17	7	↓ 142%
16	Rapid Covid-19	149	120	96	77	88	↑ 12,5%
17	Swab Pcr	4	0	0	0	0	Tetap
Jumlah		10341	10102	11097	10687	12023	↑ 11,11%



A. Analisa

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan terjadi peningkatan 11,11% dibanding dengan bulan mei 2024. Hal ini terjadi diakibatnya terjadi peningkatan permintaan pemeriksaan labrat dari kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap maupun MCU.

Tabel Data Sampel di Rujuk 2024							
No	Jenis Pemeriksaan	Bulan					Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	FNAB	15	14	16	9	7	61
2	HISTO PA	133	131	104	89	116	573
3	SITOLOGI	0	1	0	1	0	2
4	PAP SMEAR	2	2	0	1	0	5

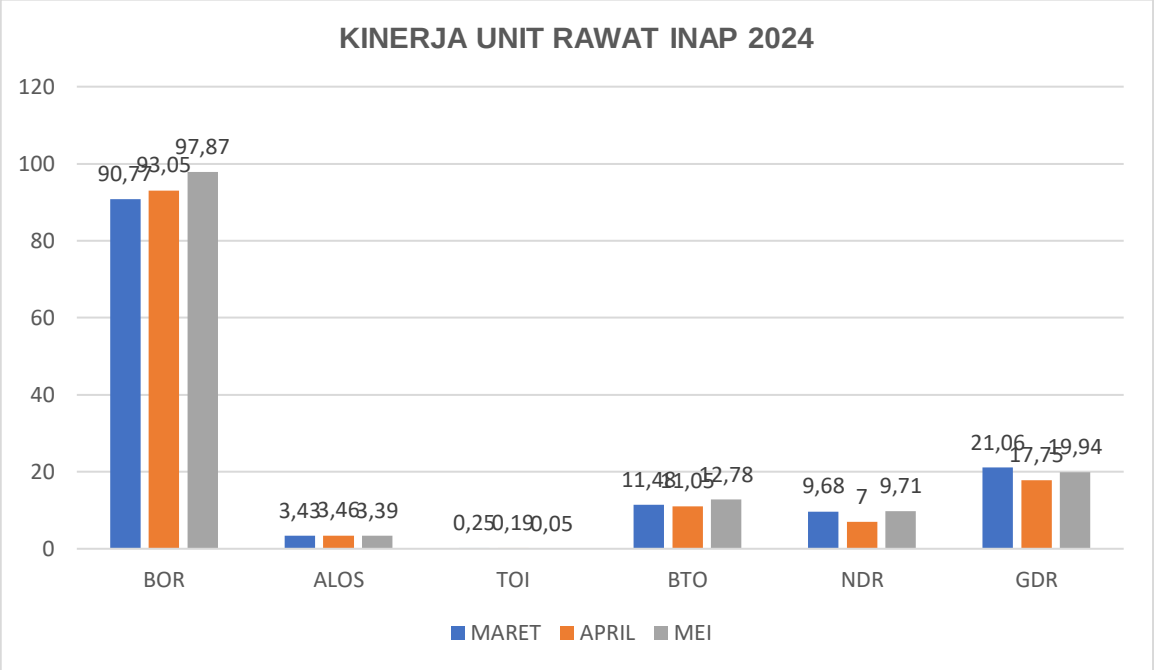


3.4.3. RM – PENDAFTARAN

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap 2024

Indikator	Bulan	Unit					Jumlah	Neo	Total
		IRNA	Mater	Iso Non Covid	ICU	NICU			
BOR	Mar	117	83	32	41	0	97.0	41	90.77
	Apr	117	90	49	49	3	99.96	40	93.05
	Mei	123	94	50	55	2	104.8	42	97.87
ALOS	Mar	4	3	3	4	0	3	3	3.43
	Apr	4	3	4	4	0	3	4	3.46
	Mei	4	3	4	3	3	3	3	3.39
TOI	Mar	0	0	3	5	0	0	3	0.25
	Apr	0	0	3	3	0	0	3	0.19
	Mei	0	0	3	2	38	0	2	0.05
BTO	Mar	14	15	6	4	0	12.1	7	11.48
	Apr	13	15	5	5	0	11.62	6	11.05
	Mei	15	17	6	6	1	13	8	12.78
NDR	Mar	7	0	0	250	0	10.32	0	9.68
	Apr	4	0	44	105	0	8	0	7
	Mei	6	0	25	163	0	10	0	9.71
GDR	Mar	16	0	37	375	0	21.87	9	21.06
	Apr	15	0	44	184	0	19	0	17.75
	Mei	11	0	51	367	0	21	0	19.94

Grafik 3.12 Kinerja Unit Rawat Inap 2024

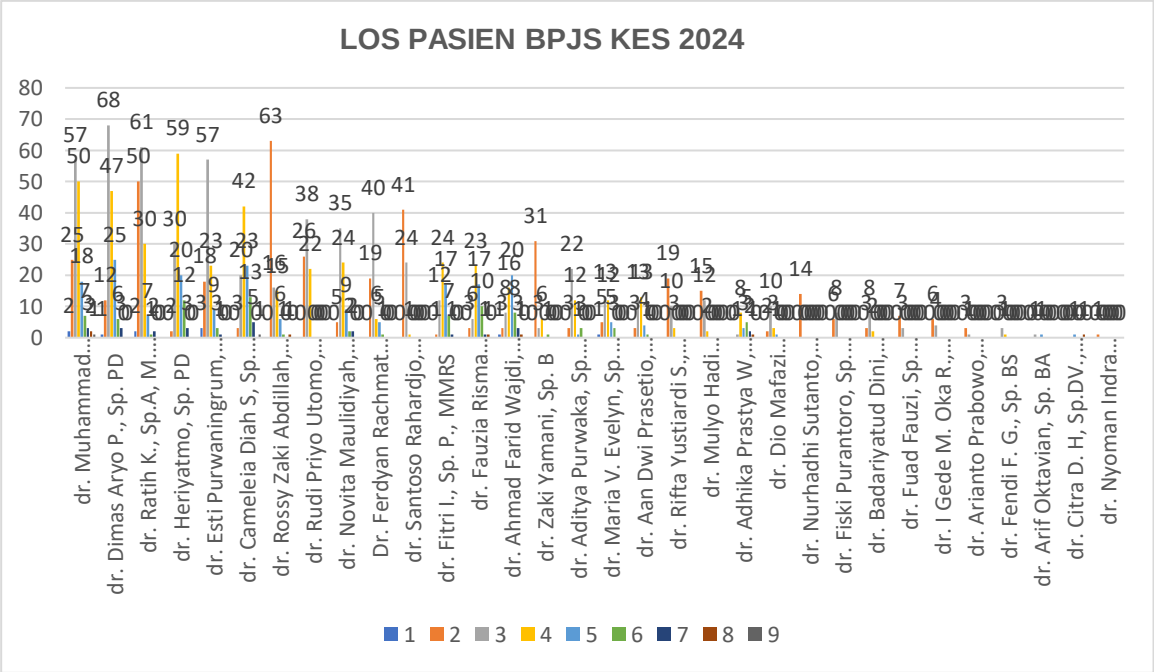


Tabel LOS Pasien BPJS Kesehatan

No	Nama DPJP	LOS (Hari)									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	dr. Muhammad Irawan, Sp. A	2	25	57	50	18	7	3	2	1	165
2	dr. Dimas Aryo P., Sp. PD	1	12	68	47	25	6	3	0	0	162
3	dr. Ratih K., Sp.A, M. Biomed	2	50	61	30	7	1	2	0	0	153
4	dr. Heriyatmo, Sp. PD	0	2	30	59	20	12	3	0	0	126
5	dr. Esti Purwaningrum, Sp. A	3	18	57	23	9	3	1	0	0	114
6	dr. Cameleia Diah S, Sp. PD	0	3	20	42	23	13	5	0	1	107
7	dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp. B	0	63	16	15	6	1	0	1	0	102
8	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG	0	26	38	22	0	0	0	0	0	86
9	dr. Novita Maulidiyah, Sp. P	0	5	35	24	9	2	2	0	0	77
10	Dr. Ferdyan Rachmat E., Sp. U	0	19	40	6	5	1	0	0	0	71
11	dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG.	0	41	24	1	0	0	0	0	0	66
12	dr. Fitri I., Sp. P., MMRS	0	1	12	24	17	7	1	0	0	62
13	dr. Fauzia Risma Rahayu, Sp. N	0	3	6	23	17	10	1	1	0	61
14	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	1	3	8	16	20	8	3	1	0	60

15	dr. Zaki Yamani, Sp. B	0	31	3	6	0	1	0	0	0	41
16	dr. Aditya Purwaka, Sp. PD	0	3	22	12	1	3	0	0	0	41
17	dr. Maria V. Evelyn, Sp. JP	1	5	13	12	5	3	0	0	0	39
18	dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp. N	0	3	13	13	4	1	0	0	0	34
19	dr. Rifta Yustiardi S., Sp. B	0	19	10	3	0	0	0	0	0	32
20	dr. Mulyo Hadi Wibowo, Sp. OG	0	15	12	2	0	0	0	0	0	29
21	dr. Adhika Prastya W, Sp. JP	0	0	1	8	3	5	2	1	0	20
22	dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp. U	0	2	10	3	1	0	0	0	0	16
23	dr. Nurhadhi Sutanto, Sp. M	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
24	dr. Fiski Purantoro, Sp. OT	0	6	8	0	0	0	0	0	0	14
25	dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE	0	3	8	2	0	0	0	0	0	13
26	dr. Fuad Fauzi, Sp. T.H.T.K.L.	0	7	3	0	0	0	0	0	0	10
27	dr. I Gede M. Oka R., Sp. OT	0	6	4	0	0	0	0	0	0	10
28	dr. Arianto Prabowo, Sp. OT	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
29	dr. Fendi F. G., Sp. BS	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
30	dr. Arif Oktavian, Sp. BA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
31	dr. Citra D. H, Sp.DV., M.Ked.Klin	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
32	dr. Nyoman Indra Bayu, Sp. M	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		10	389	584	444	192	84	26	7	2	1738

Grafik LOS Pasien BPJS Kesehatan 2024



Tabel 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Mei 2024

No	Code ICD 10	Diagnosis	Jumlah
1	E11	DM Type 2 / Noninsulin-dependent diabetes mellitus	695
2	M54.5	LBP (Low Back Pain)	480
3	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	455
4	I11	Hypertensive heart disease	437
5	I69.3	Sequelae of cerebral infarction	398
6	M17	Gonarthrosis [arthrosis of knee]	350
7	J43.9	Emphysema, unspecified	327
8	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	236
9	J06	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites (1006)	214
10	I10	Hipertensi / Essential (primary) hypertension	204

Tabel 10 Besar Penyakit Rawat Inap Mei 2024

No	Code ICD 10	Diagnosis	Jumlah
1	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	475
2	R06.0	Dyspnea	126
3	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	123
4	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	113
5	T14	Injury of unspecified body region	99

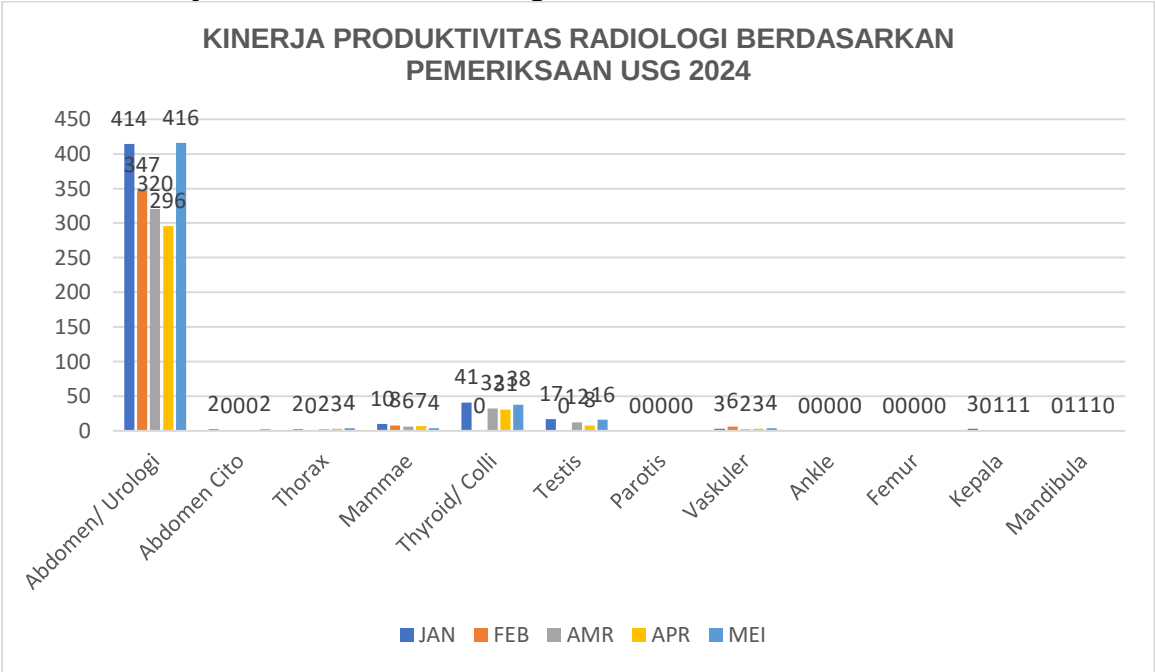
6	P03.4	Bayi Lahir dengan SC / Newborn affected by cesarean delivery	97
7	A90	Dengue Fever (DF)	96
8	A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	93
9	J18.0	Bronchopneumonia, unspecified	86
10	R11	Vomiting / Nausea and vomiting (1811)	86

3.4.4. RADIOLOGI
Tabel Kinerja Produktivitas Radiologi Berdasarkan Pemeriksaan 2024

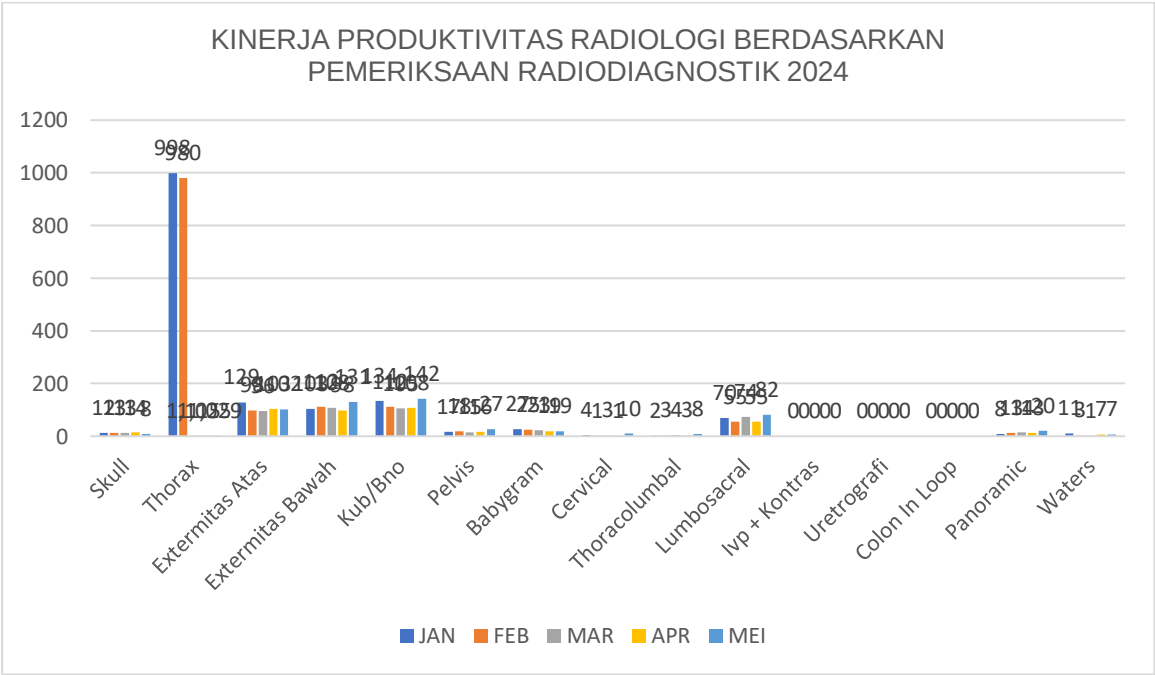
Pemeriksaan	No	Jenis Pemeriksaan	Bulan					Prosentase Dibanding Bulan Sebelumnya
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
USG	1	Abdomen/ Urologi	414	347	320	296	416	↑ 28.8%
	2	Abdomen Cito	2	0	0	0	2	↑ 100%
	3	Thorax	2	0	2	3	4	↑ 25%
	4	Mammae	10	8	6	7	4	↓ 75%
	5	Thyroid/ Colli	41	0	32	31	38	↑ 18,4%
	6	Testis	17	0	12	8	16	↑ 50%
	7	Parotis	0	0	0	0	0	Tetap
	8	Vaskuler	3	6	2	3	4	↑ 25%
	9	Ankle	0	0	0	0	0	Tetap
	10	Femur	0	0	0	0	0	Tetap
	11	Kepala	3	0	1	1	1	Tetap
	12	Mandibula	0	1	1	1	-	↓ 100%
	Total		492	362	376	350	485	↑ 27,8%
Radiodiagnostik	1	Skull	12	13	13	14	8	↓ 75%
	2	Thorax	998	980	1.115	1.025	1.029	↑ 0,38%
	3	Extermitas Atas	129	98	96	103	102	↓ 0,9%
	4	Extermitas Bawah	103	112	108	98	131	↑ 25%
	5	Kub/Bno	134	112	105	108	142	↑ 23,9%
	6	Pelvis	17	18	15	16	27	↑ 40,7%
	7	Babygram	27	25	23	19	19	Tetap
	8	Cervical	4	1	3	1	10	↑ 90%
	9	Thoracolumbal	2	3	4	3	8	↑ 62,5%
	10	Lumbosacral	70	55	74	55	82	↑ 32,9%
	11	Ivp + Kontras	0	0	0	0	0	Tetap
	12	Uretrografi	0	0	0	0	0	Tetap
	13	Colon In Loop	0	0	0	0	0	Tetap
	14	Panoramic	8	13	14	13	20	↑ 35%
	15	Waters	11	3	1	7	7	Tetap
	Total		1.515	1433	1.571	1.462	1585	↑ 7,7%
CT Scan	1	Kepala	101	57	102	106	135	↑ 21,4%
	2	Kepala Dengan Kontras	6	1	4	4	7	↑ 42,8%
	3	Kepala Trauma	30	10	42	47	37	↓ 27%
	4	Thorax	0	0	0	0	0	Tetap
	5	Thorax Dengan Kontras	0	0	0	0	2	↑ 200%
	6	Abdomen	4	0	1	1	0	↓ 100%
	7	Abdomen Dengan Kontras	1	0	0	1	3	↑ 66,6%
	8	Pelvis	0	0	0	0	0	Tetap
	9	Vertebrae	0	0	0	0	0	Tetap
	10	Cervical Vertebrae	0	0	0	0	0	Tetap
	11	Lumbosacral	0	0	0	0	0	Tetap
	12	Thoracal Vertebrae Non Kontras	0	0	0	0	0	Tetap
	13	Thorax Vertebrae	0	0	0	0	0	Tetap
	14	Cruris	0	0	0	0	2	↑ 200%
	15	Lumbosacral Vertebrae	0	0	0	0	0	Tetap

	16	Ekstermitas Lain	0	0	0	0	1	↑ 100%
Total			142	68	149	159	187	↑ 14,9%

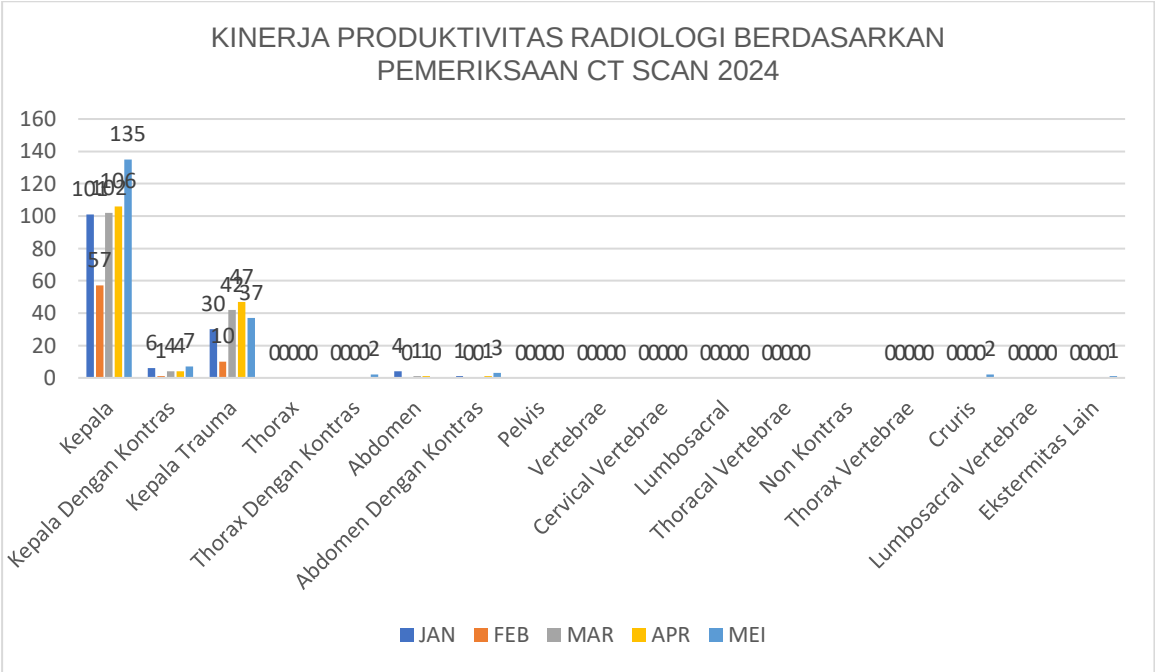
Grafik Kinerja Produktivitas Radiologi Berdasarkan Pemeriksaan USG 2024



Grafik Kinerja Produktivitas Radiologi Berdasarkan Pemeriksaan Radiodiagnostik 2024



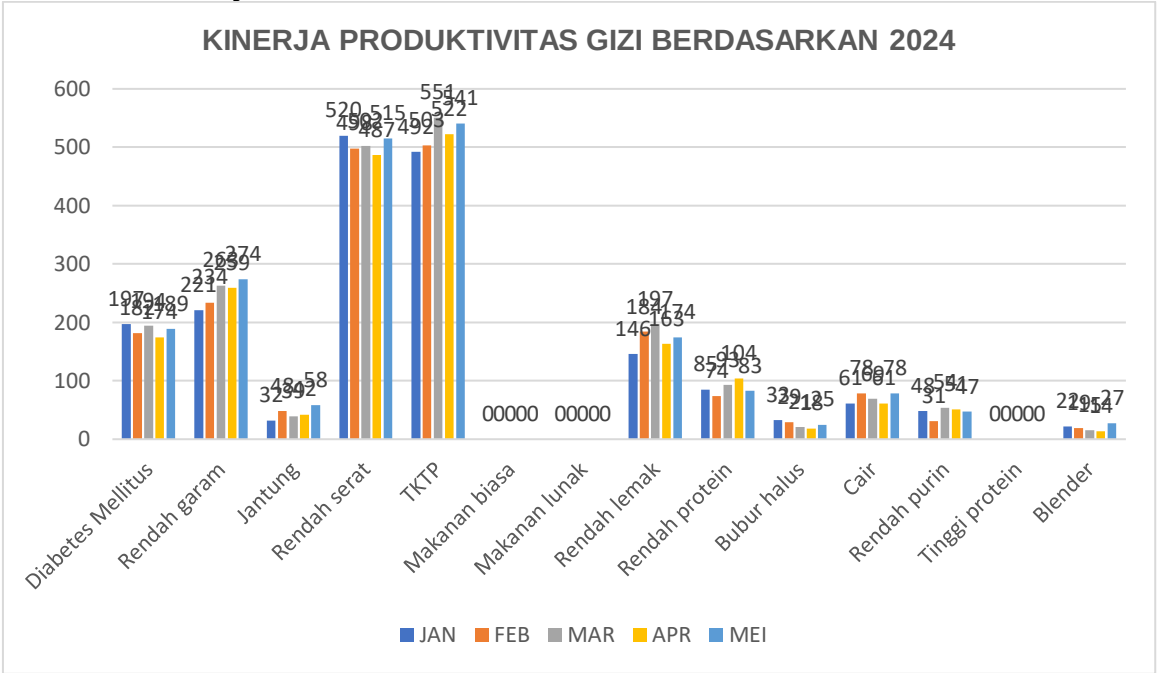
Grafik Kinerja Produktivitas Radiologi Berdasarkan Pemeriksaan CT Scan 2024



3.4.5. GIZI
Tabel Kinerja Produktivitas Gizi Berdasarkan Jenis Diit Pasien 2024

No	Nama Diit	Bulan					Persentase Dibanding Bulan Sebelumnya
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	Diabetes Mellitus	197	182	194	174	189	↑ 7,9%
2	Rendah garam	221	234	263	259	274	↑ 5,4%
3	Jantung	32	48	39	42	58	↑ 27,5%
4	Rendah serat	520	498	502	487	515	↑ 5,4%
5	TKTP	492	503	551	522	541	↑ 3,5%
6	Makanan biasa	0	0	0	0	0	Tetap
7	Makanan lunak	0	0	0	0	0	Tetap
8	Rendah lemak	146	184	197	163	174	↑ 6,3%
9	Rendah protein	85	74	93	104	83	↓ 25,3%
10	Bubur halus	33	29	21	18	25	↑ 28%
11	Cair	61	78	69	61	78	↑ 21,7%
12	Rendah purin	48	31	54	51	47	↓ 8,5%
13	Tinggi protein	0	0	0	0	0	Tetap
14	Blender	22	19	15	14	27	↑ 48%
Total		1857	1880	1998	1895	2011	↑ 5,7%

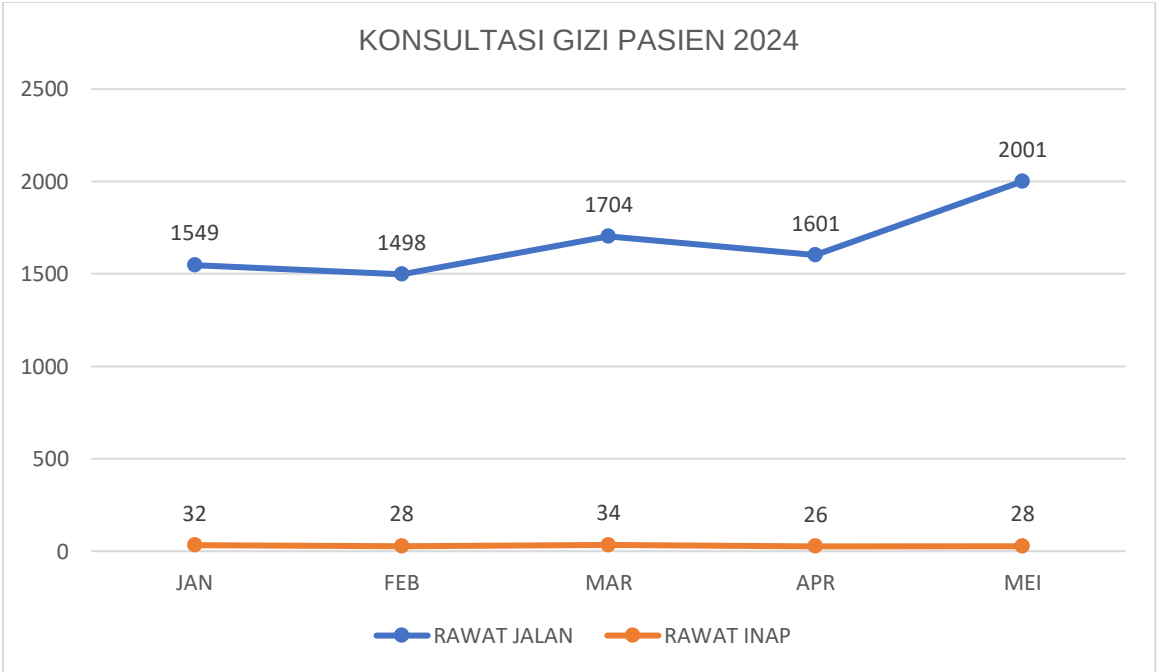
Grafik Kinerja Produktivitas Gizi Berdasarkan Jenis Diit Pasien 2024



Tabel Konsultasi Gizi Pasien 2024

No	Konsultasi Gizi	Bulan					Persentase Dibanding Bulan Sebelumnya
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	Rawat Inap	1549	1498	1704	1601	2001	↑ 19,9%
2	Rawat Jalan	32	28	34	26	28	↑ 7,1%
Jumlah		1581	1526	1738	1627	2029	↑ 19,8%

Grafik Konsultasi Gizi Pasien 2024



3.4.6. CSSD

Tabel Kinerja Produktivitas CSSD Berdasarkan Produksi Kassa Mei 2024

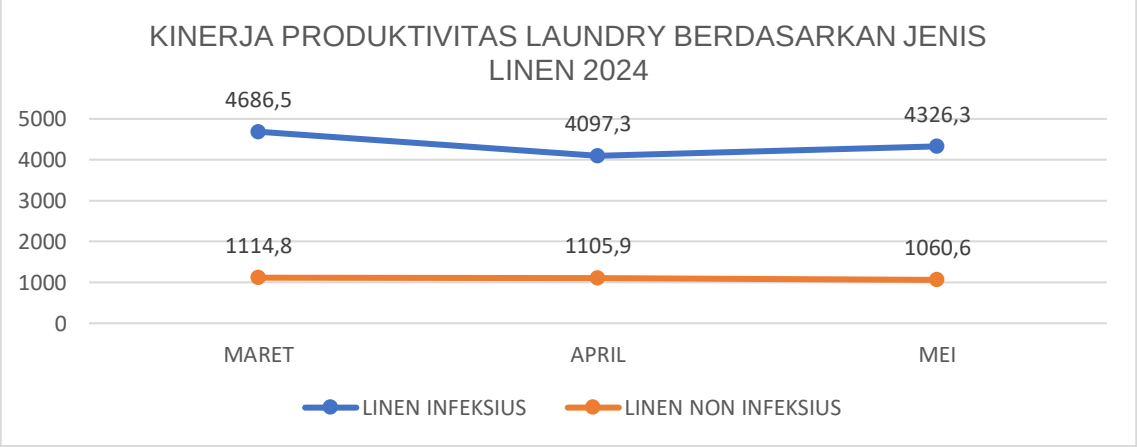
Bahan Kassa	No	Jenis Kassa	Minggu (Per Pouhces)				Total
			1	2	3	4	
BJ	1	Kassa IKO	100	100	50	120	370
	2	Kassa Deapress	60	60	50	97	267
	3	Kassa Bigkass	30	30	30	30	120
	4	Kassa Tampon Interior	10	10	10	10	40
	5	Kassa Tampon Posterior	10	10	10	10	40
Hidrofil	1	Kassa Ruangan	100	100	100	100	400

Tabel Pemakaian Reagen 2024						
Tanggal	Maret		April		Mei	
	Alkacide (mL)	Alkazyme (gram)	Alkacide (mL)	Alkazyme (gram)	Alkacide (mL)	Alkazyme (gram)
1	100	25	100	25		
2						
3					100	25
4						
5						
6						
7	100	25	100	25		
8						
9					100	25
10						
11						
12						
13						
14	100	25	100	25		
15	100	25	100	25	100	25
16						
17						
18						
19						
20	100	25	100	25	100	25
21	100	25	100	25		
22						
23						
24						
25						
26	100		100		100	25
27						
28		25		25		
29						
30	100		100			
31	100				100	25
Total	900	125	800	175	600	150
Jumlah Pasien	404		386		424	

3.4.7. LAUNDRY
Tabel Kinerja Produktivitas Laundry Berdasarkan Jenis Linen 2024

No	Jenis Linen	Bulan		
		Mar	Apr	Mei
1	Linen infeksius	4.686,5 Kg	4.097,3 Kg	4.326,3 Kg
2	Linen non infeksius	1.114,8 Kg	1.105,9 Kg	1.060,6 Kg
Jumlah		5.801,3 Kg	5.203,2Kg	5.386,9 Kg

Grafik Kinerja Produktivitas Laundry Berdasarkan Jenis Linen 2024



3.5 Kinerja Umum dan Keuangan

3.5.1 MFK dan K3RS

3.5.1.1 Laporan PJ K3

Bulan	Keikutsertaan Rapat (Total Unit / Prosentase)		Pengerjaan Laporan Bulanan (Total Unit / Prosentase)	
	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh
Januari	12 / 52.17%	11 / 47.83 %	17 / 74 %	6 / 26%
Februari	15 / 65.22%	8 / 34.78%	18 / 78.26 %	5 / 21.74
Maret	14 / 60.87%	9 / 39.13%	15 / 65.22 %	8 / 34.78 %
April	11 /47.83%	12 / 52.17%	19 / 82.61 %	4 / 17.39 %
Mei	0/100%	0/100%	18 / 78.26 %	5 / 21.74
Juni	0/ 100%	0/100%	17 / 74 %	6 / 26%
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

3.5.1.2 Perizinan Update RS

N O .	NAMA IZIN / MoU	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	642/120/424.08 6/ 2020	Selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi	
2	Ijin Operasional Rumah Sakit Yang Masih Berlaku	440/4142/424.0 72/2023	19 September 2028	
3	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Belum ada	Balasan surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 12 Juli 2018 bahwa belum ada regulasi yang disahkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan.	
4	Izin Pembuangan Air Limbah	503/660.1/IPAL/ 002/424.086/20 19	30 April 2024	Proses perpanjangan Pertek oleh Legal
5	Izin Pembangkit Listrik	566/109/PLTD/ 108.5- PSR/III/2019	Pengujian Terakhir : 1 November 2022 Exp: 1 November 2027	Hartech.Perkins 500 Kva

N O .	NAMA IZIN / MoU	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET
			(pemeriksaan dan pengujian berkala 5 tahun sekali)	
6	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian APK	094/319/424.07 6/2018 094/345/424.76 /2022	-	
7	Izin Instalasi Listrik	566/368/LISTRIK/108.5-PSN/VIII/2018	Pengujian Terakhir : 1 November 2022 Exp: 1 November 2027 (pemeriksaan dan pengujian berkala 5 tahun sekali)	Tr 220/380 V Total Daya 197 KVA Untuk tenaga (150 KVA) dan Untuk Penerangan (40 KVA)
8	Izin Pengolahan Limbah Medis Sementara (Izin Incenerator)	S.869/VPLB/PP LB3/PLB.3/11/2020	Izin sementara incenerator	Izin diberikan pada tanggal 16 November 2020 selama pandemic covid-19
9	Ijin Tempat Pembuangan Sementara Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS B-3)	660.33/001/424.086/2019	09 Januari 2024	Proses perpanjangan Rintek dengan Legal
10a	Izin Pesawat Lift Lift Penumpang (Additional)	566/1654/LIFT/108.5-PS/XI/2018	Pengujian Terakhir : 1 November 2022 Exp: 1 November 2023 (pemeriksaan dan pengujian berkala 1 tahun sekali)	Observation Elevator Pillar. 4-L. 1/L4 (4 lantai). 1350 Kg/20 Orang
10b	Izin Pesawat Lift Lift Penumpang	566/143/LIFT/108.5-PSR/IV/2019	Pengujian Terakhir : 1 November 2022 Exp: 1 November 2023 (pemeriksaan dan pengujian berkala 1 tahun sekali)	Lift Penumpang/ Pillar (4 Lantai). WYJ103-08/00592801. 5 Orang/400 Kg
11	Izin Instalasi Penyalur Petir	566/296/PETIR/108.5-PSN/VII/2018	Pengujian Terakhir: 1 November 2022 Exp: 1 November 2024	Jumlah penerima; 3 Pengukuran Grounding: 1,2 Ohm

N O .	NAMA IZIN / MoU	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET
			(Pengujian berkala 2 tahun sekali)	Down Conductor : BC 50 mm
12	Izin Lingkungan		Izin berlaku efektif setelah perusahaan memenuhi komitmen sarana dan prasarana sesuai izin lingkungan	Dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2018
13	Izin Gangguan (HO)	530.08/727/424 .077/2014	Dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin sebagaimana diktum kesatu, pemilik izin gangguan melakukan pendaftaran ulang tiap 3 tahun sekali Izin Gangguan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.	
14	Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: E011.3L6.3.350 7.GQuQ.19 Nomor Registrasi : E19113375343 7	09 Mei 2034	
15	MOU TRIPARTID PT. DPM dengan PT. TSSA dan PT. Tenang Jaya Sejahtera	No. 060.1/DPM/E- PKS/DIR/III/202 3 No.176/TSA- MOU/MD/II/202 3 No. R71/TJS/SPKIV /2023	23 Februari 2025	A337-1 A337-2 A337-3 A337-4 B337-2
16	MOU TRIPARTID PT. Disa Prima Medika dengan PT. Global Trans Jaya Mulia dan PT. Global Enviro Nusa	060.2/DPM/E- PKS/DIR/III/202 3	15 April 2026	A337-1 A337-2 A337-3 (Minimal angkut 10 kg)

N O .	NAMA IZIN / MoU	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET
17	Izin dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk ESWL dan Pesawat Sinar X-Radiografi Umum (Mobile SN. EM5A-2107015)	05818.384.3.22 0922	10 Agustus 2027	
18	Izin dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Sinar X-Radiografi Umum (Mobile SN. EM 5A-2107015)	04418.384.1.11 0822	10 Agustus 2027	
19	Izin dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile X-Ray (SN. OC25149)	097349.010.11. 290421	28 April 2024	
20	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak	555/15.0105/02 /V/2022	10 Mei 2025	
21	Perjanjian Kerjasama Antara RS Prima Husada Sukorejo dengan Karang Taruna Jombor Atas Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tentang Pengambilan Sampah Domestik	274/RSPHS/E- PKS/DIR/III/202 3	13 Maret 2025	
22	Perjanjian Kerjasama Antara PT. Disa Prima Medika dengan Sumber Rejeki Air Asli Prigen tentang Penyediaan Air Bersih Alternatif	154.41/DPM/E- PKS/DIR/XI/202 2	1 November 2027	
23	Keputusan Kepala Badan pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 01848.384.3.270223 tentang Perubahan Rekomendasi Izin Radiologi Diagnostik dan Atau Intervensional	06219.384.3.03 1022	10 Agustus 2027	CT Scan : 01848.384.3.27022 .3 ESWL : 23.1.01848.004 Pesawat Sinar x- Radiografi Umum (Mobile) : 23.1.01848.004 Pesawat Sinar-X

N O .	NAMA IZIN / MoU	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET
				Radiografi Umum (Terpasang Tetap) : 23.1.01848.004
24.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Disa Prima Medika, PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi dan PT. Andhika Makmur Persada	0175/LGL- PK/DPM-TSSA- AMP/II/2023	23 Februari 2025	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), Lampu TL, printed Circuit Board (PCB) dan kawat logam Mesin pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grift chambers, separators dan atau campuran Aki/baterai bekas Baterai bekas yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kadaluarsa Kemasa bekas b3
25.	Perjanjian Kerjasama Jasa Antara PT Natura Plastindo dengan PT Disa Prima Medika tentang Jual-Beli Limbah Non B3	No. 001/OKS- LGL/XI/2023 No. 223/ DPM/E- PKS/DIR/XI/202 3	8 November 2023 – 8 November 2024	1. Botol ex cairan infus berjenis LDPE natural 2. Jerigen HDPE warna natural 3. Botol HDPE warna non natural (pilah warna)
26.	Surat Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan 4 unit Elevator di Gedung Rumah Sakit Prima Husada	KS/PUCSBY- 1225/VII/2023	1 Juli 2023-30 Juni 2024	Biaya per bulan Rp 3.663.000/ bulan

3.5.1.3 Angka Kecelakaan Kerja Staf

Bulan	Jumlah KK	Terlaporkan	Rincian	RTL
Januari	3	1. 15 Januari 2024 (Baru terlaporkan setelah konfirmasi dari SDM dengan pemakaian BPJS TK) 2. Terlaporkan dari PPI RS 28/01/2024 3. Terlapor tanggal 01/02/2024	1. Farhan Nahdia Kamila (IRNA 2A) – 04 Januari 2023. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Randuagung sepulang shift malam, luka pada kaki kanan dan telapak kanan kiri. 2. Liliani Permata Sari (IGD) – 28/01/2024. Jari telunjuk tangan kiri setelah pengambilan sampel BGA pasien atas nama Tn. Ismugianto yang akan dilakukan penusukan pada karet dan mengenai jari staf. 3. Wahyulan Masruroh (ICU) – 30/01/2024. Ketika berkendara di prigen sebelah selatan Candi Jawi, ada motor yang tiba tiba terpeleset dan terjatuh sehingga staf tidak bisa mengendalikan diri dan terjatuh juga.	1. Pengobatan PKM Ardimulyo, total istirahat 2+3 hari = 5 hari 2. Segera cuci luka dengan air mengalir dan sabun, keluarkan darah dari luka dan tutup kassa steril, jangan menghisap dari mulut. Perawatan luka dengan rawat jalan 3. Rawat Jalan Bidan Delima dan rujuk di RSPHS
Februari	1	Terlaporkan via wa tanggal 04/02/2024	1. Bella Fitra M, S.Kep.,NS (IRNA 2A) 04/02/2024- Staf	1. Diberi ARV sebulan dan dilakukan pengecekan

Bulan	Jumlah KK	Terlaporkan	Rincian	RTL
			tertusuk jarum pasien B12.	anti HIV dan HbsAg
Maret	2	1. Terlaporkan pada tanggal 16 Maret 2024 2. Terlaporkan pada 29 Maret 2024	1. Syaifudin (Security) 15/03/2024 – Staf mengalami rem blong di area dekat loket karcis pintu masuk 2. Risca Sarifah Nur Fauziah (Pendaftaran) 27/03/2024 -KLL sepulang kerja di Jalan Raya Sengon	1. Perawatan luka di IGD 2. Perawat luka di IGD
April	3	1. Terlaporkan 5 April 2024 2. Terlaporkan 5 April 2024 3. Terlaporkan 09 April 2024	1. Rofi'atal Manzilah (SDM) 04/04/2024 staf mengalami KLL dikarenakan jalanan licin dan ada pengendara lain yang memotong jalan tanpa lampu sein. 2. Pada saat rujuk pada 04/04/2024, 3 orang staf yang bernama Aslah Fortuna (IRNA 2B); Livia Thea (IRNA 2B) dan Nasicin (Driver) mengalami kecelakaan di Tol Pandaan karena melaju terlalu kencang dan menabrak bahu Tengah jalan hingga mobil berputar sekaligus kondisi jalan yang licin karena hujan deras pada saat rujuk 3. Nurul Karima (IGD)	1. Perawatan luka mandiri di BPM Marfu'ah Prigen 2. Pemeriksaan di IGD karena tidak ada luka terbuka, namun Aslah mengalami pusing karena kepala terbentur kaca ambulance dan masih gemeteran H+1 setelah kecelakaan. 3. Dikelolah oleh Komite PPI

Bulan	Jumlah KK	Terlaporkan	Rincian	RTL
			09/04/2024 mengalami tertusuk jarum pada saat post injeksi diviti pasien Tn, Imron dan akan menutup jarum tetapi jarum mengenai jempol tangan kiri	
Mei	2	1. Terlaporkan 17 Mei 2024 via WA 2. Terlaporkan pada 27 Mei 2024 Terlaporkan 30 Mei 2024 via WA	1. Putri Aliviah Kurniawati (Neonatologi) 17/05/2024 mengalami terjatuh di perumahan taman dayu menghindari lubang dan terperosok di aspal, terluka di kedua siku dan lutut. 2. Wike Indriana (IRNA 2B) 27/05/2024 ditanrak ketika menyebrang di pogar bangil Daniel Pradana Putra (IRNA 3A) 28/05/2024 mengalami KLL di Jalan Raya Lawang di sebelah pasien dan menyenggol staf hingga terjatuh dan tertimpa motor.	1. Membawa korban ke IGD RSPHS 2. Membawa ke RSUD Bangil Membawa korban ke IGD IGD RSPHS
Juni	1	1. Terlaporkan 07 Juni 2024	Selly Marcelia (IRJA) 06/06/2024 mengalami terkilir kaki di poli	Pengobatan mandiri ke IRJA RSPHS
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

3.5.1.4 Data Limbah di Rumah Sakit

Bulan/ 2023	Limbah Infeksius (Kg)	Limbah Infus (Kg) Total bruto	Limbah Benda Tajam (Kg)	Limbah Domestik (Kg)	Sludge IPAL (Kg)	Jumlah Limbah yang Diambil Vendor (Kg)	Jumlah Pasien IRNA (Orang)	Jumlah Pasien IRJA (Orang)	BOR / Jumlah TT	Rata- Rata LB3/ pasien IRNA (Kg)	Data Penyusutan Limbah (Kg)	Efisiensi Bruto (Rp) Jumlah limbah Infus dan Data Susut
Januari	2046.5	1549	505	6049	117	2700	1555	11138	76.21 / 136	2.63	95	17.936.500
Februari	2060	1486.5	535	5978	63	2433.5	1508	11208	81.81 / 136	2.70	92.5	19.027.000
Maret	2192.5	1875	638	6923	124	2798	1714	12119	90.77 / 136	2.82	120.5	21.672.500
April	2089	1822.5	606	7170	89	2867	1627	11653	93.05 / 136	2.83	83	21.736.250
Mei	2322.5	2002	623	7440	20	2764	1819	12100	97.87 / 136	2.65	145.5	23.862.500
Juni	2067.5	1551.5	528.5	7135	105 Farmasi Kadaluarsa = 6 Kg	2579	1615	12227	83.40 / 136	2.63	107	17.770.750
Juli												
Agustus												
September												
Oktober												
November												
Desember												
Total 1 th 2023												
Total 1 th 2022												

Bulan/ 2023	Limbah Infeksius (Kg)	Limbah Infus (Kg) Total bruto	Limbah Benda Tajam (Kg)	Limbah Domestik (Kg)	Sludge IPAL (Kg)	Jumlah Limbah yang Diambil Vendor (Kg)	Jumlah Pasien IRNA (Orang)	Jumlah Pasien IRJA (Orang)	BOR / Jumlah TT	Rata- Rata LB3/ pasien IRNA (Kg)	Data Penyusutan Limbah (Kg)	Efisiensi Bruto (Rp) Jumlah limbah Infus dan Data Susut
Rata-Rata Per Bulan												
Rata-Rata Per Hari												

Catatan :

- Total Limbah yang dihasilkan 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 =
Limbah Infeksius 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = 2212 Kg
Limbah Infus 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = 2002 kg – 78.5 = 1669 Kg
Limbah Safety box 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = 623 kg – 27 kg = 568.5 Kg
Limbah Sludge IPAL 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = 105 Kg
Limbah Farmasi Kadalursa 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = 6 Kg
Total Semua Limbah Infeksius 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 (kecuali limbah non domestik) = 4560.5 Kg
- Total Limbah B3 yang diambil oleh vendor 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = **2784.5 kg**
- Selisih antara Limbah Infeksius yang diambil oleh vendor dan total stok = 4560.5 – 2784.5 = 1776 kg**
- Total Limbah Infus 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024: 1669 kg
- Penyusutan limbah B3 yang diambil vendor 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = 1776-1669 = 107 kg
- Total Limbah penyusutan dan yang dikelola sendiri : 107 + 1669 kg = 1776 Kg
- Estimasi harga limbah B3/kg : Rp 7.500,-
- Efisiensi biaya Juni 2024 (PHS): Rp 7.500 X 1551.5 kg = **Rp 11.636.250**
- Limbah PHM yang dikelola di Bulan Juni 2024 = 787 Kg
- Efisiensi biaya Juni 2024 (PHM): Rp 7.500 X 787 kg = **Rp 5.902.500**
- Hasil cacahan yang dihasilkan di bulan Juli 2024:
 - PHS : 17 Kg
 - PHM : 12 Kg
 - Estimasi harga cacahan infus : Rp 8.000/Kg

-
- d. Efisiensi biaya : $29 \text{ Kg} \times \text{Rp } 8000 = \text{Rp } 232.000$
12. Efisiensi Total Bulan Juli 2024 : $\text{Rp } 11.636.250 + \text{Rp } 5.902.500 + \text{Rp } 232.000 = \text{Rp } 17.770.750$
13. Estimasi Pembayaran ke vendor 31 Mei 2024 – 01 Juli 2024 = $\text{Rp } 2784.5 \times \text{Rp } 7500 = \text{Rp } 20.883.750$
14. Limbah Infeksius Juli 2024 = $2067.5 + 1551.5 + 528.5 + 105 + 6 = 4258.5 \text{ kg/bulan}$: pasien ranap = $4258.5 : 1615 = 2.63 \text{ kg/pasien}$

3.5.1.5 Data Perbaikan dan Pemeliharaan Alkes

Bulan	Jumlah Alkes	Jumlah Pemeliharaan Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentase	Jumlah Kalibrasi Alkes /Prosentase	Jumlah Recall Alkes	Keterangan
Januari	305	112/ 36.72%	9/ 2.95%	267/ 87.5%	0	-
Februari	314	110/ 35.03%	10 / 3.18%	267/ 85.03%	0	Penambahan Alkes : Suction Pump, ENT Chair, Pasien Monitor (3); ENT treatment Unit ; Laringoskope (3)
Maret	317	183 / 57.72 %	6 / 1.89%	267/ 84.23%	0	Penambahan 3 unit Alkes :
						Patient Monitor (3A-2 unit) Nebulizer (3B-1 unit)
April	318	234 / 73.58 %	8 / 2.15 %	267/ 84.23%	0	Mikroskop Lab
Mei	328	102 / 31.09 %	4 / 1.22 %	267/ 84.23%	0	Infuse Pump (5 buah) Patient Monitor (2 buah) Suction Pump (2 buah) USG (1 buah)
Juni	334	88 / 26.35 %	7 / 2.10%	267/ 84.23%	0	Infus Pump Maternitas (1 buah) Pasien Monitor IGD (4 buah) ECG IRNA 3B (1 buah)
Juli						
Agustus						
September						
Oktober						
November						
Desember						

3.5.1.6 Pengaduan Sarana By Billing IPSRS

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
Januari	86	65.12% / 56	34.88% / 30	0	Ac = 25 Lampu =14 Alkes =3 Dispenser = 3 Handrail=3 Pengelasan=3 Bel pasien=1 Kipas = 1 TV= 1 Water Heater = 1 Baterai =1
Februari	91	68.13% / 62	31.87 %/ 29	0	AC = 29 Lampu = 9 Alkes= 8 Handrail = 6 Closedoor= 5 Kulkas = 2 Exhause = 1 Dispenser = 1 Mesin Cuci = 1
Maret	47	78.72%/ 37	19.15% / 9	2.13% / 1	Ac = 16 Bed = 6 Alkes = 4 Mesin Cuci =1 Heater = 1 Kursi = 1 Lampu = 5 Meja = 1 TV = 1 Pengereng tangan = 1
April	73	65.75 % / 48	31.51 % / 23	2.74 % / 2	AC = 28 Lampu = 6 Alkes = 3 Kulkas = 4 Mesin cuci = 1 Speaker =1 Kursi = 2 Dispenser = 1 Bel pasien = 1 TV =1

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
Mei	97	78.35%/ 76	21.65% /21	0% / 0	AC = 42 Lampu = 13 Kursi = 1 Air = 3 Alkes = 3 Mekanik/Roda/Kursi/ Troli = 5 Bel= 1 Dispenser = 3 Handrail = 2 Mesin Cuci =1 Tanda/Symbol =1 Exhause =1 Tukang = 21
Juni	80	56.25%/45	43.75%/ 35	0% / 0	AC = 25 Lampu =7 Alkes = 4 Roda dan Troli = 4 Bed = 1 Exhause =1 TV =1 Bell = 1 Dispenser =1
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					

3.5.1.7 Data Staf Medical Check Up Staf

Bulan	Jumlah Staf	Total Staf yang di MCU	Total Staf yang Belum MCU	Keterangan
Januari	0	0	457	0
Februari	0	0	487	0
Maret	0	0	491	0
April	0	0	446	0
Mei	448	30 / 6.70%	418 / 93.30 %	0
Juni	438	54 /	384 / 87.67%	0

Bulan	Jumlah Staf	Total Staf yang di MCU	Total Staf yang Belum MCU	Keterangan
		12.33%		
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

3.5.2 Security

A. Angka Kepatuhan Pemakaian NameTag Pengunjung

Bulan	Jumlah yang Diamati	Jumlah Patuh	Jumlah Tidak Patuh	Keterangan
Januari	640 / 100%	522/ 81.57%	118 / 18.43%	-
Februari	512 / 100%	457/ 89.25%	55 / 10.75%	-
Maret	620 / 100%	562/ 90.64%	58 / 9.36 %	-
April	600 / 100%	509 / 84.83%	91 / 15.17%	-
Mei	620 / 100%	545/ 87.90 %	75 /12.10 %	-
Juni	600 / 100%	537 / 89.5%	63/ 10.5%	-
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total				
Rata-Rata				

B. Angka Kehilangan

Bulan	Angka Pengrusakan	Angka Kehilangan	Angka Kekerasan	Keterangan
Januari	0	5	0	4 kehilangan helm dan 1 kehilangan tas tukang
Februari	0	1	0	1 kehilangan helm
Maret	0	1	0	Helm dicuri pada saat sholat tarawih dengan parkir motor depan IPAL tanggal 13 Maret 2024

Bulan	Angka Pengrusakan	Angka Kehilangan	Angka Kekerasan	Keterangan
April	0	1	0	Keteledoran menaruh helm di motor milik orang lain
Mei	0	0	0	-
Juni	0	3	0	1. Tanggal 3 Jun 2024 - Pasien poli kehilangan 1 hp disekitar poli karena tertinggal dan ditemukan orang serta dikembalikan 2. Tanggal 8 Jun 2024 - Pasien kehilangan 2 hp saat tidur jam 4 dini hari di area 2A Tanggal 21 Juni 2024- Pasien poli sholat ashar di masjid kehilangan celana, dompet dan kunci motor diambil orang
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

C. Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok

No	Temuan	Bulan						Tindak Lanjut
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1	Orang Merokok	176	100	145	266	278	241	Menegur di lokasi dan sosialisasi di kantin
2	Ruangan Khusus Merokok	0	0	0	0	0	0	
3	Tanda KTR	22	22	22	22	22	22	
4	Tercium Bau Rokok	0	11	0	0	0	0	

5	Asap dan Korek Api	0	0	0	0	0	0	
6	Putung Rokok	274	165	138	216	168	232	
7	Promosi Rokok	0	0	0	0	0	0	
8	Penjual Rokok	0	0	0	0	0	0	

3.5.3 Humas Marketing

A. Pencapaian kinerja PKS tahun 2024

No	Bulan	Target	Jumlah						
			Masih Berlaku	ED	IKS Lama	Baru	Kurang baru	Pro gres	Kurang Lama
1	April	5 PKS	90		89	4	1	3	
2	Mei	5 PKS	90		90	3	2	3	
3	Juni	5 PKS	95		90	5	0	5	
Analisis ; - Pada bulan Juni, MOU baru dengan instansi lain masih dalam progress, diantaranya : APT PLN Persero, PT lyondellbasell, PT Nestle gempol, PT Asuransi Zurich, BNNK - MOU masih dalam tahap revisi RTL : Meriview Kembali terkait MOU serta pemantauan terkait progress IKS untuk fayankes									

Tabel Progres IKS Baru di RSPHS Pada Bulan Juni Tahun 2024

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT IST	Proses TTD	
2	PT Asuransi Admedika	Proses Revisi	
3	PT Taspen	Proses Revisi	
4	PT Cheiljedang	Proses Review	
5.	PT Duta Beton Mandiri	Kirim draf MOU	
6.	PT STG Pandaan	Kirim draf MOU	
7.	PT Indo Aneka Atsiri	Kirim draf MOU	
8.	Satelit Agar-agar	Kirim draf MOU	

B. Pencapaian Hasil Kinerja MCU Bulan Mei 2024

No	Bulan	Jumlah Pasien	Review
1	April	540	Analisis : Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up sedikit meningkat
2	Mei	104	
3	Juni	146	
			Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan - Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan - Mempromosikan program MCU - Mereview tarif/biaya pemeriksaan - Meningkatkan pelayanan MCU

No	Bulan	Jumlah Pasien	Review
			Do 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain 3. Memperbaiki alur pelayanan MCU Study 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU 2. Perusahaan memilih harga MCU paling murah diantara vendor 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. 4. Peningkatan pelayanan MCU mempengaruhi loyalitas perusahaan Action 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan 2. Memperbaiki alur pelayanan MCU dengan membuat SPO 3. Mereview ulasan kepuasan terkait pelayanan MCU

C. Evaluasi Peningkatan Pasien Lama dan Baru

Tabel jumlah kunjungan pasien Bulan Juni

No	Bulan	Jumlah Pasien				
		Rawat Inap	Rawat Jalan	IGD	Rata Px RI per hari	Rata Px RJ per hari
1	April	1599	10143	1510	53,3	338,1
2	Mei	1889	12100	1637	60,9	390,3
3	Juni	1615	10841	1386	53,8	407,56
Analisis : Berdasarkan data diatas 1. Kunjungan IRNA terbanyak di Bulan Juni 2024 adalah spesialis penyakit dalam sejumlah 390 pasien diikuti dengan spesialis anak sejumlah 377 pasien. 2. Kunjungan pasien rawat jalan di bulan juni turun 12,59% dari kunjungan bulan sebelumnya. Review hasil kunjungan pasien. Plan 1. Melakukan promosi kepada faskes pertama,Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik Mandiri dan instansi Perusahaan. 2. Membuat digital marketing kolaborasi dengan Tim PKRS 3. Melakukan marketing internal kepada pasien, keluarga pasien dengan metode penyuluhan kesehatan berbasis promosi Do						

1. Meningkatkan kinerja Humas Marketing ke FKTP, BPM/DPM, dan instansi Perusahaan dalam mempromosikan dan melayani para perujuk. 2. Melakukan digital marketing kolaborasi dengan Tim PKRS 3. Kolaborasi dengan kepala bidang terkait dalam pengkondisian DPJP, pelayanan, dan fasilitas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.
Study 1. Keterlambatan DPJP dalam melakukan praktek akan mempengaruhi kinerja pelayanan di Rumah Sakit. 2. Ketidakhadiran dokter di Rumah Sakit akan mempengaruhi jumlah kunjungan pasien. 3. Pelayanan yang kurang baik akan memunculkan komplain dari pasien.
Action 1. Perbaikan pelayanan di IGD dan rawat inap a. Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg IGD b. Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg Perujuk c. Meminta Umpan Balik dari perujuk atas Pelayanan yang telah diterima d. Meningkatkan Komunikasi -Koordinasi antara Humas dg Perusahaan

3.5.4 Penjaminan

3.5.4.1 Tabel Data Klaim Pending

BULAN	KLAIM PENDING RJ	BERKAS KLAIM RJ	KLAIM PENDING RI	BERKAS KLAIM RI	KET
Jan-24	7/9552	9552	57/1376	1376	tunggu FPK
Feb-24	15/8503	8503	31/1323	1323	sudah diajukan
Mar-24	85/9124	9124	32/1544	1544	sudah diajukan
Apr-24	40/8604	8604	99/1439	1439	proses pengerjaan
May-24	34/10434	10434	114/1649	1649	
Jun-24		9331		1429	

3.5.4.2 Analisa Klaim Pending

Berdasarkan data table diatas, dapat dianalisa terjadinya klaim pending karena :

1. Reseleksi diagnosa utama sesuai dengan resource terbanyak
2. Berkas klaim tidak tidak terlampir pada link pengiriman dokumen
3. Kasus adhesiolisis dilakukan secara tajam atau secara tumpul
4. Kasus pneumonia dengan LOS <7hr tidak sesuai kriteria wasin
5. Perawatan pasien dengan LOS 1hr indikasi dilakukan rawat inap
6. Kasus ISK dimana nilai leukosit pada urin harus >10lbp
7. Hypokalemi yang tidak dilakukan pemeriksaan ulang nilai kliumnya
8. Indikasi pterigyum dilakukan di rawat inap

3.5.4.3 Rencana Tindak Lanjut Klaim Pending

1. Koordinasi dengan DPJP terkait dengan resorce terabanyak pasien selama perawatan
2. pengirimkan dokumen kembali dan untuk selanjutnya pengiriman berkas dilakukan melalui hardisk atau flesdisk

- kasus adhesiolisis yang dilakukan secara tajam dengan menggunakan couter dan mess sudah tertulis pada lembar operasi
- koordinasi dengan DPJP terkait dengan kriteria pneumonia sesuai dengan audit wasin
- koordinasi dengan DPJP untuk dilakukan pemeriksaan kembali pada kasus hyponatrium, hipokalemia
- koordinasi dengan DPJP

3.5.5. PIPP – MOD – MPP

3.5.5.1. Angka Komplain Pasien

No	Unit	Jumlah Pengaduan	Ket
1.	IKO	1	
2.	IRNA 3A	2	
3.	IRJA	4	
4.	PERINATOLOGI	1	
5.	SECURITY	1	
6.	IRNA 2B	1	
7.	IRNA 3B	1	
Total		11	

3.5.5.2. Data Kepuasan Pasien

Berdasarkan data kepuasan pasien pada Juni 2024, didapatkan bahwa dari 131 pengaduan terdapat 116 pasein yang puas dengan pelayanan RSPHS (88.55%) dan 15 pengaduan (11.45%) dan yang tidak puas dengan pelayanan pasien, meliputi :

No	Unit	Jumlah Pengaduan
1.	Gizi	2
2.	Security	1
3.	Cantolan Kamar Mandi	2
4.	IGD / IRNA 3A	1
5.	Kasur terlalu Tipis (CS)	1
6.	Wifi dalam Ruangan (IT)	1
7.	IGD	2
8.	DPJP	1
9.	AC rusak (IPSRS)	1
10.	Farmasi	1
11.	DPJP Ortho	1
12.	Lampu Taman	1
TOTAL		15

3.5.6. Pengadaan Umum

Laporan Bulan Juni

3.5.7. Parkir

3.5.7.1. Angka Pendapatan Parkir Tahun 2024

Bulan	Total (Rp)	Pajak (Rp)
-------	------------	------------

Juni	140.304.000	1.327.000
Juli	113.065.000	1.071.900
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

Pada Bulan Juni 2024 terdapat pendapatan parkir sebesar
Rp 140.304.000,-.

3.5.7.2. Pengembangan Parkir

Tidak ada pengembangan layanan di parkir

3.5.7.3. Kendala dan Hambatan

Terdapat beberapa kendala terkait sarana diparkir yaitu:

- 1. Akses pohon di area parkir waktunya perapian
- 2. Banyak batako yang perlu perbaikan di area parkir
- 3. Banyak karyawan yang memarkir motor di area pengunjung
- 4. Ada 2 spot lampu taman yang mati
- 5. Pintu masuk motor otomatisasinya sering eror

3.5.8. Verifikator

Angka Kepatuhan Penyetoran Berkas ke Verif

Bulan	Indikator	IRNA 2A	IRNA 2B	IRNA 3A	IRNA 3B	Mater	Perina	ICU	IGD
Mei 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	6.65 %	17.53 %	2.01 %	5.43%	0%	0%	2.70%	0%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	1.61 %	0.90 %	1.61%	1.81%	1.60%	0%	0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	1.38%	1.35%	0%	2.90%	0%	4.07%	27.03%	3.70%
Juni 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)	4.03%	21.59%	1.67%	4.12%	1.89%	1.10%	15.00%	6.25%
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)	2.02%	2.57%	2.51%	1.23%	0%	1.10%	5.0%	0%
	Berkas yang telat disetorkan (%)	2.31%	2.57%	0.42%	0.82%	0.63%	10.99%	30.0%	6.25%
Juli 2024	Ketidaklengkapan Resume (%)								
	Ketidaklengkapan Penunjang (%)								
	Berkas yang telat disetorkan (%)								

Hasil tindaklanjut terkait data kepatuhan penyetoran berkas ke verifikator yaitu berkoordinasi dengan Kabid Pelayanan Medis terkait angka kepatuhan dari kepatuhan penyetoran berkas untuk penunjang klain baik ke BPJS maupun kepada pihak Asuransi

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Bulan Juni Tahun 2024.

Tabel Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit	≥80%
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	≥80%
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	≥80%
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	≥76.61%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

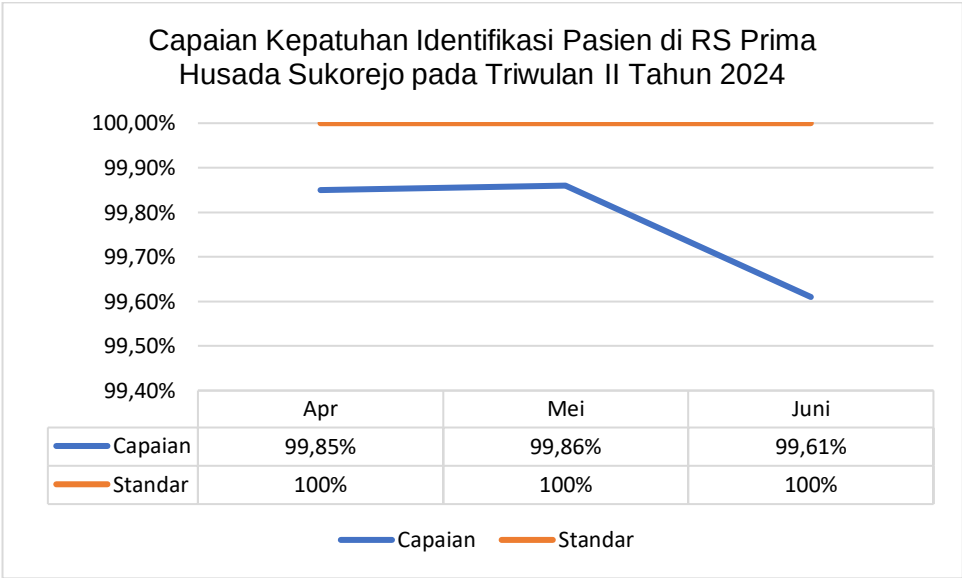
Tabel Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo pada Bulan Juni Tahun 2024

No	Judul Indikator	Bulan			Std	Rata-rata	Ket
		Apr	Mei	Jun			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,85%	99,86%	99,61%	100%	99,77%	Tidak Tercapai
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit	100%	97,37%	90,91%	≥80%	96,09%	Tercapai
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	50,43%	63,46%	65,22%	≥80%	59,70%	Tidak Tercapai
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	0,68%	0%	1.27%	≤5%	0,34%	Tercapai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,27%	71,09%	71,32%	≥80%	71,23%	Tidak tercapai
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100,00%	Tercapai
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100,00%	Tercapai
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	73,23%	67,79%	78,3%	≥85%	73,11%	Tidak tercapai
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	97,76%	96,39%	97,26%	100%	97,14%	Tidak tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	72%	67,03%	90,45%	≥80%	76,49%	Tercapai

1	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	80,19%	80,61%	96,18%	≥ 76.61%	85,66%	Tercapai
2	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100,00%	Tercapai
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96,37%	90,09%	90,88%	100%	92,45%	Tidak tercapai

Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

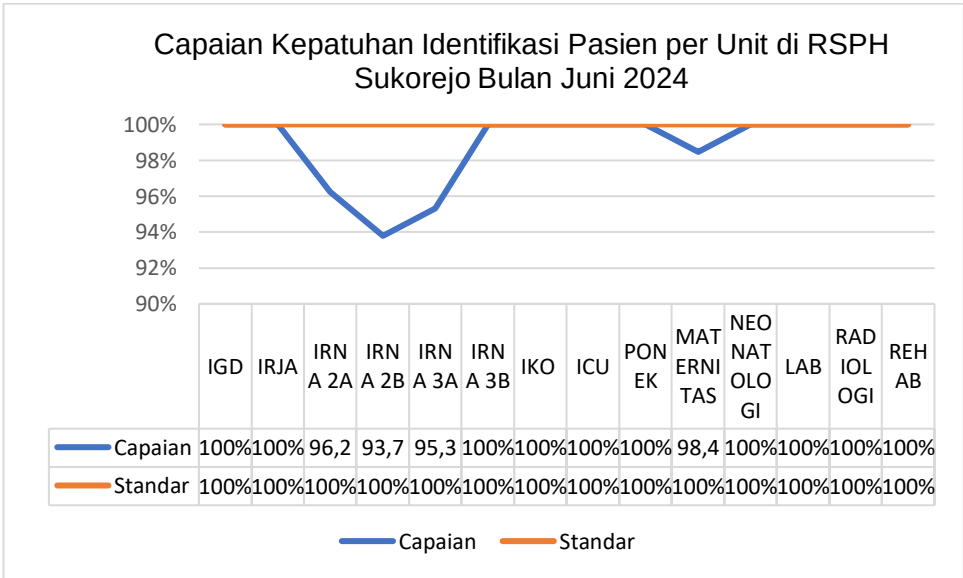
1. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien di RS. Prima Husada Sukorejo pada bulan Juni Tahun 2024 mencapai 99.61%. Data ini diambil dari 5428 pasien yang diobservasi pada 14 unit, ditemukan 5407 pasien yang dilakukan tindakan identifikasi pasien secara tepat dan 21 pasien tidak dilakukan identifikasi dengan tepat. Dibawah ini merupakan capaian kepatuhan identifikasi pasien per unit Bulan Juni 2024 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien per unit di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan terdapat 4 unit kepatuhan identifikasi pasien yang tidak mencapai standar yakni Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A) sebesar 96,25%,

Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B) sebesar 93,79%, Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) sebesar 95,33% dan di Maternitas sebesar 98,46%. Adapun di Instalasi Rawat Inap 2A dari 80 pasien yang di observasi ditemukan 3 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja. Adapun di Instalasi Rawat Inap 2B dari 145 pasien yang di observasi ditemukan 8 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar, yaitu tidak diidentifikasi secara visual (melihat gelang identitas pasien) tetapi dilakukan secara lisan saja. Adapun di Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) dari 150 pasien yang di observasi ditemukan 7 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja. Adapun di Maternitas dari 130 pasien di observasi ditemukan 2 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 99,61% dan belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : Merubah kebiasaan individu agar selalu patuh terhadap identifikasi pasien Harapan : Petugas yang namanya masuk dalam kategori tidak patuh dapat dilakukan pemantauan kepatuhan saat identifikasi ke pasien. Tindakan : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Koordinasi dengan kabid keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh d. Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 2. Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian Bulan Juni yakni 99,61% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien belum mencapai standar 100%. Terdapat 4 unit yang belum patuh terhadap kepatuhan identifikasi pasien yakni Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A) sebesar 96,25%, Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B) sebesar 93,79%, Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) sebesar 95,33% dan di Maternitas sebesar 98,46%. Ini dikarenakan masih ditemukan: a. Instalasi Rawat Inap 2A: Terdapat 3 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian : 1) 3 petugas yang tidak melakukan identifikasi secara visual pada pemberian pengobatan 2) Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: a) Intania Cahya Andini, A.Md.Kep (2 kali) b) Nanda Daeng Pamungkas, A.Md.Kep (1 kali) b. Instalasi Rawat Inap 2B Terdapat 9 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian: 1) 9 petugas yang tidak melakukan identifikasi secara visual pada pemberian pengobatan 2) Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: a) Tatan Lestari, S.Kep., Ns (1 kali) b) M. Ragil Zuli Walady.,Amd.Kep (2 kali) c) Aslah Fortuna Ramadhan, AMd. Kep (1 kali) d) Wike Indriana, S.Kep.,Ns (1 kali) e) Windy Silegar Maelani, S. Kep., Ns (1 kali) f) Ayu Widayanti, S.Kep., Ns (1 kali) g) Aryan Budi Purnomo, A.Md.Kep (1 kali) h) Vella Octavianita., Amd Kep (1 kali) c. Instalasi Rawat Inap 3A Terdapat 7 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian:

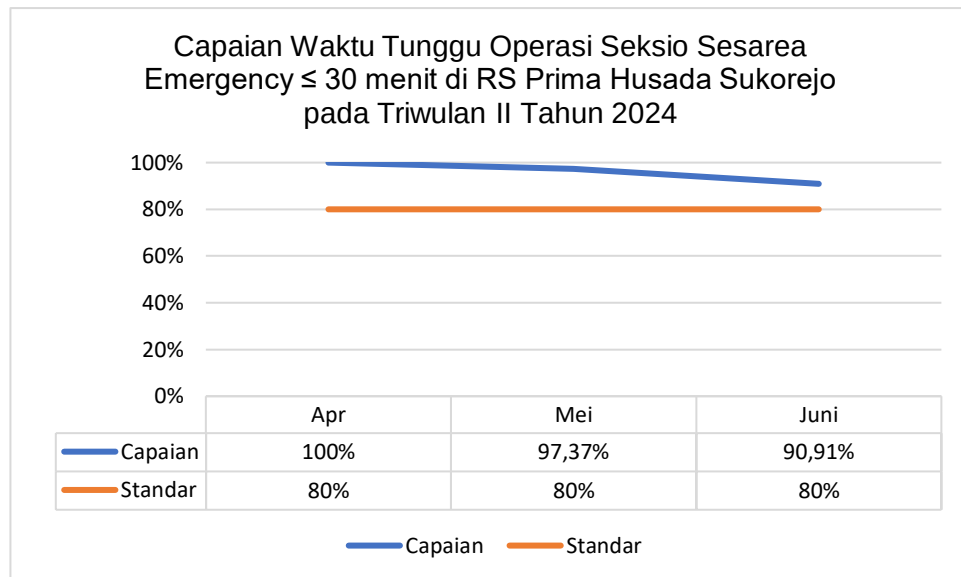
	1) 7 petugas yang tidak melakukan identifikasi secara visual pada pemberian pengobatan 2) Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: a) Rica Octavianingrum, S.Kep., Ns (2 kali) b) Dhisma Fitri Rahmadhani Amd. Kep (2 kali) c) Dwi Putri Yulianti, S.Tr.Kep.Ns (1 kali) d) Istiqfarin Nurayunda, A.Md.Kep (1 kali) e) Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep (1 kali) d) Maternitas: Terdapat 2 petugas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian : 1) 2 petugas tidak idenfikasi secara visual hanya lisan saja petugas pada saat prosedur tindakan. 2) Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: a) Yulia Noer Rohmah, S.Tr., Keb (1 kali) b) Novita Wulansari, A.Md.Keb (1 kali)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Juni tahun 2024 mencapai 99,61%, masih ditemukan beberapa petugas di unit IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A & Maternitas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien 2. Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 3. Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM. 4. Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani oleh staf yang bersangkutan 5. Rapat Mutu dengan karu 6. Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu 7. Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik 8. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Kepala Ruangan	Satu bulan
2	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Ka. Ruangan, Tim SKP, Kabid Keperawatan, SDM dan Mutu	Satu bulan
3	Memberikan	Merubah	Staff yang	Catatan	SDM	Satu

	catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM.	kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Khusus staff yang tidak patuh		bulan
4	Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani staf yang bersangkutan	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Pencatatan staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan Unit Masing-Masing	Satu bulan
5	Rapat Mutu dengan Kepala Ruangan	Melakukan evaluasi terhadap kinerja system manajemen mutu	Kepala ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Satu bulan 1 kali
6	Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu	Mutu Unit dapat terkontrol secara berkelanjutan dan masalah terkait mutu dapat segera di tindaklanjuti	Seluruh staff di Unit	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan di setiap Unit	Satu bulan
7	Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik	Staff yang bertugas paham terkait pembelajaran yang disampaikan	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala ruang kepada timnya terkait pembelajaran	Kepala Ruangan	Satu bulan
8	Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.	Kepala Ruang dapat mengetahui setiap petugas unit yang patuh terhadap identifikasi pasien	Seluruh staff di Unit	Supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang dan mencatat staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan	Satu bulan

2. Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit

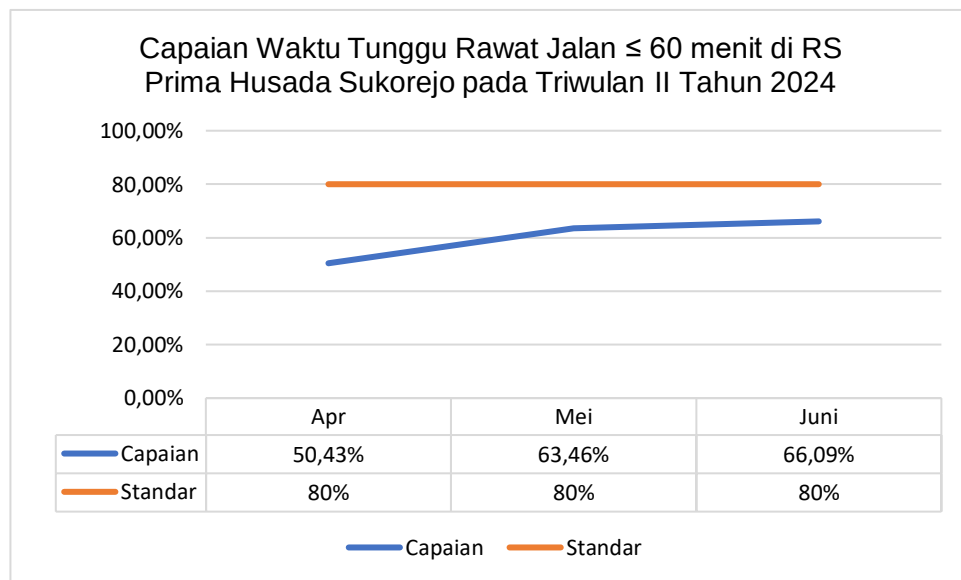


Gambar 3.3. Capaian Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tunggu operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit pada bulan Juni 2024 telah mencapai standar yakni 90,91% Dari 11 Pasien Operasi Seksio Sesarea Emergency, 10 pasien yang menunggu kurang dari 30 menit. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

3. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.4. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, waktu tunggu rawat jalan mengalami peningkatan pada bulan Juni 2024 yakni 66,09% dibandingkan dengan bulan Mei 2024. Capaian hasil Bulan Juni 2024, dari 115 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 39 pasien yang harus menunggu lebih dari 60 menit yaitu dengan rata-rata 99 menit (1 jam 39 menit). Berikut merupakan jumlah pasien yang menunggu lebih dari 60 menit sampai dilayani oleh dokter diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.5. Jumlah Pasien yang menunggu lebih dari 60 menit dari pendaftaran sampai dilayani oleh dokter pada Bulan Juni Tahun 2024.

No	Poli	Nama Dokter Poli	Tanggal	Jumlah Pasien	
				Menunggu > 60 menit	Di Poli

1	Poli Syaraf	dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	20 Juni 2024	2	14
		dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	05 Juni 2024	5	40
			08 Juni 2024	3	29
		dr. Fauzia Risma Rahayu, Sp.N	25 Juni 2024	2	50
2	Poli Jiwa	dr. Andika Widiyanti, Sp.K.J	26 Juni 2024	1	17
		dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ.	15 Juni 2024	4	22
			22 Juni 2024	4	11
3	Poli Penyakit Dalam	dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	28 Juni 2024	2	4
			29 Juni 2024	2	4
		dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	11 Juni 2024	1	24
			24 Juni 2024	2	28
			27 Juni 2024	1	34
4	Poli Mata	dr. Nyoman Indra Bayu, Sp.M	06 Juni 2024	2	9
5	Poli Urologi	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	03 Juni 2024	1	29
			13 Juni 2024	3	15
6	Poli Bedah	dr. Rosy Zaki Abdillah, Sp.B	14 Juni 2024	4	23
TOTAL				39	

Tabel 3.6 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Bulan Juni Tahun 2024

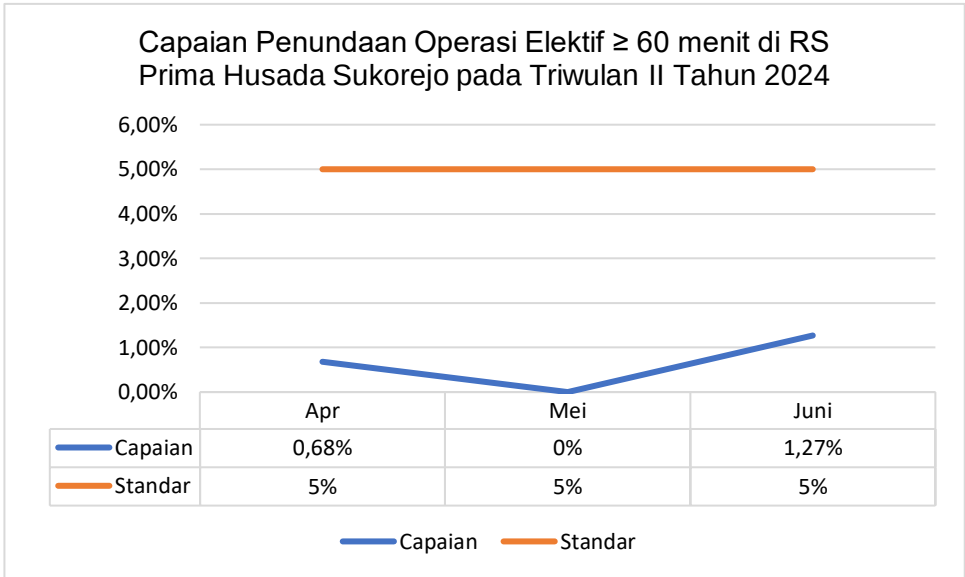
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 66,09%, belum mencapai target 80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan pasien
Plan	Rencana : Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien Harapan : Semua pasien mendapatkan pelayanan dokter kurang dari 60 menit Tindakan : a. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Waktu pasien rawat jalan yang didaftarkan di tempat pendaftaran sampai dilakukan pemeriksaan oleh dokter
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian bulan Juni yakni 66,09%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target ≥ 80%. Dari 115 pasien yang diobservasi ditemukan 39 pasien yang menunggu lebih dari 60 menit dengan rata-rata 99 menit (1 jam 39 menit). Ini dikarenakan: a. Banyaknya jumlah kunjungan pasien tiap harinya b. Adanya pasien yang daftar di ruang pendaftaran 1 jam sebelum jadwal poli
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian bulan Juni yakni 66,09%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target ≥ 80%. Ilow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien 2. Monev khusus progress tiap minggu

Tabel 3.7 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

1	Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Satu bulan
2	Monitoring dan evaluasi terkait waktu tunggu rawat jalan pasien	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Supervisi yang dilakukan oleh Komite Mutu	Komite Mutu	Satu bulan

4. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

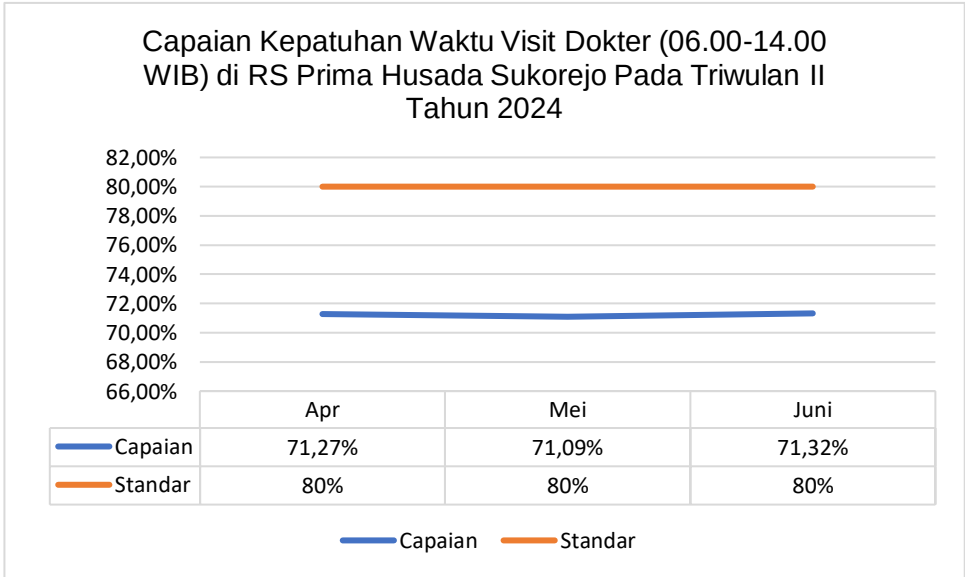


Gambar 3.5. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Juni yakni 1,27% dan mencapai standar kurang dari 5%.

5. Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)



Gambar 3.6. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap pada Bulan Juni 2024 mencapai 71,32%. Capaian tersebut belum mencapai standar $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 767 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 167 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan sebanyak 53 pasien yang tidak di visite oleh dokter.

Tabel 3.8. Jumlah Pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 WIB dan Pasien yang tidak tervisit dokter pada Bulan Juni 2024 Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

No	Nama Dokter Poli	Jumlah Pasien yang divisite >14.00 WIB	Jumlah Pasien yang Tidak Tervisite
1	dr. Aditya Purwaka, SP.PD	18	0
2	dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	9	6
3	dr. Adhika Prastya Wikananda,Sp.JP	3	1
4	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	5	5
5	dr. Arif Oktavian, Sp.BA	3	0
	dr. Arianto Prabowo, Sp. OT	0	2
6	dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K)	1	1
6	dr. Cameleia Diah Setyorini,Sp.PD	36	3
7	dr. Citra Dwi Harningtyas, Sp.DV., M.Ked.Klin	1	0
8	dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	1	0
9	dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U	2	1
10	dr. Esti Purwaningrum, Sp,A	4	1
11	dr. Fauzia Risma Rahayu, Sp.N	11	1
12	dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS	2	0
13	dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	2	1
14	dr. Ferdyan Rachmat Efendi,Sp.U	5	3
15	dr. Fitri Indahyanti, Sp.P, MMRS	6	1
16	dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L	1	0
17	dr. Heriyatmo, Sp. PD	4	2
18	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT.	1	1
19	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	13	7
20	dr. Muhammad Irawan,Sp.A	15	0
22	dr. Novita Maulidiyah,Sp.P	6	0
23	dr. Nurhadhi Sutanto, Sp. M	1	1
24	dr. Ratih Kusumawardani,Sp.A., M.Biomed	8	2
25	dr. Rifta Yustiardi sudjoko,Sp.B	2	0
26	dr. Rosy Zaki Abdillah,Sp.B	0	6
27	dr. Rudi Priyo Utomo,Sp.OG	2	0
28	dr. Zaki Yamani, Sp.B	5	8
Total		167	53

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB) pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 71,32%, belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu visite dokter kepada pasien rawat inap Harapan : Semua pasien rawat inap dapat tervisite oleh dokter Tindakan : a. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan komite medik b. Pemaparan jumlah dokter yang visite lebih dari jam 14.00 WIB
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kesesuaian waktu visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian Bulan Juni yakni 71,32% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 767 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 167 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan 53 pasien yang tidak di visite oleh dokter. Ini dikarenakan:

	a. Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB b. Pasien masuk ke ruang ICU pada malam hari, sehingga visit dilakukan oleh dokter jaga dan di visit oleh DPJP di kemudian hari c. Adapun nama-nama dokter yang tidak melakukan visit ke pasien dan digantikan oleh Dokter Jaga adalah sebagai berikut: 1) dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N (6 kali) 2) dr. Adhika Prastya Wikananda, Sp.JP (1 kali) 3) dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N (5 kali) 4) dr. Arianto Prabowo, Sp. OT (2 kali) 5) dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K) (1 kali) 6) dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD (3 kali) 7) dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U (1 kali) 8) dr. Esti Purwaningrum, Sp,A (1 kali) 9) dr. Fauzia Risma Rahayu, Sp.N (1 kali) 10) dr. Fiski Purantoro, Sp.OT (1 kali) 11) dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U (3 kali) 12) dr. Fitri Indahyanti, Sp.P, MMRS (1 kali) 13) dr. Heriyatmo, Sp. PD (2 kali) 14) dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT. (1 kali) 15) dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP (7 kali) 16) dr. Nurhadhi Sutanto, Sp. M (1 kali) 17) dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed (2 kali) 18) dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B (6 kali) 19) dr. Zaki Yamani, Sp.B (8 kali)
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Dasarkan capaian pada bulan Juni yakni 71,32% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 844 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 167 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan 53 pasien yang tidak di visite oleh dokter. How-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik terkait kepatuhan waktu visit dokter konfirmasi ke dokter jaga. 2. Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite IRNA, jam Operasi adakah yg beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain 3. Merekrut Home doctor

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik untuk mengingatkan visit ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan komite medik	komite medik	Satu bulan
2	Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Irna, jam Operasi adakah yang beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain.	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan Dokter, Sekretaris Komite Medik, Kabid Pelayanan	Sekretaris Komite Medik, Kabid Pelayanan	Satu bulan
3	Merekrut Home Dokter	Semua pasien rawat inap dapat tervisite	Home Dokter	Koordinasi dengan SDM terkait dokter yang tidak bisa visit	SDM	Satu bulan

6. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit



Gambar 3.7. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada bulan Juni 2024 yakni 100% sesuai standar. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

7. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

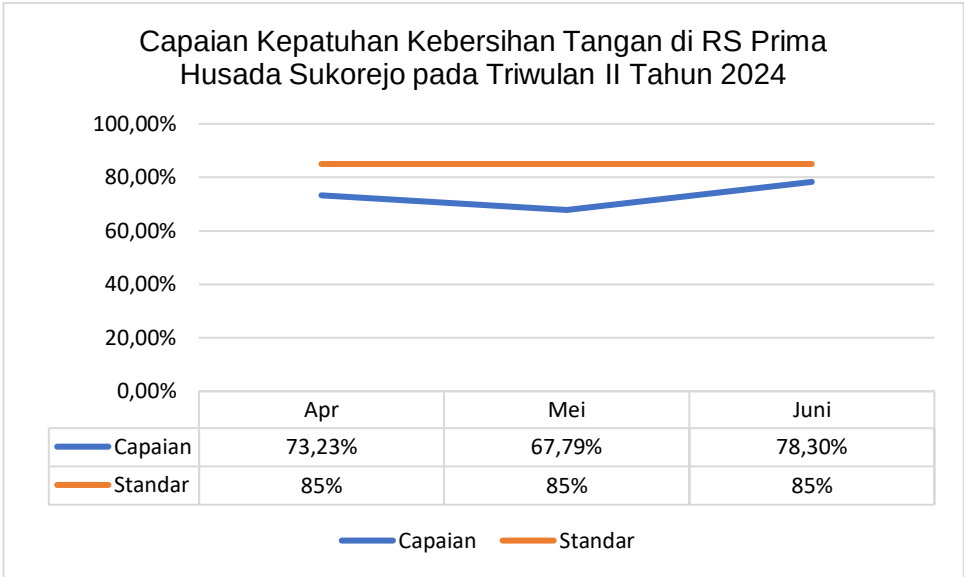


Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mulai Bulan Januari sampai Bulan Juni Tahun 2024 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan persepsan obat hanya dari Formularium Nasional.

8. Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas



Gambar 3.9. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan Juni belum mencapai $\geq 85\%$, yaitu 78,30 %. Dari 14 unit yang di observasi masih ditemukan 8 unit yang capaiannya < 85% yakni IRNA 3B 78%, IRNA 2A 71%, IRNA 2B 79%, ICU 74%, IKO 59%, IRJA 60%, Farmasi 73%, Radiologi 70%.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Kepatuhan Kebersihan tangan petugas pada Bulan Juni Tahun 2024

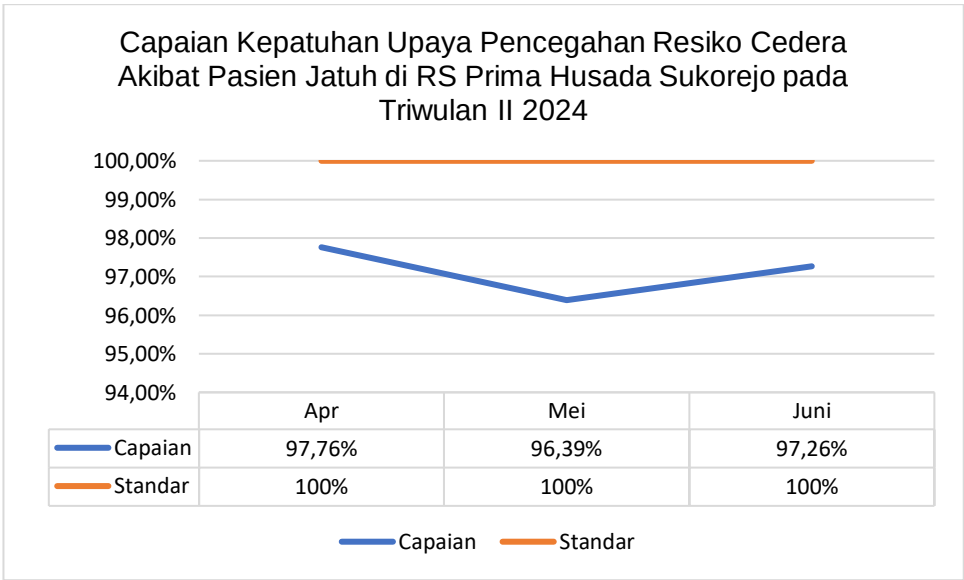
Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan Juni Tahun 2024 kurang dari 85% yakni 78,30%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kebersihan tangan pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kebersihan tangan c. Koordinasi dengan PJ PPI di unit untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.
Do	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen yaitu: 1. Sebelum kontak dengan pasien 2. Sebelum tindakan aseptic 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien 4. Setelah kontak dengan pasien 5. Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan kebersihan tangan Bulan Juni mencapai 78,30% yang belum mencapai standar 85%. Ini disebabkan dari 3285 petugas yang melakukan kebersihan tangan selama 1 bulan, 2572 petugas yang patuh dan mempraktekan teknik 6 langkah dan 5 momen yang sesuai. 2. Rata-rata kepatuhan kebersihan tangan terendah di unit IKO yakni 59% 3. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan kebersihan tangan sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.

Action	1. Kolaborasi antara Komite PPI dan kabid keperawatan terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 2. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 3. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 4. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 5. Pemberian proses pembelajaran
---------------	---

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM terkait petugas yang tidak patuh dalam upaya kebersihan tangan	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama petugas medis	Rapat rutin antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Satu bulan
2	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Komite PPI	Satu bulan

9. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Juni tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1678 pasien yang di observasi ditemukan 46 petugas yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Berikut merupakan petugas yang tidak patuh dalam resiko jatuh yakni:

Table 3.13. Nama Petugas yang Tidak Patuh dalam Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh

No	Unit	Nama Petugas	Jumlah Ketidakpatuhan	Alasan
1	IRJA	Vira Agustin Sintia Putri, A.Md.Kep	3	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Firdhausi Nuzula., Amd Kep	1	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Iin Nur Khasanah, Amd. Kep	4	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Indah Wulan Suci, A.Md.Kep	7	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Istighosah, A.Md.Kep	1	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Miati, Amd. Kep.	2	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Rezza Anggela Santoso., Skep.Ns	5	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Shara Wahyuni., Amd Kep	2	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Selvia Leli Agus Anika., S. Kep. Ns	1	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
2	Maternitas	Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Al Alief Banat Amanda, S.Tr.Keb	2	Tidak terpasang handrail
		Novita Wulansari, A.Md.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Nurul Almi Samsu Amd.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Julya Marsa, S.Tr.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Lailatur Rofiqo, S.Tr.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Futuhatul Hidayah, S.Keb.Bd	2	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
3	IRNA 2A	Novita Febri Setiyani, S.Kep., Ns	1	Tidak Terpasang Handrail
4	IRNA 3A	Dewi Wijayanti, Amd. Kep	1	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
		Dimas Kurniansyah, S.Kep.Ns	2	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Yuana Pubosetiwati, S. Kep. Ns	2	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi

	Daniel Pradana Putra, S.Kep., Ns	2	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
	Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep	1	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
	Leni Narulita, S.Kep., Ns	1	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.,Ns	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
TOTAL		46	

Tabel 3.14 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Juni Tahun 2024

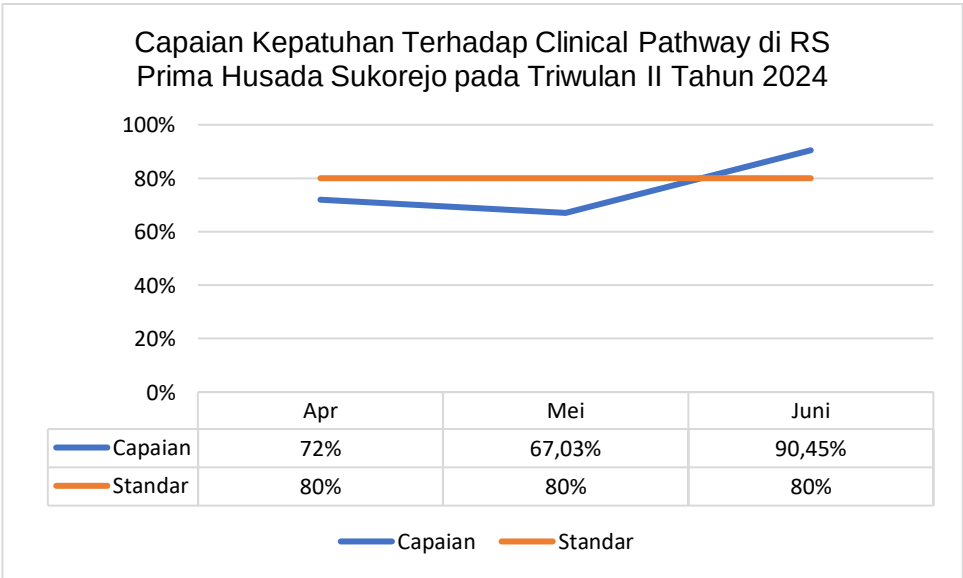
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Harapan : Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien cedera akibat pasien jatuh dapat tercapai 100% Tindakan : koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal pasien - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap - Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh dalam melakukan skrinning awal maupun intervensi pada pasien yang berisiko jatuh sesuai RM seperti hand rail tidak terpasang dan tanda resiko jatuh di bed tidak terpasang.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Juni tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1678 pasien yang di observasi ditemukan 46 petugas yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko pasien jatuh. - Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. - Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Ilow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.15 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya	Koordinasi dengan kepala ruang Unit, Kepala	kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan,	Satu Bulan

	Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Bidang Keperawatan, SDM	SDM	
2	Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruangan, Komite Mutu	Satu Bulan

10. Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway



Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

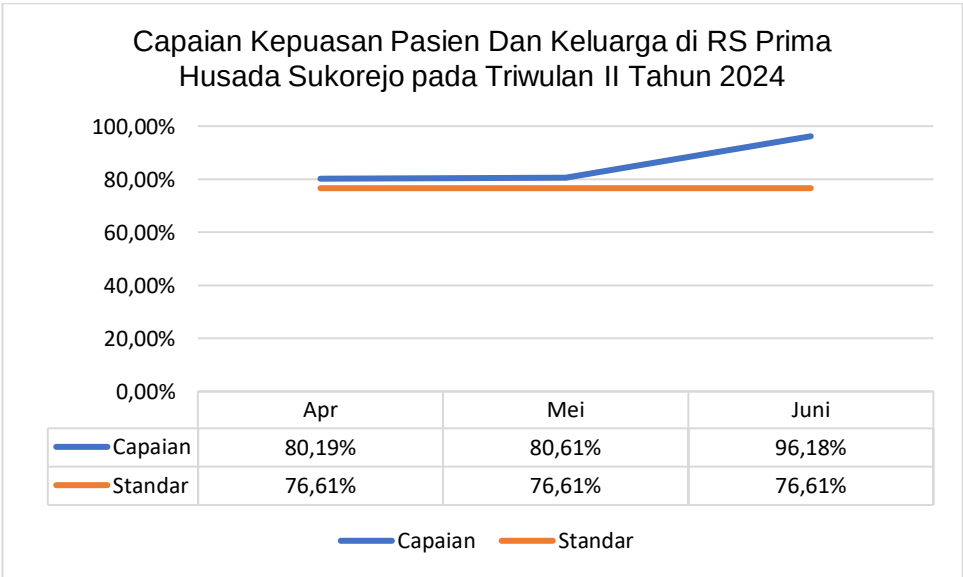
Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juni capaian kepatuhan terhadap clinical pathway di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 90,45%, angka tersebut belum mencapai target 80%. Dari 220 pelayanan yang dilakukan oleh PPA pada pasien yang penyakitnya berada dalam batasan clinical pathway, terdapat 21 pelayanan yang tidak sesuai dengan clinical pathway. Adapun ketidaksesuaian ada pada pemberian obat dan LOS (*Length of Stay*) atau lama perawatan di Rumah Sakit.

Tabel 3.16. PDSA Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan terhadap Clinical Pathway pada Bulan Juni yaitu 90,45%, angka tersebut tidak mencapai standar 80%.
Step	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap clinical pathway di RS Prima Husada Sukorejo. 2. Harapan: Seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) patuh terhadap clinical pathway yang disepakati. 3. Tindakan: a) Koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) mengenai pengisian form CP b) Koordinasi dengan Komite Medik, Kabid Kepelayanan dan Kabid Keperawatan mengenai PPA yang tidak patuh dalam CP c) Memaparkan hasil evaluasi <i>Clinical Pathway</i> dalam rapat dengan Komite Medik
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? Clinical pathway dilihat dari kesesuaian pengisian form CP yang telah disepakati.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata hasil capaian kepatuhan terhadap clinical pathway pada Bulan Juni Tahun 2024 yakni 90,45%, angka tersebut belum mencapai standar 80%. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian lama perawatan (LOS) di RS dan ketidaksesuaian obat yang diberikan.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian terhadap clinical pathway pada Bulan Juni Tahun 2024 yakni 90,45% angka tersebut belum mencapai target 80%. Dari 220 pelayanan yang dilakukan oleh PPA ditemukan 21 pelayanan yang tidak sesuai. Ilow-up dan Rencana Lanjutan 1. Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.

11. Kepuasan Pasien dan Keluarga

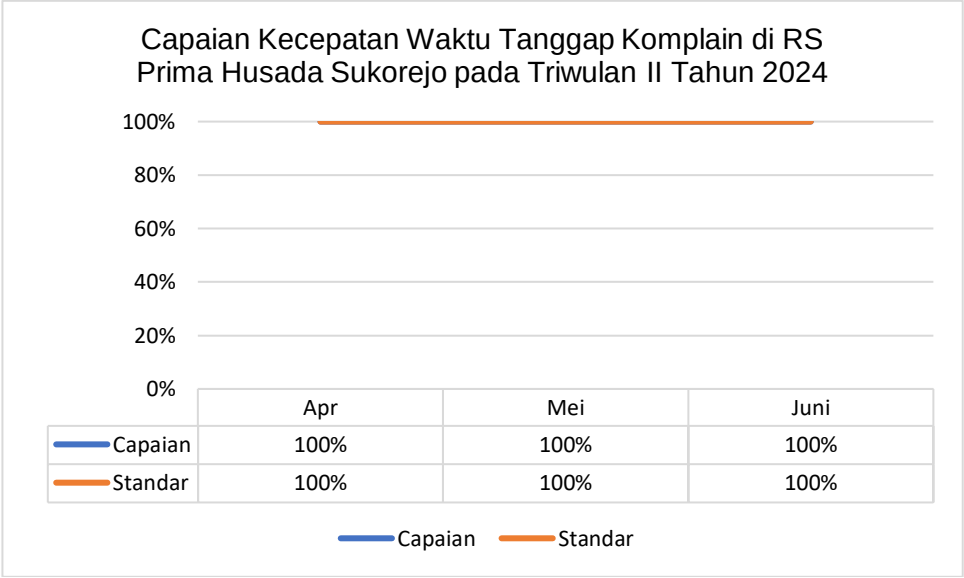


Gambar 3.12. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Juni 2024 sudah mencapai standar yakni 96,18%. Capaian Bulan Juni meningkat dibanding pada Bulan Mei yakni 80,61%.

12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

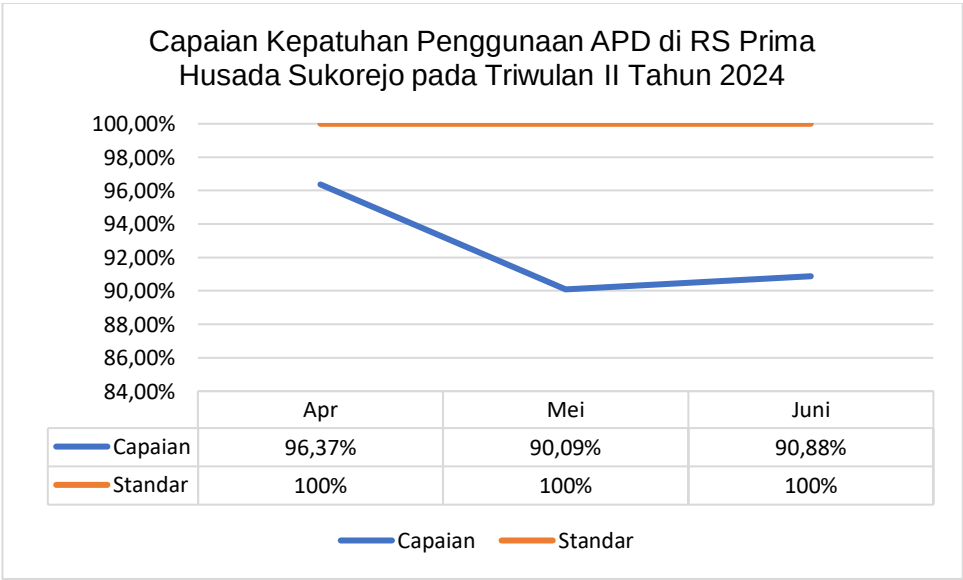


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada bulan Januari sampai bulan Juni 2024 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.14. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian :

Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Juni 2024 adalah 90,88%. Dari 18 unit yang di observasi masih ditemukan 9 unit yang angka capaiannya belum 100% yakni IRNA 3A 93%, IRNA 3B 97%, IRNA 2B 87%, Laboratorium 50%, Radiologi 93%, Gizi & Dapur 57%, Laundry 80%, B3 93% & CS 80%.

Tabel 3.17 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Juni yaitu 90,88%, angka tersebut tidak mencapai standar 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD oleh petugas di RS Prima Husada Sukorejo 2. Harapan: Seluruh staf pelayanan patuh dalam penggunaan APD sehingga target kepatuhan dapat dicapai 3. Tindakan a) Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD c) Koordinasi dengan Komite PPI untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD Bulan Juni mencapai 90,88% yang belum mencapai standar 100%. Ini disebabkan dari 570 petugas yang diobservasi selama 1 bulan, 518 petugas yang patuh dalam penggunaan APD sesuai dengan standar. 2. Rata-rata unit dengan capaian terendah dalam penggunaan APD yakni Unit Laboratorium yakni 50% dimana petugas ditemukan tidak menggunakan Gown di Area Sampling.
Action	1. Review dan evaluasi penggunaan APD pada staf. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Kolaborasi dengan komite PPI untuk monitoring penggunaan APD di unit. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 5. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Tabel 3.18 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Komite PPI	Satu bulan
2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Komite PPI	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebutuhan penggunaan APD	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Komite PPI dan komite keperawatan	Satu bulan

4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi	Komite PPI	Satu bulan
---	---	---	---	-------------------------	------------	------------

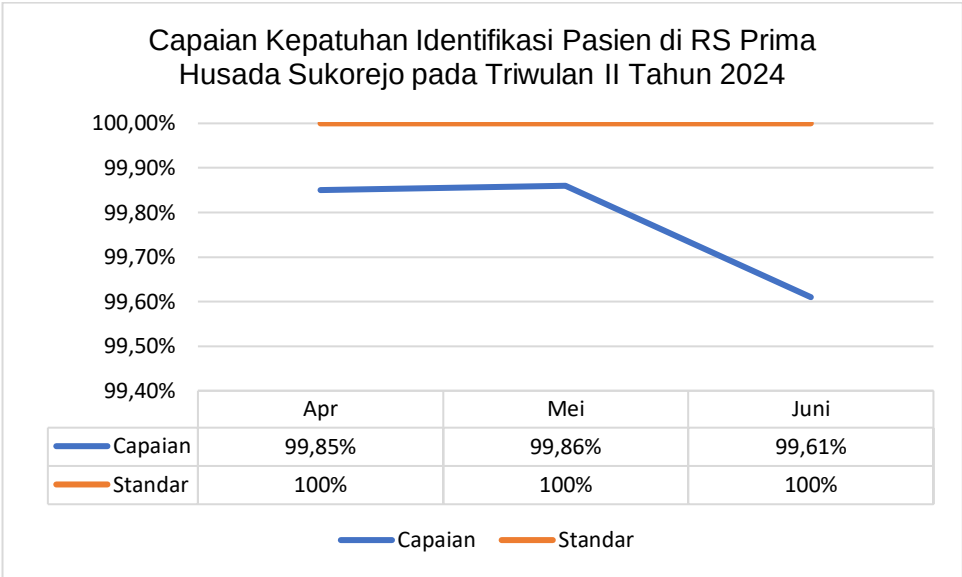
a. Indikator Mutu Prioritas

Tabel 3.19 Capaian Indikator Mutu Prioritas di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Ket
				Apr	Mei	Jun		
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1) Kepatuhan Identifikasi Pasien	100 %	99,85%	99,86%	99,61%	99,77%	PDSA
		2) Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	99,49%	99,55%	97,74%	98,93%	PDSA
		3) Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert	0	8	8	1	6	PDSA
		4) Kejadian tidak dilakukannya penandaan lokasi pasien operasi	0	0	0	0	0,00%	Tercapai
		5) Kepatuhan Kebersihan Tangan	100%	73,23%	67,79%	78,3%	73,11%	PDSA
		6) Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	97,76%	96,39%	97,26%	97,14%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1) waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	100%	65,64%	65,88%	89,25%	73,59%	PDSA
		2) waktu tunggu pelayanan Racikan ≤ 60 menit	100%	80%	85%	95,45%	86,82%	PDSA
3	Renstra RS	Kepuasan pelanggan	≥76,61%	80,19%	80,61%	96,18%	85,66%	Tercapai
4	Perbaikan Sistem	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 kejadian	32 kejadian	26 kejadian	19 kejadian	26 kejadian	PDSA
5	Manajemen Resiko	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	0 kejadian	89 kejadian	191 kejadian	68 kejadian	116 kejadian	PDSA

i. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

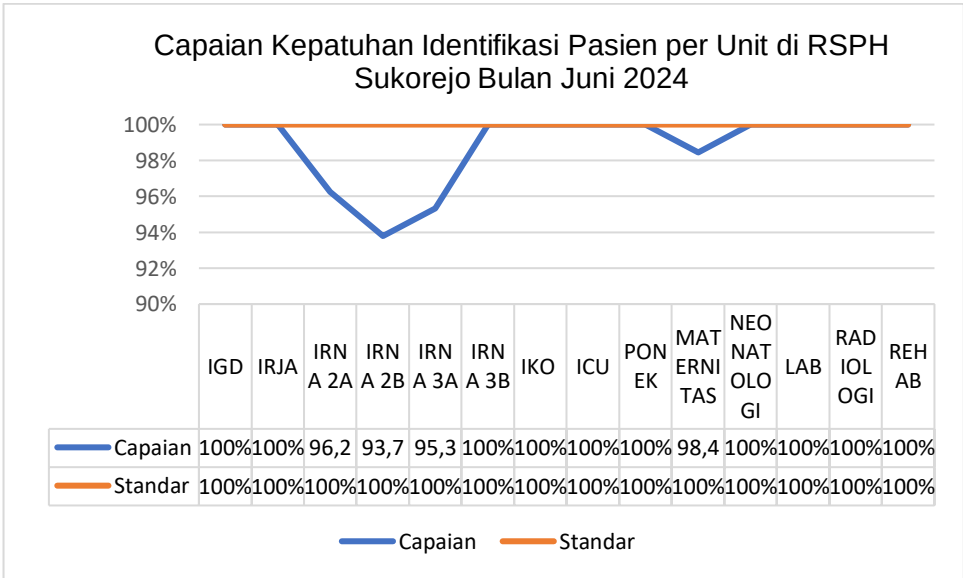
1. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.15. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien di RS. Prima Husada Sukorejo pada bulan Juni Tahun 2024 mencapai 99.61%. Data ini diambil dari 5428 pasien yang diobservasi pada 14 unit, ditemukan 5407 pasien yang dilakukan tindakan identifikasi pasien secara tepat dan 21 pasien tidak dilakukan identifikasi dengan tepat. Dibawah ini merupakan capaian kepatuhan identifikasi pasien per unit Bulan Juni 2024 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien per unit di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan terdapat 4 unit kepatuhan identifikasi pasien yang tidak mencapai standar yakni Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A) sebesar 96,25%, Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B) sebesar 93,79%, Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) sebesar 95,33% dan di Maternitas sebesar 98,46%. Adapun di Instalasi Rawat Inap 2A dari 80 pasien yang di observasi ditemukan 3 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja. Adapun di Instalasi

Rawat Inap 2B dari 145 pasien yang di observasi ditemukan 8 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar, yaitu tidak diidentifikasi secara visual (melihat gelang identitas pasien) tetapi dilakukan secara lisan saja. Adapun di Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) dari 150 pasien yang di observasi ditemukan 7 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja. Adapun di Maternitas dari 130 pasien di observasi ditemukan 2 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 99,61% dan belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : Merubah kebiasaan individu agar selalu patuh terhadap identifikasi pasien Harapan : Petugas yang namanya masuk dalam kategori tidak patuh dapat dilakukan pemantauan kepatuhan saat identifikasi ke pasien. Tindakan : - Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien - Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh - Koordinasi dengan kabid keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh - Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) - Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian Bulan Juni yakni 99,61% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien belum mencapai standar 100%. Terdapat 4 unit yang belum patuh terhadap kepatuhan identifikasi pasien yakni Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A) sebesar 96,25%, Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B) sebesar 93,79%, Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) sebesar 95,33% dan di Maternitas sebesar 98,46%. Ini dikarenakan masih ditemukan: a. Instalasi Rawat Inap 2A: Terdapat 3 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian : 3 petugas yang tidak melakukan identifikasi secara visual pada pemberian pengobatan - Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: - Intania Cahya Andini, A.Md.Kep (2 kali) - Nanda Daeng Pamungkas, A.Md.Kep (1 kali) b. Instalasi Rawat Inap 2B Terdapat 9 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian: 9 petugas yang tidak melakukan identifikasi secara visual pada pemberian pengobatan - Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: - Tatan Lestari, S.Kep., Ns (1 kali) M. Ragil Zuli Walady.,Amd.Kep (2 kali) - Aslah Fortuna Ramadhan, Amd. Kep (1 kali) - Wike Indriana, S.Kep.,Ns (1 kali) - Windy Silegar Maelani, S. Kep., Ns (1 kali) - Ayu Widayanti, S.Kep., Ns (1 kali) - Aryan Budi Purnomo, A.Md.Kep (1 kali) - Vella Octavianita., Amd Kep (1 kali) c. Instalasi Rawat Inap 3A Terdapat 7 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian: 7 petugas yang tidak melakukan identifikasi secara visual pada pemberian pengobatan - Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain:

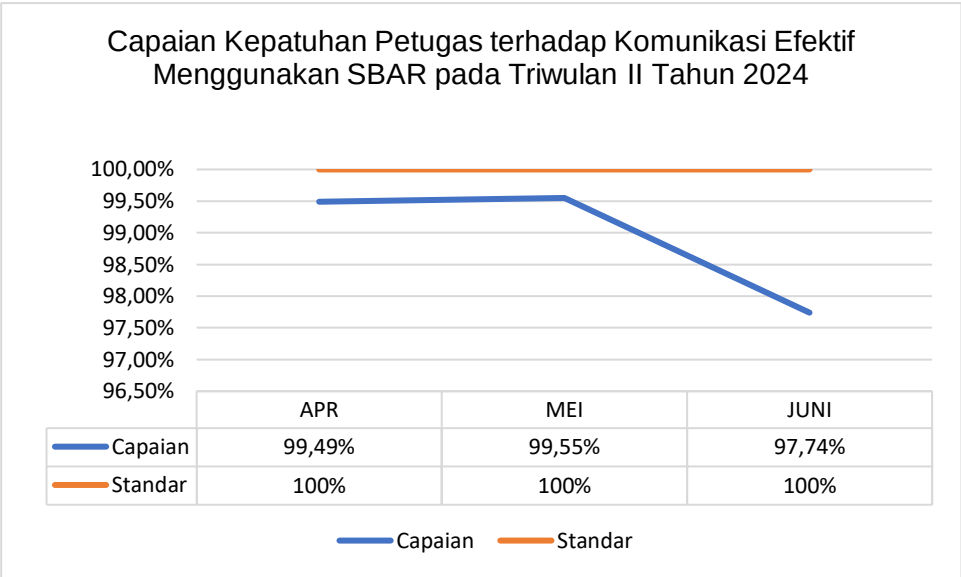
	a) Rica Octavianingrum, S.Kep., Ns (2 kali) b) Dhisma Fitri Rahmadhani Amd. Kep (2 kali) c) Dwi Putri Yulianti, S.Tr.Kep.Ns (1 kali) d) Istiqfarin Nurayunda, A.Md.Kep (1 kali) e) Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep (1 kali) d) Maternitas: Terdapat 2 petugas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian : 1) 2 petugas tidak idenfikasi secara visual hanya lisan saja petugas pada saat prosedur tindakan. 2) Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: a) Yulia Noer Rohmah, S.Tr., Keb (1 kali) b) Novita Wulansari, A.Md.Keb (1 kali)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Juni tahun 2024 mencapai 99,61%, masih ditemukan beberapa petugas di unit IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A & Maternitas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien 2. Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 3. Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan dalam berkas SDM. 4. Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani oleh staf yang bersangkutan 5. Rapat Mutu dengan karu 6. Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu 7. Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik 8. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Kepala Ruangan	Satu bulan
2	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah peneguran	Ka. Ruangan, Tim SKP, Kabid Keperawatan, SDM dan Mutu	Satu bulan
3	Memberikan catatan khusus tentang ketidakpatuhan staff dan diarsipkan	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Catatan Khusus staff yang tidak patuh	SDM	Satu bulan

	dalam berkas SDM.	pasien dengan benar				
4	Karu mencatat juga dalam Form Evaluasi Kinerja yang terbaru terkait nama-nama staf yang tidak patuh dan direkap semesteran dan form tersebut harus di tandatangani staf yang bersangkutan	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi pasien dengan benar	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Pencatatan staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan Unit Masing-Masing	Satu bulan
5	Rapat Mutu dengan Kepala Ruangan	Melakukan evaluasi terhadap kinerja system manajemen mutu	Kepala ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Rapat Komite Mutu & Kepala Ruangan	Satu bulan 1 kali
6	Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu	Mutu Unit dapat terkontrol secara berkelanjutan dan masalah terkait mutu dapat segera di tindaklanjuti	Seluruh staff di Unit	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan di setiap Unit	Satu bulan
7	Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik	Staff yang bertugas paham terkait pembelajaran yang disampaikan	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala ruang kepada timnya terkait pembelajaran	Kepala Ruangan	Satu bulan
8	Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin.	Kepala Ruang dapat mengetahui setiap petugas unit yang patuh terhadap identifikasi pasien	Seluruh staff di Unit	Supervisi yang dilakukan oleh kepala ruang dan mencatat staff yang tidak patuh dalam form evaluasi kinerja yang terbaru	Kepala Ruangan	Satu bulan

2. Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024 mencapai 97,74%. Data ini diambil dari 576 form SBAR pasien yang diobservasi ditemukan 563 form SBAR yang terisi lengkap dan 13 form SBAR yang tidak terisi lengkap. Berikut merupakan form SBAR yang tidak terisi lengkap yakni:

Table 3.22. Form SBAR di Bulan Juni yang tidak terisi secara lengkap

No	Unit	Nama Perawat	Jumlah Ketidakpatuhan	Alasan
1	Instalasi Rawat Inap 2B	Ida Nihayatul Afifa, S.Kep., Ns	2	Bagian Recommendation tidak terisi
		Windha Setyo Oetamie, S.Kep.Ns.	1	Bagian Recommendation tidak terisi
		Vella Octavianita ., Amd Kep	1	Bagian Recommendation tidak terisi
		Aryan Budi Purnomo, A.Md.Kep	1	Bagian background tidak terisi
		Windy Silegar Maelani, S. Kep., Ns	1	Bagian background tidak terisi
		Ana Nurlaili, A.Md.Kep	1	Bagian Recommendation tidak terisi
2	Instalasi Rawat Inap 3A	Yuana Pubosetiowati, S. Kep. Ns	1	Bagian Recommendation tidak terisi
		Erma Dwi Nurida, S.Kep.,Ns	1	Bagian Recommendation tidak terisi
		Leni Narulita, S.Kep., Ns	2	Bagian Recommendation tidak terisi
		Nila Martiya Sani., Amd Kep	1	Bagian Recommendation tidak terisi
3	ICU	Lillo Palupi Armaidah, A.Md.Kep	1	Terapi yang dijalankan tidak sesuai advice

Total	13	
-------	----	--

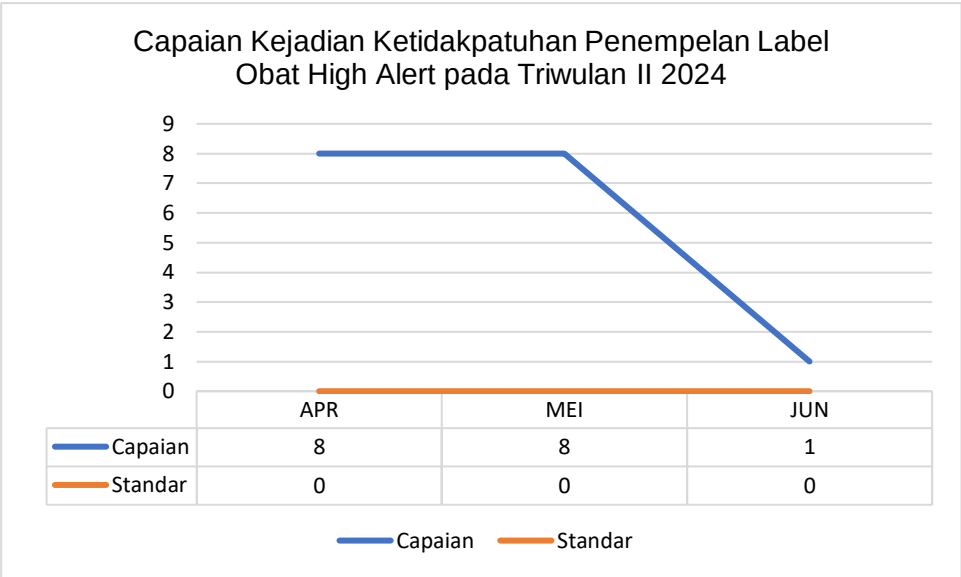
Tabel 3.23 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 97,74%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Rencana: Meningkatkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR 2. Harapan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR dapat tercapai 100% 3. Tindakan a. Peningkatan supervisi SBAR oleh PKRS & Mutu
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pengisian SBAR oleh petugas
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 97,74% belum mencapai standar 100% dari 674 form SBAR yang di observasi ditemukan 3 form SBAR yang tidak terisi lengkap pada: 1. Bagian Background tidak terisi (2 kali) 2. Bagian Recommendation tidak terisi (10 kali) 3. Bagian Terapi yang dijalankan tidak sesuai advice (1 kali)
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? patuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar disebabkan adanya form SBAR yang tidak terisi lengkap Ilow-up dan Rencana Lanjutan Supervise kepatuhan dan peneguran staff secara langsung

Tabel 3.24 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi kepatuhan dan peneguran staff secara langsung	Agar kepatuhan PPA dalam mengisi SBAR dapat meningkat	Kelengkapan SBAR dapat terisi 100%	Supervise dan peneguran secara langsung	PKRS	1 minggu

3. Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Gambar 3.18. Capaian Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Obat High Alert di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kejadian tidak adanya label high alert di di RS Prima Husada Sukorejo pada bulan Juni Tahun 2024 yaitu 1 kejadian yaitu pada obat lixiana.

Tabel 3.25 PDSA Capaian Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Obat High Alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Juni Tahun 2024

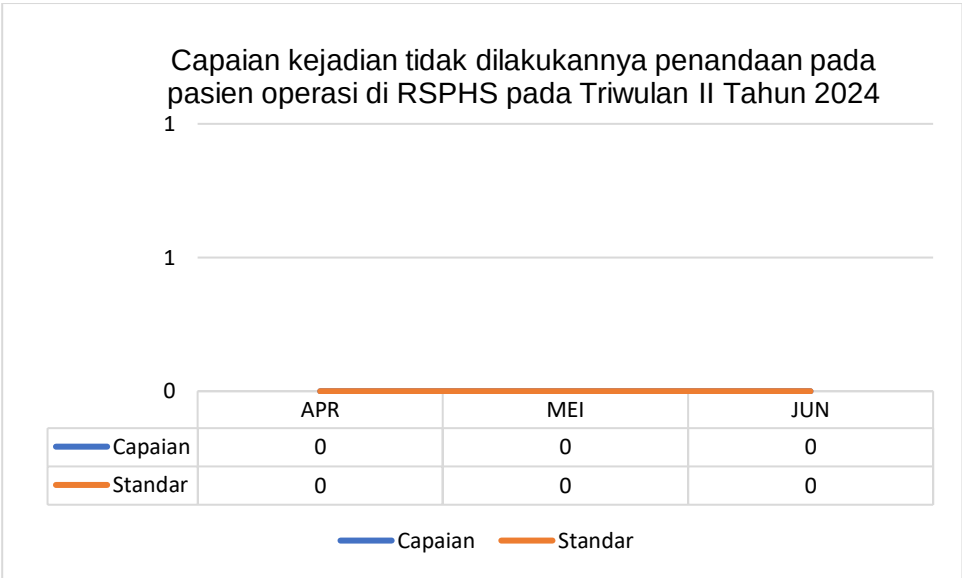
Problem	Rata-rata capaian kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 1 kejadian, angka tersebut belum mencapai target 0 kejadian
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo
Plan	Rencana : Meningkatkan kepatuhan petugas mengenai penempelan label obat high alert di Unit Farmasi Harapan : Kepatuhan petugas dalam penempelan obat high alert mencapai target Tindakan : Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang tidak menempel stiker obat high alert
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? Stiker High Alert Pada Obat High Alert
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 1 kejadian yakni pada obat lixiana, angka tersebut belum mencapai target 0 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh pada saat serah terima barang ada obat high alert yang belum tertempel.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 1 kejadian yakni pada obat lixiana, angka tersebut belum mencapai target 0 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh pada saat serah terima barang ada obat high alert yang belum tertempel. Follow-up dan Rencana Lanjutan a. Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang tidak menempel stiker obat high alert b. Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.26. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	---------	--------	---------	-----------	-----------	-------

	Kegiatan					
1	Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang tidak menempel stiker obat high alert	Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap stiker obat high alert	Seluruh petugas dalam penempelan obat high alert	Koordinasi dengan Karu mengenai obat high alert dan stiker pada obat	Karu Farmasi, Mutu	Satu bulan

4. Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi

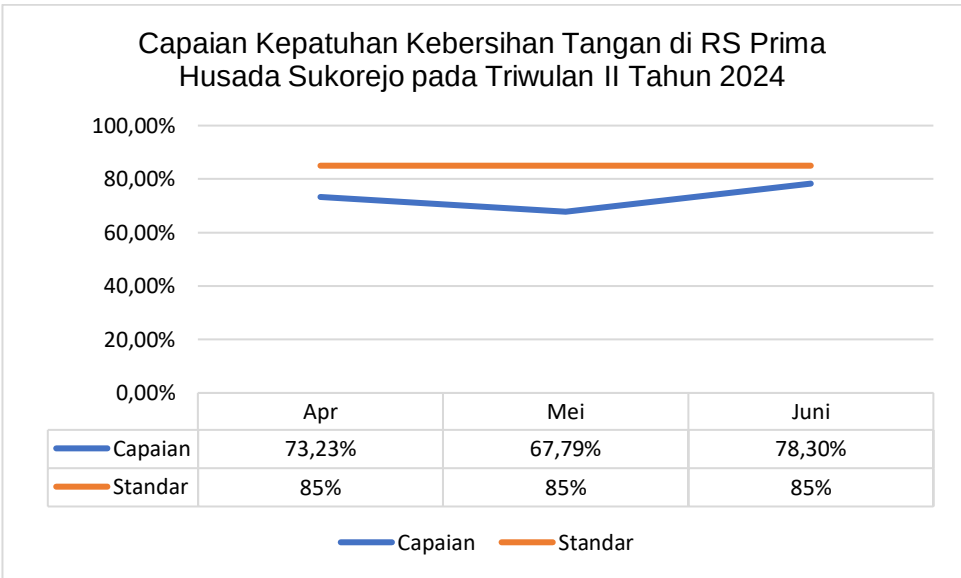


Gambar 3.19. Capaian Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Juni Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada bulan Juni Tahun 2024 yaitu 0 kejadian. Angka tersebut sudah mencapai standar yakni 0 kejadian. Ini disebabkan setiap pasien operasi telah dilakukan penandaan pada tubuhnya.

5. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.20. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan Juni belum mencapai ≥85%, yaitu 78,30 %. Dari 14 unit yang di observasi masih ditemukan 8 unit yang capaiannya < 85% yakni IRNA 3B 78%, IRNA 2A 71%, IRNA 2B 79%, ICU 74%, IKO 59%, IRJA 60%, Farmasi 73%, Radiologi 70%.

Tabel 3.25 PDSA Capaian Kepatuhan Kebersihan tangan petugas pada Bulan Juni Tahun 2024

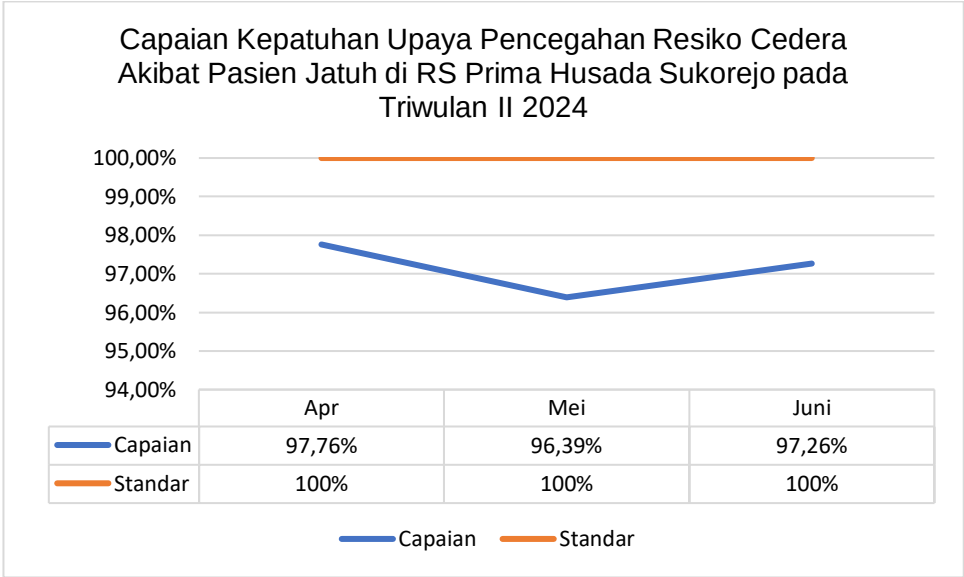
Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan Juni Tahun 2024 kurang dari 85% yakni 78,30%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan 2. Harapan: Seluruh staf pelayanan medik melakukan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan: a. Melakukan audit kebersihan tangan pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kebersihan tangan c. Koordinasi dengan PJ PPI di unit untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.
Do	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen yaitu: 1. Sebelum kontak dengan pasien 2. Sebelum tindakan aseptik 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien 4. Setelah kontak dengan pasien 5. Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan kebersihan tangan Bulan Juni mencapai 78,30% yang belum mencapai standar 85%. Ini disebabkan dari 3285 petugas yang melakukan kebersihan tangan selama 1 bulan, 2572 petugas yang patuh dan mempraktekan teknik 6 langkah dan 5 momen yang sesuai. 2. Rata-rata kepatuhan kebersihan tangan terendah di unit IKO yakni 59% 3. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan kebersihan tangan sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	1. Kolaborasi antara Komite PPI dan kabid keperawatan terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 2. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 3. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 4. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 5. Pemberian proses pembelajaran

Tabel 3.26. Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Komite PPI	Satu bulan

2	Koordinasi antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM terkait petugas yang tidak patuh dalam upaya kebersihan tangan	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama petugas medis	Rapat rutin antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Satu bulan
3	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Komite PPI	Satu bulan

6. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.21. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Juni tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1678 pasien yang di observasi ditemukan 46 petugas yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Berikut merupakan petugas yang tidak patuh dalam resiko jatuh yakni:

Table 3.13. Nama Petugas yang Tidak Patuh dalam Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh

No	Unit	Nama Petugas	Jumlah Ketidakpatuhan	Alasan
1	IRJA	Vira Agustin Sintia Putri, A.Md.Kep	3	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Firdhausi Nuzula., Amd Kep	1	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Iin Nur Khasanah, Amd. Kep	4	asuhan skrining resiko jatuh tidak

				dilakukan
		Indah Wulan Suci, A.Md.Kep	7	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Istighosah, A.Md.Kep	1	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Miati, Amd. Kep.	2	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Rezza Anggela Santoso., Skep.Ns	5	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Shara Wahyuni., Amd Kep	2	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
		Selvia Leli Agus Anika., S. Kep. Ns	1	asuhan skrining resiko jatuh tidak dilakukan
2	Maternitas	Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Al Alief Banat Amanda, S.Tr.Keb	2	Tidak terpasang handrail
		Novita Wulansari, A.Md.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Nurul Almi Samsu Amd.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Julya Marsa, S.Tr.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Lailatur Rofiqo, S.Tr.Keb	1	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Futuhatul Hidayah, S.Keb.Bd	2	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
3	IRNA 2A	Novita Febri Setiyani, S.Kep., Ns	1	Tidak Terpasang Handrail
4	IRNA 3A	Dewi Wijayanti, Amd. Kep	1	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
		Dimas Kurniansyah, S.Kep.Ns	2	Tidak terpasang stiker resiko jatuh di bed
		Yuana Pubosetiowati, S. Kep. Ns	2	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
		Daniel Pradana Putra, S.Kep., Ns	2	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
		Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep	1	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
		Leni Narulita, S.Kep., Ns	1	Tidak terpasang handrail di salah satu sisi
		Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.,Ns	1	Tidak terpasang

				stiker resiko jatuh di bed
TOTAL			46	

Tabel 3.14 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Harapan : Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien cedera akibat pasien jatuh dapat tercapai 100% Tindakan : koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal pasien - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap - Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Bulan Juni Tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh dalam melakukan skrinning awal maupun intervensi pada pasien yang berisiko jatuh sesuai RM seperti hand rail tidak terpasang dan tanda resiko jatuh di bed tidak terpasang.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Juni tahun 2024 adalah 97,26%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1678 pasien yang di observasi ditemukan 46 petugas yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko pasien jatuh. - Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. - Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh. Illo-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

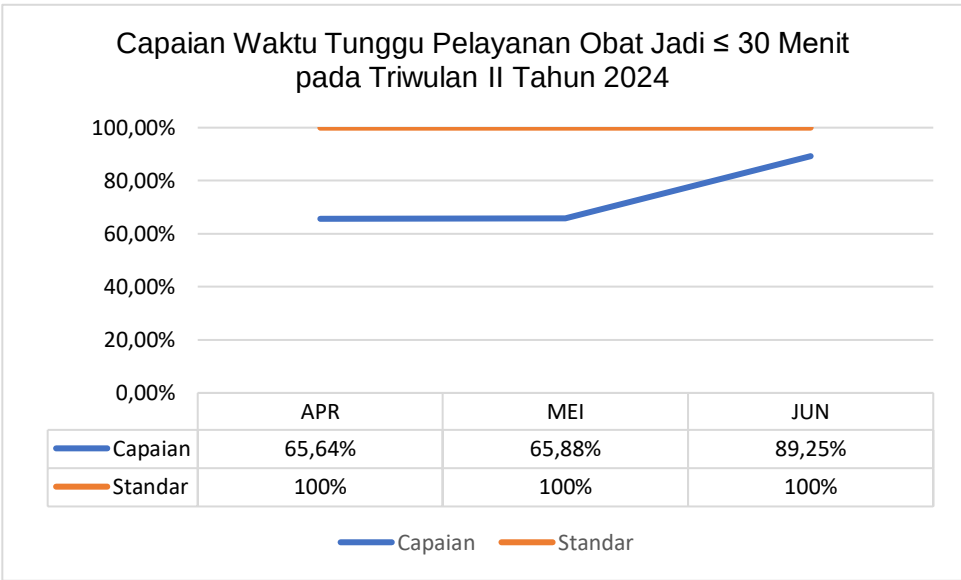
Tabel 3.15 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Koordinasi dengan kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	Satu Bulan
2	Monitoring dan Evaluasi	Meningkatkan kepatuhan	Nama-nama staff yang	Monitoring dan evaluasi	Kepala Ruangan,	Satu Bulan

	terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	berkala	Komite Mutu	
--	---	--	---	---------	-------------	--

i. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas

1. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit



Gambar 3.26. Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit pada Bulan Juni Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan waktu tunggu pelayanan obat jadi Obat Jadi ≤ 30 Menit pada bulan Juni tahun 2024 adalah 89,25%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Adapun dari 93 pasien dengan obat jadi yang di observasi ditemukan 10 pasien yang menunggu obat jadi > 30 Menit dengan rata-rata waktu 45 menit.

Tabel 3.34 PDSA Capaian Kepatuhan Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit pada bulan Juni Tahun 2024

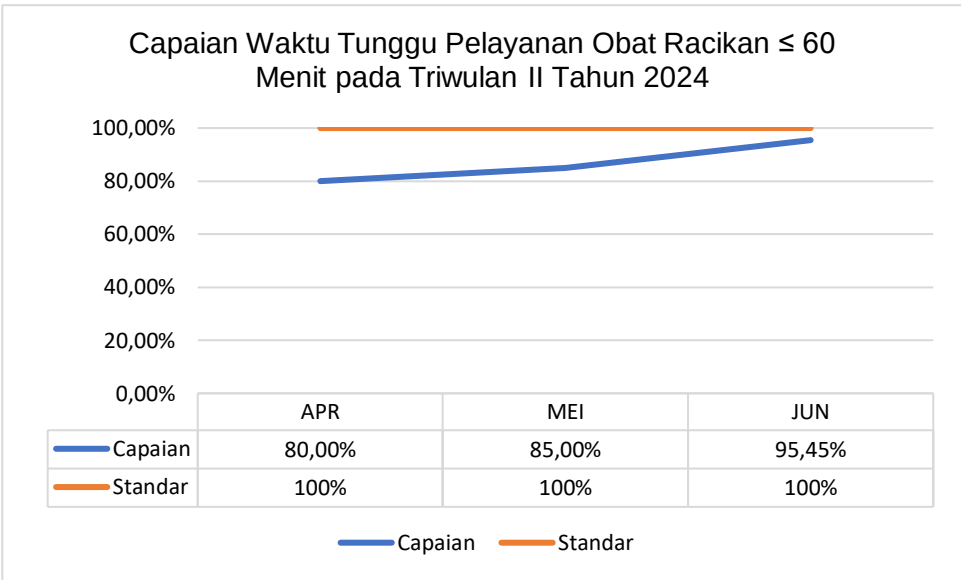
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit pada bulan Juni tahun 2024 adalah 89,25%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit Harapan : Kepatuhan waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit dapat tercapai 100% Tindakan : Koordinasi dengan Kabid Penunjang terkait pelayanan petugas dalam melakukan pelayanan obat jadi > 30 menit
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Melihat kepatuhan petugas dalam melayani obat dari SIMRS sampai obat dilayani
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Juni tahun 2024 belum mencapai target 100% yakni 89,25%, hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang melayani obat jadi > 30 menit
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? rata-rata capaian waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit pada bulan Juni Tahun 2024 belum sesuai standar dimana waktu pelayanan obat jadi > 30 menit dengan rata-rata 45 menit. Illo-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala

	ruang secara rutin
--	--------------------

Tabel 3.35 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang penunjang dan kepala ruangan farmasi untuk mengingatkan petugas dalam pelayanan obat jadi	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pelayanan obat jadi	Petugas Farmasi yang melayani obat jadi >30 menit	Rapat koordinasi dengan kabis penunjang, kepala ruangan farmasi	Kabis Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan

2.3 Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit



Gambar 3.26. Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit pada Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 Menit pada bulan Juni tahun 2024 adalah 95,45%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Adapun dari 22 pasien dengan obat racikan yang di observasi ditemukan 1 pasien yang menunggu obat jadi > 60 Menit dengan waktu 73 menit

Tabel 3.36 PDSA Capaian Kepatuhan Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit pada bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit pada bulan Juni tahun 2024 adalah 95,45%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan waktu tunggu pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu tunggu pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit Harapan : Kepatuhan waktu tunggu pelayanan Obat Racikan ≤ 60 Menit dapat tercapai 100% Tindakan : Koordinasi dengan Kabis Penunjang terkait pelayanan petugas dalam melakukan pelayanan obat Racikan > 60 menit
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Melihat kepatuhan petugas dalam melayani obat dari SIMRS sampai obat dilayani
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Juni tahun 2024 belum mencapai target 100% yakni 95,45%, hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang melayani obat racikan > 60 menit

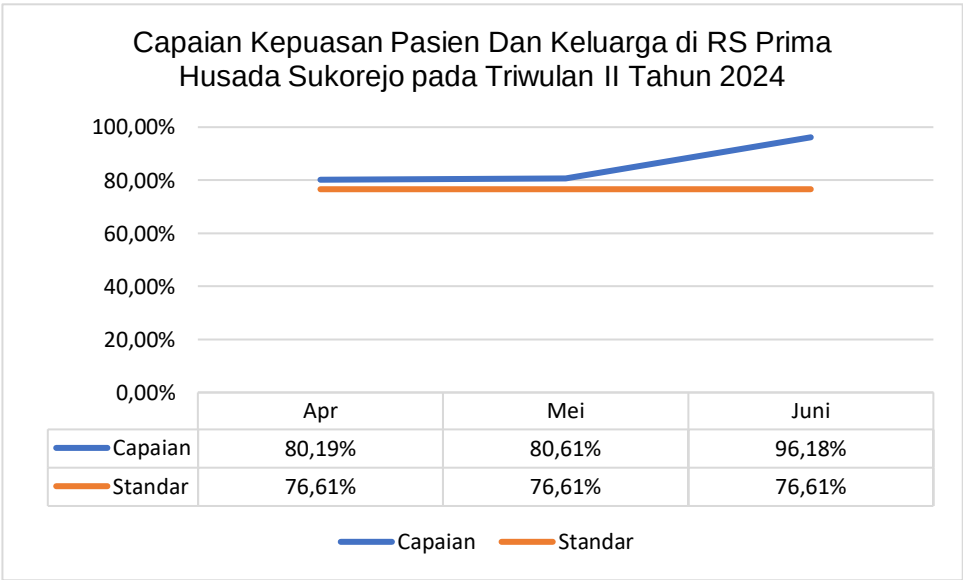
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? ta-rata capaian waktu tunggu pelayanan Obat racikan $\leq$ 60 Menit pada bulan Juni Tahun 2024 belum sesuai standar yakni 95,45%, dimana waktu pelayanan obat racikan > 60 menit dengan rata-rata 73 menit. llow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin
--------	---

Tabel 3.37 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang penunjang dan kepala ruangan farmasi untuk mengingatkan petugas dalam pelayanan obat jadi	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pelayanan obat jadi	Petugas Farmasi yang melayani obat jadi >30 menit	Rapat koordinasi dengan kabid penunjang, kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan

ii.Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis

4. Kepuasan pelanggan



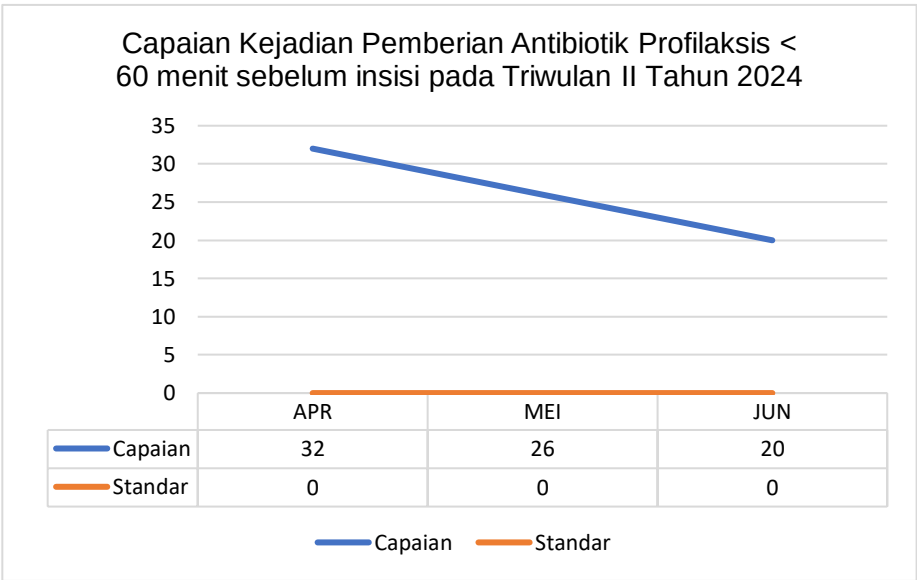
Gambar 3.27. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2024

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Juni 2024 sudah mencapai standar yakni 96,18%. Capaian Bulan Juni meningkat dibanding pada Bulan Mei yakni 80,61%.

iii. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem

1. Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi



Gambar 3.28. Capaian Kejadian Pemberian Antibiotik Profilaksis <60 menit sebelum insisi pada Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kejadian pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi pada bulan Juni tahun 2024 adalah 20 kejadian, angka tersebut belum mencapai target yakni 0 kejadian. Adapun dari 35 pasien yang di observasi ditemukan kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi. Kejadian ini disebabkan 2 faktor yakni 13 kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi dan 7 kejadian karena Unit IKO tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien.

Tabel 3.36 PDSA Capaian Kejadian Pemberian Antibiotic Profilaksis < 60 Menit Sebelum Insisi Di Unit Farmasi pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi pada bulan Juni 2024 adalah 20 kejadian, dimana tidak mencapai target yakni 0 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi
Plan	1. Rencana : Menurunkan capaian kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi 2. Harapan : Kepatuhan kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi dapat tercapai 0 kejadian. 3. Tindakan : a. Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar keterlambatan pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit. b. Koordinasi dengan Unit IKO dalam kelengkapan penulisan di Rekam Medik terkait jadwal pasien Operasi

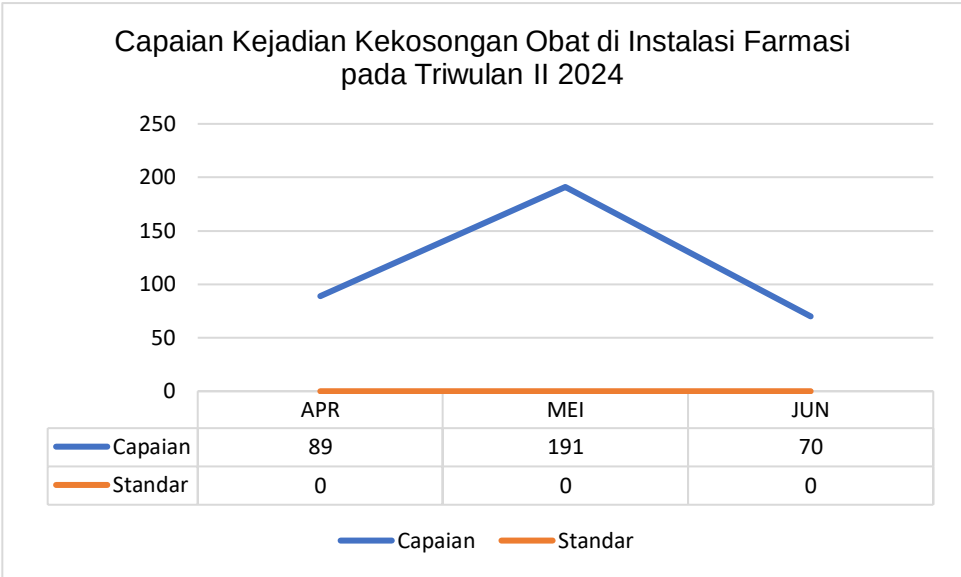
	c. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan terkait pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit. d. Supervisi terkait pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis 2. Melihat penulisan RM terkait jadwal pasien Operasi
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada bulan Juni tahun 2024 belum mencapai target 0 kejadian yakni 20 kejadian. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yakni 13 kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi dan 7 kejadian karena Unit IKO tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? rdasarkan rata-rata capaian pada bulan Juni tahun 2024 belum mencapai target 0 kejadian yakni 20 kejadian. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yakni 13 kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi dan 7 kejadian karena Unit IKO tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien. llow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.37 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang penunjang dan kepala ruangan farmasi dalam kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Petugas Farmasi yang terlambat dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Rapat koordinasi dengan kabid pelayanan, kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan
2.	Koordinasi dengan kepala bidang keperawatan kepala ruang farmasi dan kepala ruang IKO dalam kelengkapan penulisan jadwal pasien operasi di RM	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Perawat IKO yang tidak lengkap dalam penulisan jadwal pasien operasi di RM	Rapat koordinasi dengan kabid keperawatan, karu farmasi dan karu IKO	Kabid Keperawatan, Karu Farmasi, dan Karu IKO	Satu bulan
3.	Supervisi terkait kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Memastikan bahwa petugas patuh dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Petugas Farmasi yang terlambat dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Monitoring dan Evaluasi berkala	Karu Farmasi, Komite PMKP	Satu bulan

iv.Analisis Capaian Indikator Manajemen Risiko

1. Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi



Gambar 3.29. Capaian Kejadian Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi pada Bulan Juni Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi pada Bulan Juni tahun 2024 adalah 70 kejadian, angka tersebut belum mencapai target yakni 0 kejadian. Adapun jenis obat-obatan yang mengalami kekosongan antara lain:

Tabel 3.38 Daftar Nama Obat yang Kosong

No	Nama Obat yang Kosong	Frekuensi	Alasan
1	D5 1/2	13	Kosong Distributor
2	ERPHAFILIN	20	
3	carnexid / as.tranex inj	6	
4	cefadroxil caps	7	
5	cendo pantocain	9	
6	irbesartan 150mg	15	
TOTAL		70	

Tabel 3.39 PDSA Capaian Kejadian Kekosongan Obat Di Instalasi Farmasi pada Bulan Juni Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi pada bulan Juni tahun 2024 adalah 70 kejadian dimana tidak mencapai target yakni 0 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi
Plan	Rencana : menurunkan capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi Harapan : kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi dapat tercapai 0 kejadian. Tindakan : Koordinasi dengan Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Ruang Farmasi untuk menindaklanjuti kekosongan obat dari pihak distributor.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Daftar Obat yang mengalami kekosongan di Instalasi Farmasi
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada bulan Juni belum mencapai target 0 kejadian yakni 70 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan jenis obat-obatan yang mengalami kekosongan adalah D5 ½, Erphafilin, Carnexid/as tranex inj, Cefadroxil caps, Cendo Pantocain, Irbesartan 150mg. Kejadian ini disebabkan karena distributor mengalami kekosongan jenis obat-obatan tersebut.
Action	apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian pada bulan Juni belum mencapai target 0 kejadian yakni 70 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan jenis obat-obatan yang mengalami kekosongan adalah D5 ½, Erphafilin, Carnexid/as tranex inj, Cefadroxil caps, Cendo Pantocain, Irbesartan 150mg. Kejadian ini disebabkan karena distributor

	mengalami kekosongan jenis obat-obatan tersebut. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin
--	--

Tabel 3.40. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Ruang Farmasi untuk menindaklanjuti kekosongan obat dari pihak distributor.	Menurunkan kejadian kekosongan obat di Unit Farmasi	Daftar obat yang kosong dari depo dan Gudang Farmasi	Rapat koordinasi dengan kabid penunjang dan kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan

1. Indikator Mutu Prioritas Unit

1. **INSTALASI GAWAT DARURAT**

Tabel 3.40 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan II Tahun 2024

No	Judul Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,3%	99,77%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100,00%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1	Waktu tanggap pelayanan dokter <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100 %	90,97%	96,99%	PDSA
2	Kematian pasien < 24 jam (sebelum 8 jam)	≤ dua per seribu	0/1510	12/1637	12/1395	0,53%	PDSA
3	Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	Dipertahankan
4	Kepadakhengkapan pengisian pengkajian medis IGD	0%	0%	0,65 %	0%	0,22%	Dipertahankan
5	Kepadakhengkapan pengisian pengkajian keperawatan IGD	0%	0%	0%	0%	0,00%	Dipertahankan
6	Kepadakhengkapan formulir rujukan pasien	0%	0%	0%	0%	0,00%	Dipertahankan
7	Kepadakhengkapan dokumen casemix BPJS	0%	0%	0%	0%	0,00%	Dipertahankan

2. **INSTALASI RAWAT JALAN**

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	77,5%	73,73%	77,39%	76,21%	PDSA

3	Kepuasan pasien	≥ 80%	50%	-	-	50,00%	PDSA
4	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	50,43%	63,46%	65,22%	59,70%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit	0%	20%	26,89%	29,82%	25,57%	PDSA
2.	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian awal medis RJ	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan RJ	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4.	Ketidaklengkapan PRMRJ pasien	0%	100%	100%	100%	100%	PDSA

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	93,64%	96,19%	96,25%	95,36%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	97,14%	66,67%	98,75%	87,52%	PDSA
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	68,75%	47%	100%	71,92%	PDSA
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	≥ 80%	51,43%	51,43%	52,50%	51,79%	PDSA
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	50%	-	-	50,00%	Tidak ada Pasien dengan diagnose Tunggol
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0%	0,64%	0%	0,21%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	2 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	0%	4,4%	22,86%	5%	10,75%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5.	Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan tepat waktu (kemenkes, direktur, dinkes)	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.43 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	93,79%	97,93%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100,00%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	100%	-	100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	≥ 80%	50,68%	55,48%	48,30%	51,49%	PDSA
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	-	-	-		Tidak ada Pasien dengan diagnose Tunggal
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	30%	22,22%	1,33%	17,85%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	5 kejadian	0 Kejadian	7 kejadian	4 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	96,55%	98,85%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.44 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	95,33%	98,44%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	93,33%	97,78%	PDSA
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	75%	82%	95,45%	84,15%	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	≥ 80%	76%	82,58%	85,33%	81,30%	Dipertahankan
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	75%	75%	50%	67%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							

1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0,67%	0%	0,67%	0,45%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	2 kejadian	1 Kejadian	3 Kejadian	2 Kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	100%	96,66%	96,77%	97,33%	96,92%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	98,8%	96,67%	98,49%	PDSA
5.	Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan tepat waktu (kemenkes, direktur, dinkes)	100 %	100%	100%	100%	100%	Tercapai

6. **INSTALASI RAWAT INAP 3B**

Tabel 3.45 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	77,78%	92%	97,14 %	88,97%	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	≥ 80%	58,11%	63,87%	52,67 %	58,22%	PDSA
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	Tidak ada Pasien dengan diagnose Tunggal
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	1,33%	1,29%	1,33%	1,32%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	3 kejadian	2 Kejadian	4 kejadian	3 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	100%	74,82%	79,05%	85%	79,62%	PDSA

4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5.	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan tepat waktu (kemenkes, direktur, dinkes)	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

7. **INSTALASI KAMAR OPERASI**

A. Bedah

Tabel 3.46 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Bulan Juni Tahun 2024

No	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	≤ 5%	0,68%	0%	1,27%	0,65%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kejadian kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3.	Kejadian operasi salah pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Kejadian salah tindakan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6.	Ketidaklengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7.	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8.	Angka	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

	ketidaklengkapan inform consent						
9.	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengisian <i>surgical safety checklist</i> sesuai standar	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
11	Angka ketidaklengkapan laporan operasi	0%	0%	0%	0,25%	0,08%	PDSA

B. Anestesi

Tabel 3.47 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
.	Ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0%	0	0	0	0	Dipertahankan
3.	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan
4.	Kejadian efek samping selama sedasi moderat	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan
5.	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan
6.	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan

8. **MATERNITAS**

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	96,67%	97,42%	98,46 %	97,52%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	97,90%	98,66%	93,08 %	96,55%	PDSA
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		PDSA
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 –	≥ 80%	94,21%	86,32%	97,27 %	92,60%	Dipertahankan

	14.00)						
5	Waktu tanggap SC Cito	≥ 80%	100%	83,33%	87,50 %	90,28%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	50%	66%	92,79 %	69,60%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	Perdarahan 0% Pre-eklampsia 0% Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia 0% Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia 0% Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia 0% Sepsis ≤ 0%	dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	dipertahankan
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 Jam	100%	96,38%	97,95%	100%	98,11%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

9.
PONEK

Tabel 3.49
Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh tim ponek yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	Perdarahan 0% Pre-eklampsia % Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia % Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia % Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia % Sepsis ≤ 0%	dipertahankan
3.	Tidak	0%	Kegiat	Kegiata	Kegiata	Kegiata	dipertahankan

	terbinanya jejaring PONEK (tiap 1x)		an Bersa ma IBI	n Bersam a IBI	n Bersam a IBI	n Bersam a IBI	
--	-------------------------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-	-	PDSA
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	≥ 80%	95,19%	97,27%	97,98%	96,81%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 Jam	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kepuasan pelanggan	≥80%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	0 kejadian	2 kejadian	5 Kejadian	8 kejadian	5 Kejadian	PDSA
5.	Ketidakpatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	0%	0%	0%	0%	0%	dipertahankan

11. ICU

Tabel 3.51 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	71,43%	53,19%	60%	61,54%	PDSA

	(07.00 – 14.00)						
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0%	0%	0%	0%	dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian dokumen kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3.	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	97,56%	100%	96,77%	98,11%	PDSA

12. RADIOLOGI

Tabel 3.52 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100 %	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100 %	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-	-	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	< 3%	0%	0%	0%	0 %	Dipertahankan
2.	Kejadian keluhan DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3.	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	100%	100%	100 %	100%	Dipertahankan
4.	Angka ketidaklengkapan formulir permintaan radiologi	0%	0 %	0%	0 %	0 %	Dipertahankan
5.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

13. LABORATORIUM

Tabel 3.53 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		

Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Pelaporan nilai kritis ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-	-	
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Angka Kerusakan Sampel Darah	0%	0,04%	0%	0,12%	0,05%	PDSA
4.	Angka ketidaklengkapan formulir permintaan ke laboratorium	0%	4,09%	0%	4,86%	2,98%	PDSA
5.	Kejadian kesalahan pemindahan hasil laboratorium ke SIMRS	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	2 kejadian	1 kejadian	PDSA
6.	Kejadian Ketidaktepatan waktu pemeliharaan alat KSO laboratorium oleh teknisi dari vendor	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian Keterlambatan Backup alat error dalam waktu 1x24 jam.	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8.	Kejadian keterlambatan hasil laboratorium cito ≥ 30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
BDRS							
9.	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
10.	Reaksi tranfusi darah	< 0,01%	0%	0%	1,89%	0,63%	PDSA
11.	Kejadian keterlambatan penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12.	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.54 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	98%	98%	99%	98,33%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kejadian kesalahan tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
2.	Ketidaklengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

15. **FARMASI**

Tabel 3.55 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan terhadap formularium nasional	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	81,13%	-	-		PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	0 Kejadian	89 kejadian	191 Kejadian	68 Kejadian	116 kejadian	PDSA
2.	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 Kejadian	32 kejadian	26 Kejadian	20 kejadian	26 kejadian	PDSA
3.	Kejadian perubahan pemberian antibiotik profilaksis menjadi teraupetik	0 kejadian	18 kejadian	11 Kejadian	13 Kejadian	14 kejadian	PDSA

16. **GIZI**

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Sisa makanan	≤ 20 %	19%	19%	19%	19%	Dipertahankan

	yang tidak termakan oleh pasien						
3.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka ketidaklengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	0%	0%	0 %	0 %	0%	Dipertahankan
5.	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.57 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Ketidaklengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	0%	-	100%	100%	100%	PDSA
2.	Kelengkapan informed concent tindakan	100%	100%	-	82,76%	91,38%	Belum Mengisi
3.	Kelengkapan general concent	100%	74,73%	88%	93,10%	85,28%	PDSA
4.	Kejadian nomor rekam medis ganda	0	1 kejadian	1 Kejadian	2 kejadian	1 Kejadian	PDSA
5.	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0	2 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	1 Kejadian	PDSA
6.	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl,)	0%	-	-	-	-	PDSA
7.	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	0%	31,54%	91%	96,77%	73,10%	PDSA

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Baku mutu limbah cair	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD mg/l b. COD mg/l c. TSS mg/l d. PH	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d PH 6-9	Dipertahankan
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.	Angka ketidakpatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

19. **SDM**

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Bulan Juni Tahun 2024

No	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	100 %	54%	79,41%	79,41%	70,94%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	59,51%	58,46%	58,46%	58,81%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	≤10% / bulan	0,45%	0,44%	0,44%	0,44%	Dipertahankan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	1 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	0%	2,71%	1,79%	1,33%	1,94%	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD: BLS/PPGD/GELS/AL S b. PONEK: PPGD c. ICU d. HD e. IKO	100%	33,5%	33,50%	34,15%	33,72%	PDSA
7.	Kepuasan karyawan	≥ 80 %			55,1%	55,10%	PDSA
8.	Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

20. **KESEKRETARIATAN**

Tabel 3.60 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Tindak lanjut penyelesaian	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	hasil pertemuan direksi						
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariat	100%	89,29%	89,29%	85,71%	88,10%	PDSA
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.61 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Angka ketersediaan ambulance sesuai kebutuhan ≤30 menit	100%					Belum mengisi
2.	Kepuasan pengguna ambulance	≥80%					Belum mengisi
3.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%					Belum mengisi
4.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%					Belum mengisi

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.62 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Bulan Juni Tahun2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
ATEM							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	≤ 80%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	100%	100%	95%	100%	98,33%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	sesuai dengan jadwal						
IPSRs							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non medis ≤ 15 menit	100%	11,03%	11,99%	13,5%	12,17%	PDSA
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset ≤ 10 detik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

24. **LAUNDRY**

Tabel 3.64 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kejadian linen hilang	0 kejadian	1 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 1x24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kejadian terdapat benda asing di linen	0 kejadian	5 kejadian	5 Kejadian	3 Kejadian	4 Kejadian	PDSA
4.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

25. **CSSD**

Tabel 3.65 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kejadian kehilangan set instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai standar	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3.	Waktu tunggu pelayanan sterilisasi steam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5.	Persentase set instrumen yang sudah dibersihkan dan tepat waktu dari unit yang dikembalikan ke CSSD	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6.	Persentase hasil biological test negative pada BMHP reuse	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

7.	Terpasangnya label ED pada instrumen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

26. **CLEANING SERVICE**

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤ 2/3 tempat sampah	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 2x dalam sehari	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

27. **KEAMANAN**

Tabel 3.67 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai ketentuan	100%					Belum mengisi terkendala dengan pasien yang keluar masuk

28. **GUDANG UMUM**

Tabel 3.68 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan	Rata-	Keterangan
-----	-----------	---------	-------	-------	------------

			Apr	Mei	Jun	rata	
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	100%	86,36%	46%	95,33%	75,90%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	2 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.69 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	-	-	98%	98%	Pelatihan diadakan tanggal 7,8, 9 Juni 2024
2.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60 %	98,17%	96,9%	100%	98,36 %	Dipertahankan
3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75 %	57,76%	63,69 %	74,86 %	65,44 %	PDSA
4.	Kepatuhan HH	≥ 85%	73,23%	67,79 %	78,30 %	73,11 %	PDSA
5.	Kepatuhan APD	≥ 80%	96,37%	90,09 %	90,88 %	92,45 %	Dipertahankan
6.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0%	0%	0,55%	0,18%	PDSA
7.	Angka kejadian VAP pada pasien ICU	0%	0%	0%	0%	0,00%	Dipertahankan
8.	Angka kejadian infeksi pada pemasangan CVC pada pasien ICU	0%	0%	0%	0%	0,00%	Dipertahankan
9.	Angka phlebitis	≤ 1,5%	0,54%	1,23%	1,96%	1,24%	PDSA
10.	Kepatuhan penempatan pasien infeksius	100%	100%	100%	100%	100,0 0%	Dipertahankan

30. PKRS

Tabel 3.70 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Angka	0%	77,68%	88%	42,86%	69,51%	PDSA

	ketidakpatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok						
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR	100%	55,56%	63,64%	91,14%	70,11%	PDSA
3.	Kepatuhan pelaksanaan edukasi terintegrasi & kolaborasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

31. VERIFIKATOR

Tabel 3.71 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Verifikator pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kesesuaian coding diagnosis dan tindakan sesuai dengan INA-CBGS	100%	99,96%	99,99%	99,98%	99,98%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas terhadap penyetoran rekam medis BPJS Kesehatan ≤ 24jam	100%	91,58%	87,85%	85,11%	88,18%	PDSA
3.	Kepatuhan DPJP dalam mengisi resume medis	100%	92,67%	92,90%	92,67%	92,75%	PDSA
4.	Ketidaklengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	0%	4,00%	1,29%	2,00%	2,43%	PDSA

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.72 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	80,19%	80,61%	96,18%	85,66%	Dipertahankan
2.	Ketidakpatuhan update dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kenaikan jumlah pasien baru	10% / bulan	22,27%	26,43%	30,99%	26,56	Dipertahankan

33. CSO

Tabel 3.73 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Responstime CSO <30 mnt (WA)	100%	100%	-	61,73%	80,87%	PDSA

34. MOD-MPP

Tabel 3.73 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1	Kepuasan	≥ 80%	80,19%	80,61%	96,18%	85,66%	Dipertahankan

	pelanggan						
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Angka ketidaklengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	0%	0%	0%	43,33%	14,44%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan form Dischard planning	0%	3,45%	35,77%	43,33%	27,52%	PDSA

35. TB di IRJA

Tabel 3.74 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB di IRJA pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1	Ketidakpatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Kejadian tidak terpantaunya pasien TB oleh PIC TB	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan

36. ASURANSI CENTER

Tabel 3.75 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1	Ketepatan Maturitas klaim BPJS	100%					Belum mengisi

37. KEUANGAN

Tabel 3.76 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10menit	<5%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Ketepatan waktu pembayaran kepada pihak rekanan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Jumlah piutang ≥1m / bulan	0%	17%	27%	29%	24,33%	PDSA

38. **TIM HIV**

Tabel 3.77 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1	Kejadian tidak teridentifikasi pasien HIV pada pasien bedah	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian pasien drop out pengobatan HIV	0 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

39. **KB**

Tabel 3.78 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Ketidakpatuhan pengisian kartu K4 KB	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca Keguguran	50%	24,24%	17,14%	15,13%	18,84%	PDSA
3.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	30%	100%	100%	94,37%	98,12%	PDSA

40. **STUNTING**

Tabel 3.79 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Bulan Juni Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	100%	0%	0%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

41. IT - SIM RS

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Bulan Juni Tahun 2024

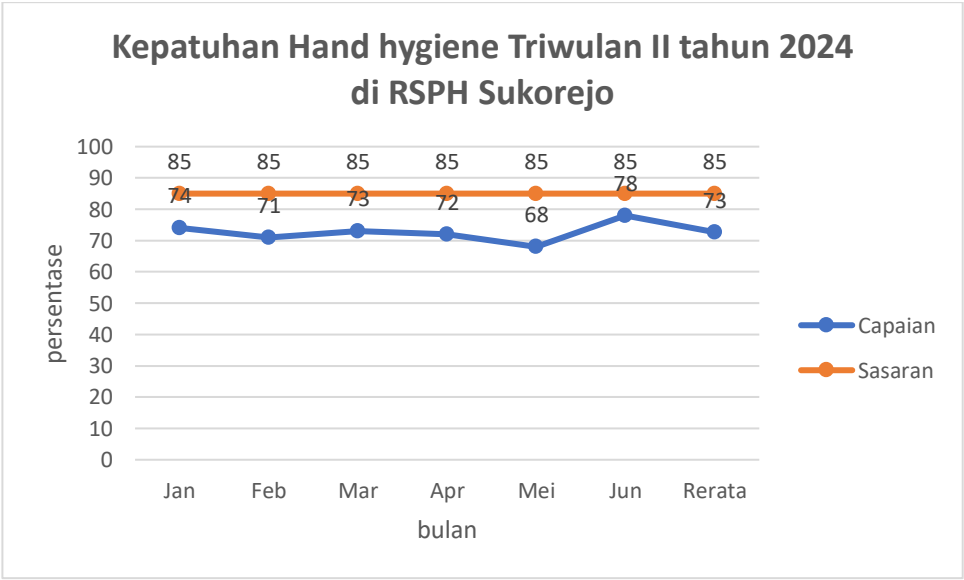
No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Apr	Mei	Jun		
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan 1 minggu sekali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	84,62%	100%	100%	94,87%	Dipertahankan
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	83,33%	100%	100%	94,44%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	100%	100%	100%	46,15%	82,05%	PDSA

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Kewaspadaan Standar

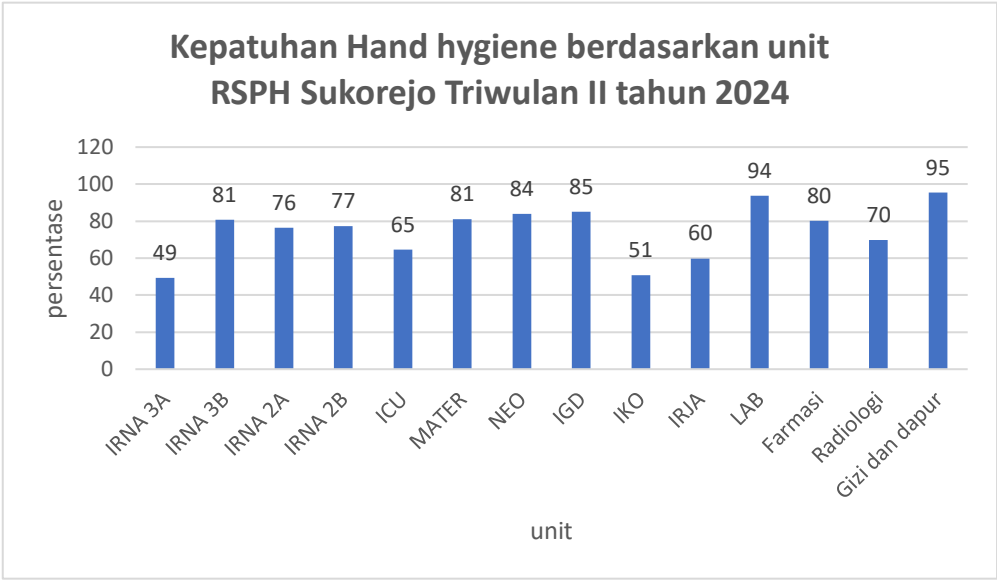
A. Kepatuhan kebersihan tangan

1. Kepatuhan total



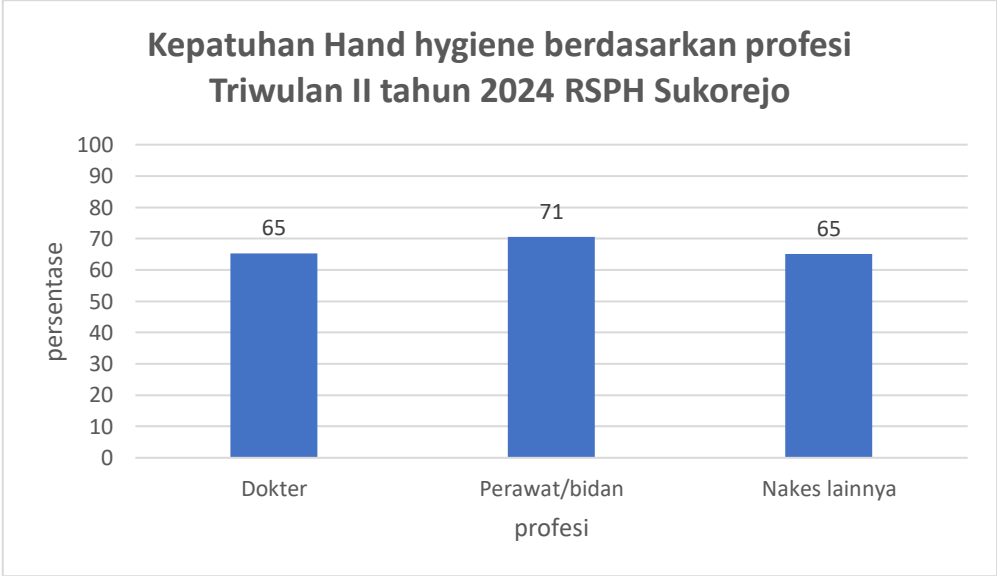
Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan total kebersihan tangan di triwulan II mencapai 73%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu 85%.

2. Kepatuhan berdasarkan unit



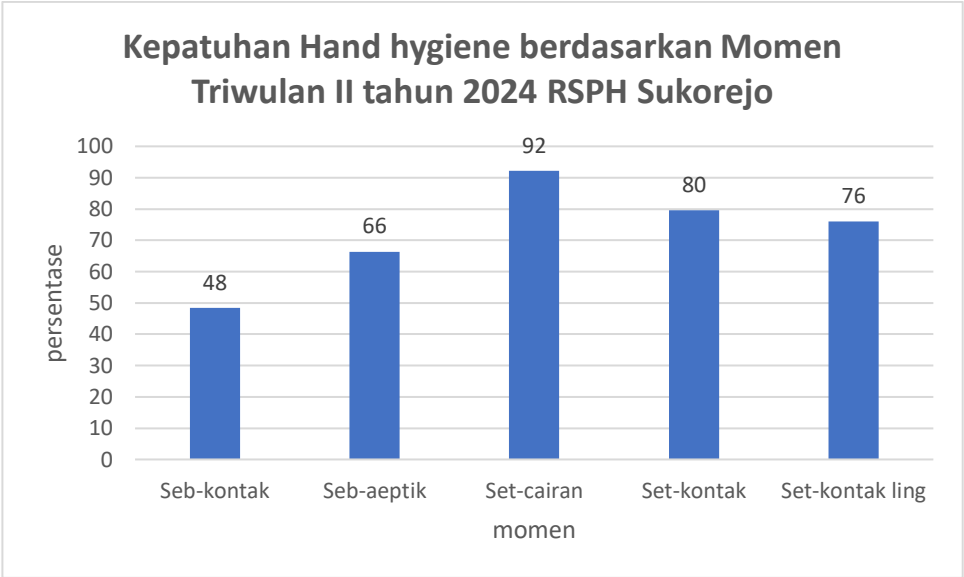
Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa unit dengan rata-rata kepatuhan kebersihan tangan terendah yaitu unit IRNA 3A sebesar 49%. Kepatuhan tertinggi di unit gizi dan dapur sebesar 95%.

3. Kepatuhan HH berdasarkan profesi



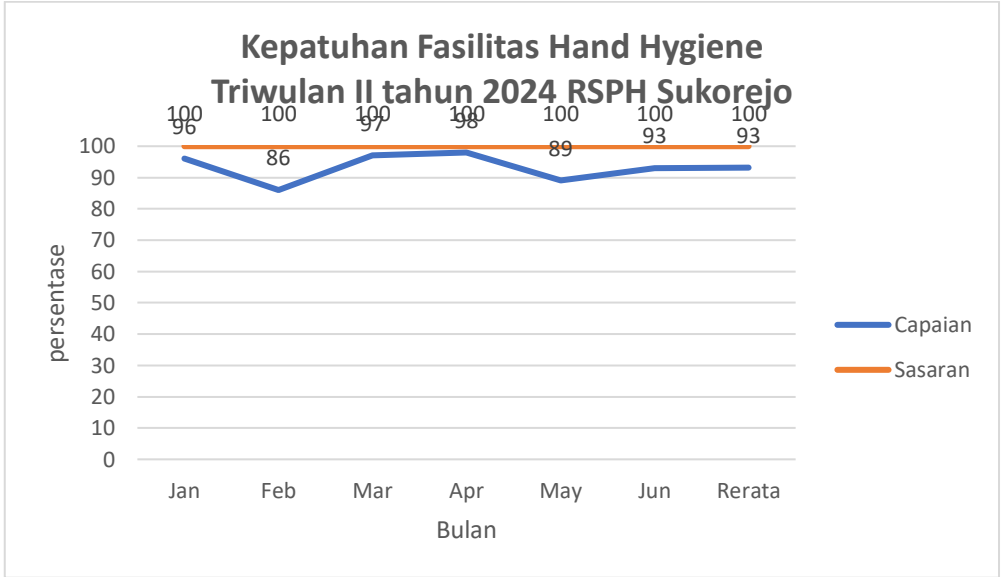
Interpretasi: Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah perawat/bidan sebesar 71%. Nakes lain yang dimaksudkan adalah tenaga Kesehatan yang kontak langsung dengan pasien seperti petugas laboratorium dan farmasi selama melakukan visite di unit rawat inap.

4. Kepatuhan berdasarkan 5 momen



Interpretasi: Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan momen terendah adalah momen sebelum kontak dengan pasien yaitu sebesar 48%.

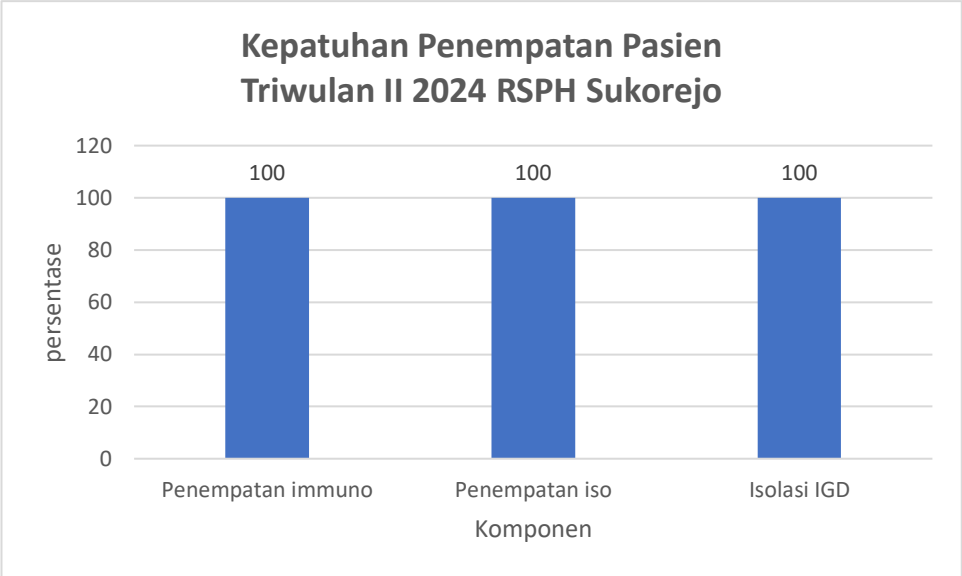
5. Fasilitas hand hygiene



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan pemenuhan fasilitas kebersihan tangan sebesar 93% Dimana angka tersebut belum sesuai dengan standar yaitu 100%.

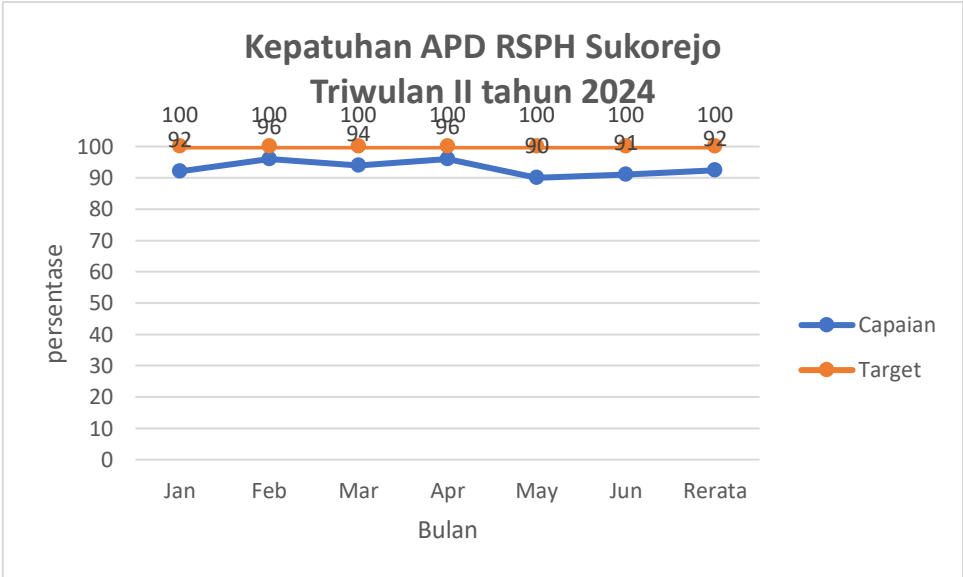
Tabel PDSA Kebersihan Tangan	
PROBLEM	Rata-rata kepatuhan kebersihan tangan di triwulan II mencapai 73%, Dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu 85%.
STEP	1. Menganalisis masalah: a. banyaknya staf baru yang belum mendapatkan pelatihan b. staf yang tidak patuh, karena tidak diawasi dan belum menyadari pentingnya kebersihan tangan 2. Buat rencana tindak lanjut
PLAN	4. Rencana: Mengetahui kepatuhan hand hygiene secara berkesinambungan 5. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 6. Tindakan a. membuat TOR untuk review pelatihan PPI dasar b. berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan c. membuat rencana metode role play HH untuk staf lama
DO	Monitoring dan audit menggunakan form audit kebersihan tangan oleh WHO.
STUDY	1. Rata-rata kepatuhan total kebersihan tangan di triwulan I mencapai 73%, dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu 85%. 2. Rata-rata kepatuhan kebersihan tangan terendah yaitu unit IRNA 3A sebesar 49%. Kepatuhan tertinggi di unit gizi dan dapur sebesar 94%. 3. Rata-rata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah perawat/bidan sebesar 71%. 4. Rata-rata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan momen terendah adalah momen sebelum kontak dengan pasien yaitu sebesar 48%. 5. Ditemukan staf baru belum pelatihan PPI dasar
ACTION	1. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 2. Kolaborasi dengan kabid terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 3. Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 4. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

B. Kepatuhan Penempatan Pasien



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien sudah mencapai target 100% di triwulan II tahun 2024.

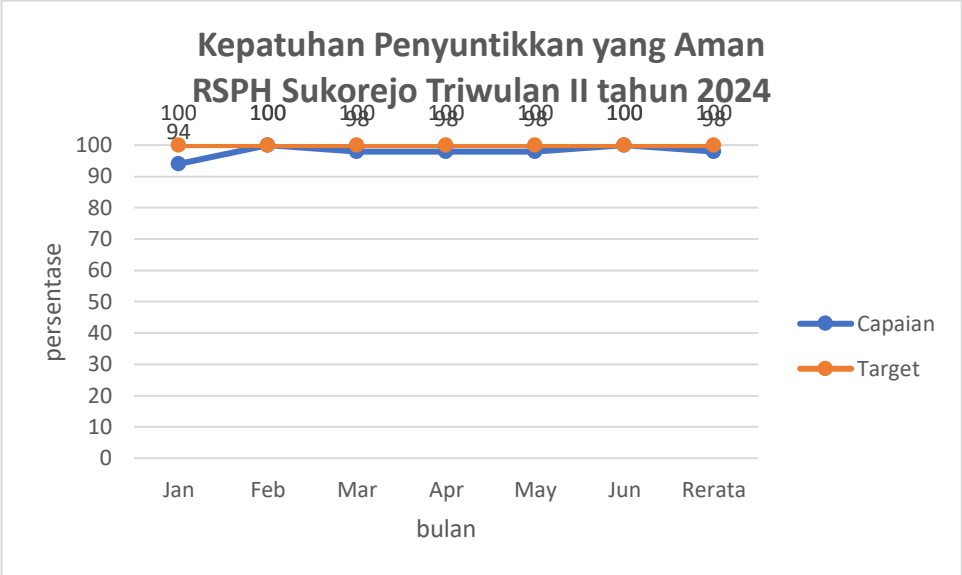
1. Kepatuhan penggunaan APD berdasarkan unit



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata unit dengan kepatuhan penggunaan APD terendah adalah unit laboratorium yaitu sebesar 60%.

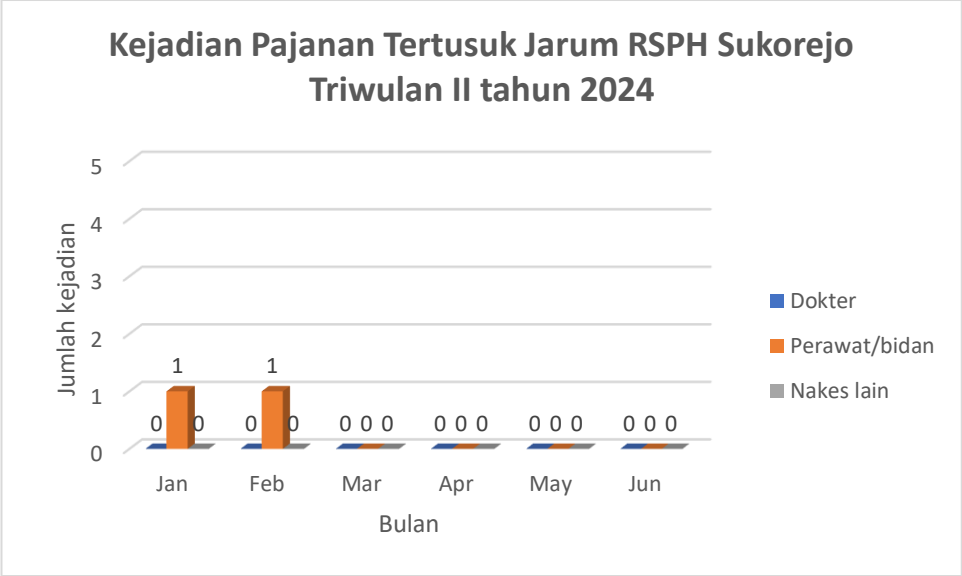
PROBLEM	Persentase rata-rata kepatuhan penggunaan APD pada triwulan II tahun 2024 mencapai 92% Dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu sebesar 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	2. Rencana: Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan 3. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 4. Tindakan a. Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
DO	Monitoring dan audit kepatuhan penggunaan APD menggunakan form audit.
STUDY	2. Rata-rata kepatuhan penggunaan APD pada triwulan II tahun 2024 mencapai 92% Dimana angka tersebut belum mencapai standar yaitu sebesar 100%. 3. Rata-rata unit dengan kepatuhan penggunaan APD terendah adalah unit laboratorium yaitu sebesar 60%. 4. Ditemukan petugas lab tidak menggunakan gown di area sampling. 5. Ditemukan petugas pemorsian tidak menggunakan APD dengan tepat.
ACTION	2. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 3. Beri feedback pada hasil temuan. 4. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk monitoring penggunaan APD di unit. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

C. Kepatuhan Penyuntikkan yang Aman dan Pencegahan Paparan Benda Tajam



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan penyuntikkan yang aman di triwulan II tahun 2024 sebesar 98% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu sebesar 100%.

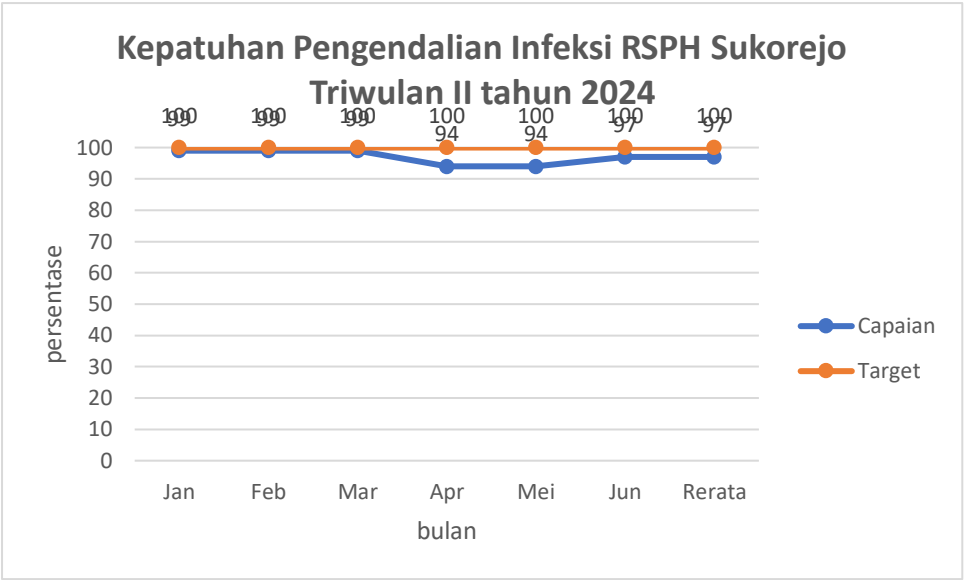
Tabel 2. PDSA Penggunaan APD



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa tidak ada 1 kejadian pajanan tertusuk jarum bekas pasien pada perawat di triwulan II tahun 2024.

PROBLEM	Rata-rata kepatuhan penyuntikkan yang aman di triwulan II tahun 2024 belum mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf terkait kepatuhan penyuntikkan yang aman untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien, serta mengurangi risiko tertusuk jarum bekas pakai
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam penyuntikkan yang aman di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai dan risiko tertusuk jarum dapat ditekan. 3. Tindakan - Melakukan audit penyuntikkan yang aman di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penyuntikkan yang aman - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit.
DO	Monitoring kepatuhan penyuntikkan yang aman menggunakan form supervisi dan audit.
STUDY	1. Masih ditemukan petugas yang kurang menerapkan prinsip Teknik one hand saat memasukkan obat dalam ampul ke spuit (IGD). 2. Ditemukan spuit dalam kondisi diletakkan di atas bed pasien, sehingga sudah tidak steril (IRNA). 3. Ditemukan petugas tidak melakukan kebersihan tangan saat akan melakukan penyuntikkan, karena sudah menggunakan handscoon, sedangkan kebutuhan handrub di bed pasien terpenuhi (IRNA dan IGD).
ACTION	1. Beri feedback pada hasil temuan. 2. Review kepada staf terkait alur pasca pajanan 3. Monitoring penyuntikkan yang aman dengan Teknik one hand. 4. Lakukan audit berkala setiap unit 5. Beri teguran saat melakukan audit penyuntikkan yang aman di unit.

a. Kepatuhan Pengendalian Infeksi Lingkungan



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan kebersihan lingkungan di triwulan II tahun 2024 sebesar 97% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 100%.

PROBLEM	Persentase rata-rata kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%.
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan - Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. - Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit.
DO	Monitoring dilakukan secara rutin menggunakan form supervisi yang telah disusun.
STUDY	1. Masih ditemukan fasilitas kebersihan tangan yang kosong seperti handtowel (IGD, IRNA, IRJA) 2. Masih ditemukan kamar pasien KRS belum dibersihkan segera setelah pasien pulang, sehingga saat pasien baru masuk, kondisi kamar belum bersih maksimal
ACTION	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

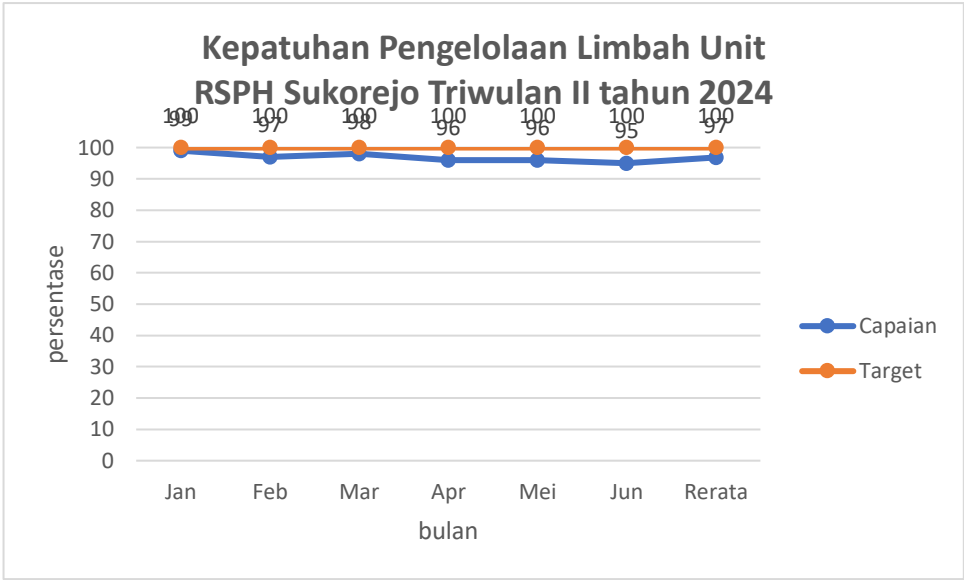
b. Kepatuhan Penanganan Linen



Interpretasi: Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kepatuhan penanganan linen triwulan II tahun 2024 sebesar 94% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 100%.

PROBLEM	Persentase rata-rata kepatuhan penanganan linen belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit londri mengenai pentingnya penanganan linen untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penanganan linen di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam penanganan linen di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit penanganan linen di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penanganan linen di unit laundry. c. Koordinasi dengan IP di unit untuk meningkatkan kepatuhan penanganan linen di unit. d. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai.
DO	Kepatuhan penanganan linen mencapai 100% di bulan berikutnya.
STUDY	1. Masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD lengkap saat menangani linen infeksius 2. Ditemukan area londri belum diprogres kebersihan.
ACTION	1. Resosialisasi kepada staf terkait penanganan linen 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. 4. Monitoring progress pembersihan ruangan

-
- c. Kepatuhan Penanganan Limbah
 - 1. Kepatuhan pemilahan sampah unit (infeksius dan non infeksius)



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui rata-rata kepatuhan pengelolaan limbah unit di triwulan II tahun 2024 sebesar 97% Dimana angka tersebut belum sesuai dengan standar yaitu 100%.

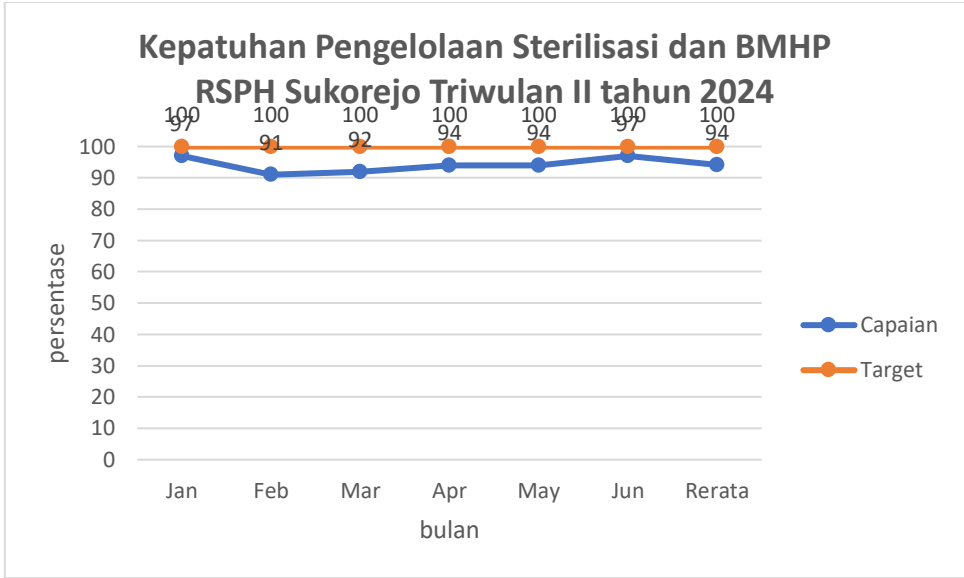
PROBLEM	Persentase rata-rata kepatuhan pemilahan sampah di unit belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pemilahan sampah di unit baik infeksius maupun non infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pemilahan sampah di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pemilahan sampah di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pemilahan sampah di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pemilahan sampah di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah di unit.
DO	Monitoring kepatuhan pemilahan sampah unit dilakukan menggunakan form supervisi.
STUDY	1. Masih ditemukan limbah tidak segera dibuang setelah selesai Tindakan (IKO). Masih ditemukan cara mengikat limbah infeksius belum tepat (IRNA, IRJA). 2. Masih ditemukan limbah yang penuh tidak segera diganti (IRNA).
ACTION	1. Review pengelolaan limbah di unit kepada staf terutama staf cleaning service terkait pemilahan sampah di unit, motivasi petugas untuk patuh dalam pemilahan limbah di unit. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Jika ada sampah yang tercampur, follow up ke unit segera untuk dipilah 4. Catat nama unit asal di limbah yang tidak terikat dengan baik sebagai hasil evaluasi kinerja.

2. Kepatuhan pembuangan sampah jarum dan benda tajam



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan pembuangan sampah jarum dan benda tajam di triwulan II tahun 2024 mencapai 89% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 100%.

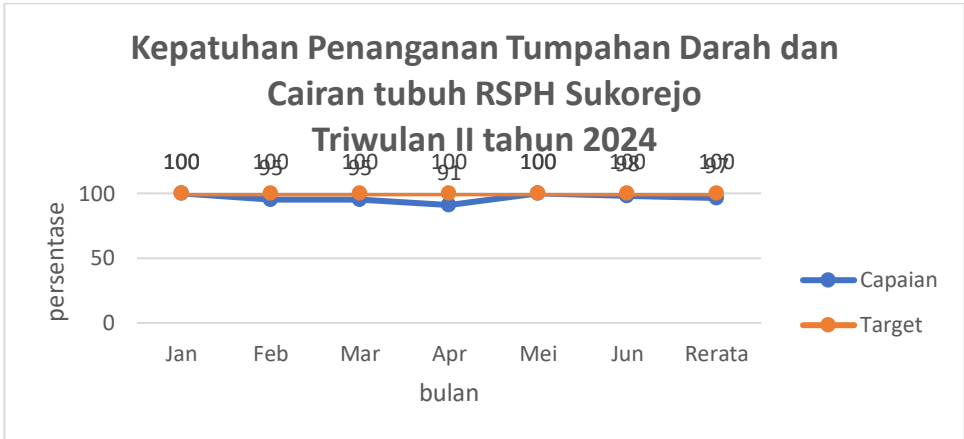
d. Kepatuhan Pemrosesan Peralatan Kesehatan (Dekontaminasi CSSD)



Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan perawatan peralatan pasien triwulan II tahun 2024 mencapai 94% Dimana angka tersebut belum sesuai standar 100%.

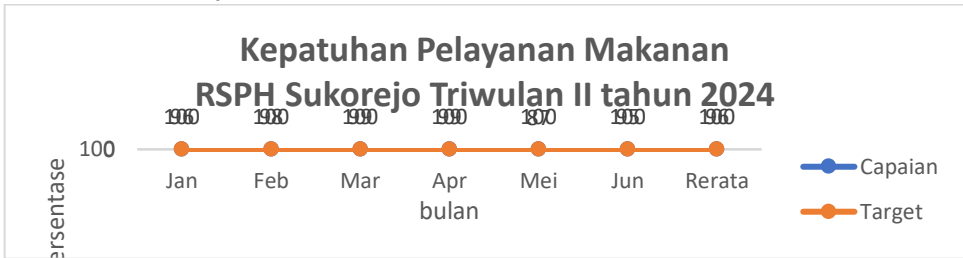
D. Program Penunjang PPI

1. Kepatuhan Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh



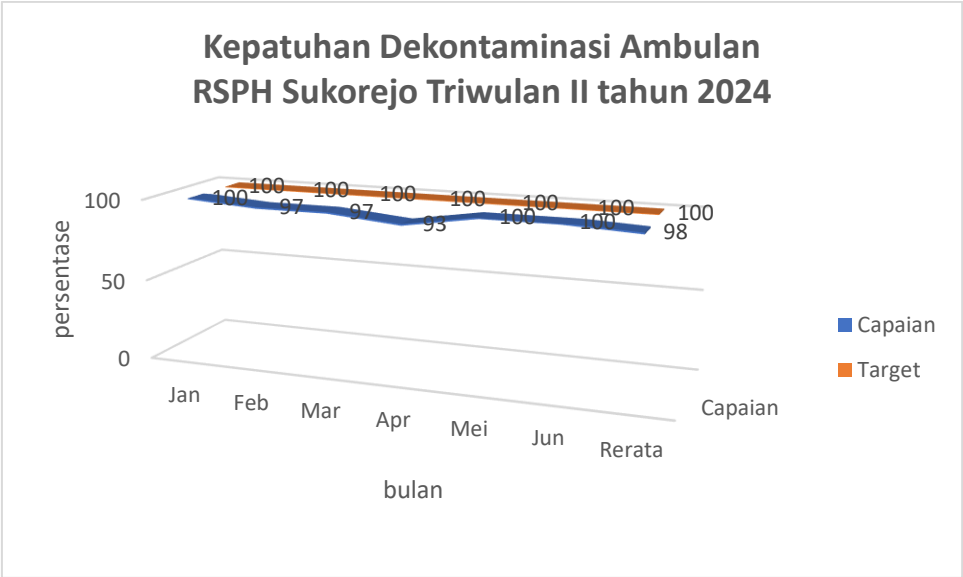
Interpretasi: Pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan penanganan tumpahan di triwulan II tahun 2024 mencapai 97% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 100%.

E. Kepatuhan Pelayanan Makanan



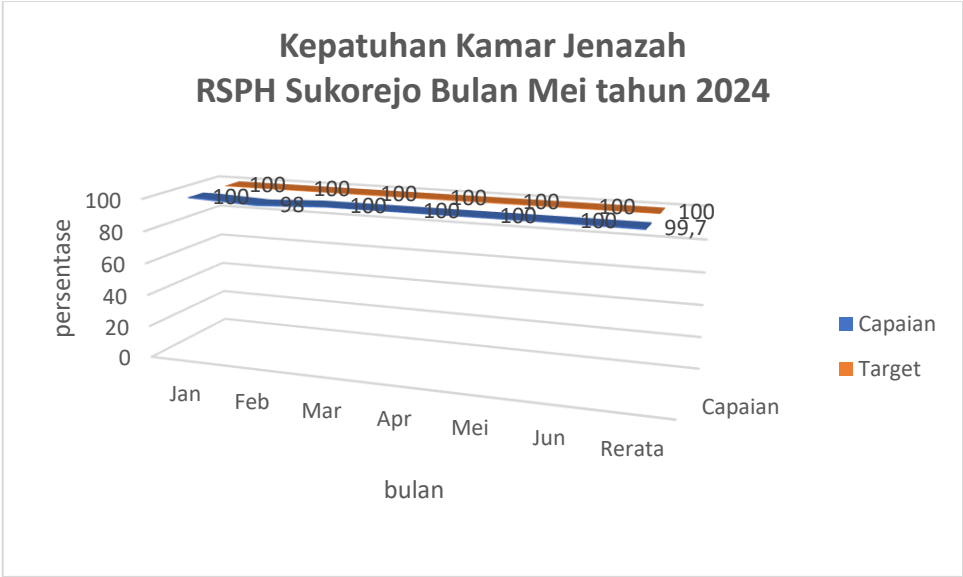
Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kepatuhan pelayanan makanan di triwulan II tahun 2024 sebesar 96% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 100%.

F. Dekontaminasi ambulan



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kepatuhan dekontaminasi ambulan di triwulan II tahun 2024 mencapai 98% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu sebesar 100%.

G. Kepatuhan Penatalaksanaan Kamar Jenazah



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rata-rata kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah di triwulan II tahun 2024 mencapai 99,7% dimana sama seperti bulan sebelumnya, mencapai sasaran.

H. Kesehatan Karyawan

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan		Keterangan
			Fisik	Thorax	
Jumlah		-	-	-	Sisa staf yang belum MCU = 82
1.	Januari	-	-	-	-

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan		Keterangan
			Fisik	Thorax	
2.	Februari	-	-	-	Dilakukan swab rectal pada 10 staf dapur dengan hasil dianalisa
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	22	-	-	Dari 53 staf yang direncanakan MCU, terlaksana 22 orang (+ tes HbsAg)
6.	Juni	-	-	-	

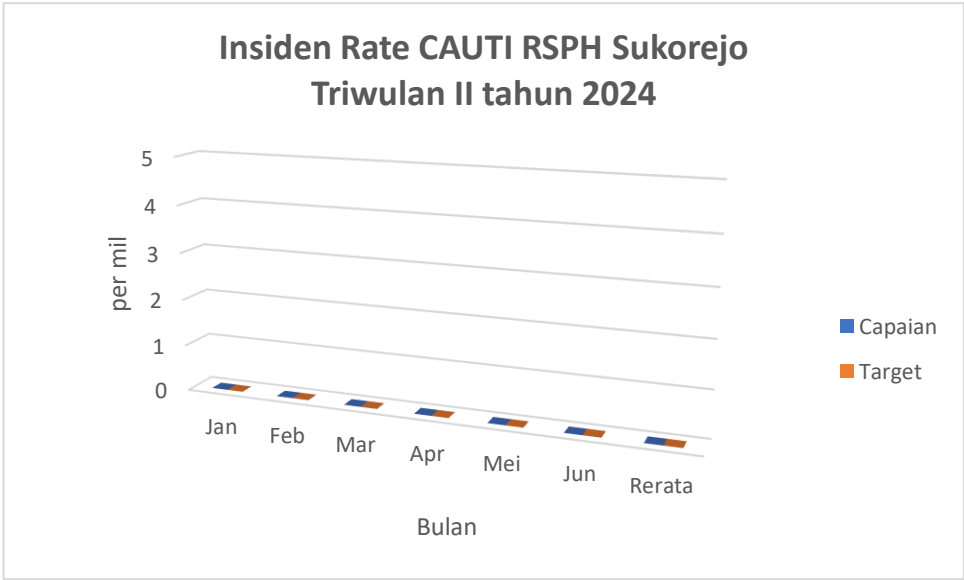
Interpretasi:
 Dilakukan MCU pada bulan Mei sejumlah 22 orang dari 53 staf.

Analisa:
 K3RS masih membuat monitoring MCU di bulan April hingga 2-3 bulan kedepan.

RTL:
 Koordinasi dengan K3RS terkait pelaksanaan MCU

D. Surveilans HAIs

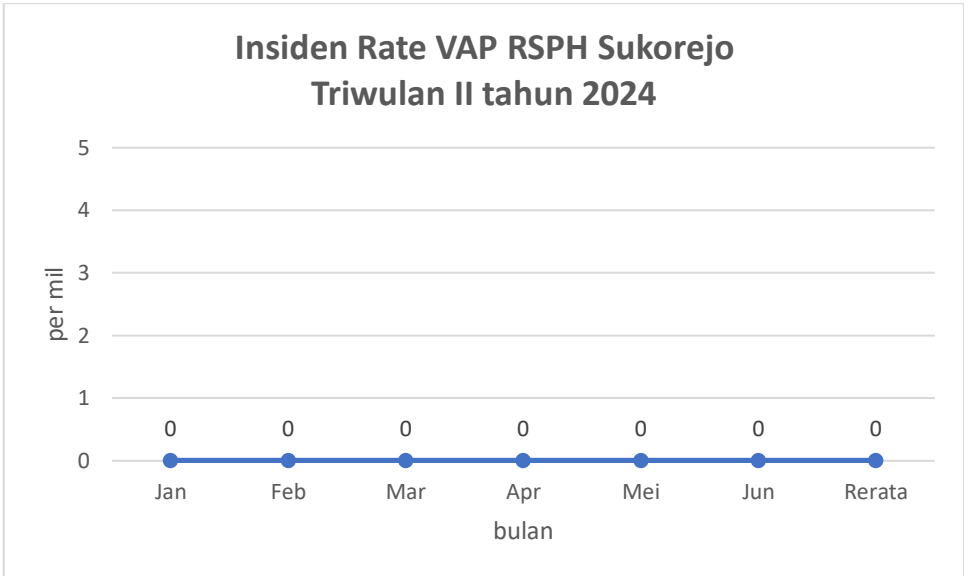
1. Infeksi Saluran Kemih (CAUTI)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa di triwulan II tahun 2024 tidak ada kejadian ISK akibat pemasangan urine catheter di rumah sakit.

PLAN	Mempertahankan angka ISK yang sudah sangat baik.
DO	Surveilans ISK dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	Jarangnya kejadian ISK pada unit perawatan dapat disebabkan karena pemakaian kateter yang tidak terlalu lama dan perawatan rutin oleh perawat ruangan serta penggantian rutin kateter setelah 7 hari pemasangan.
ACTION	1. Monitoring pelaksanaan bundles ISK di unit 2. Koordinasi pelatihan pemasangan dan perawatan kateter pasien dengan komite keperawatan.

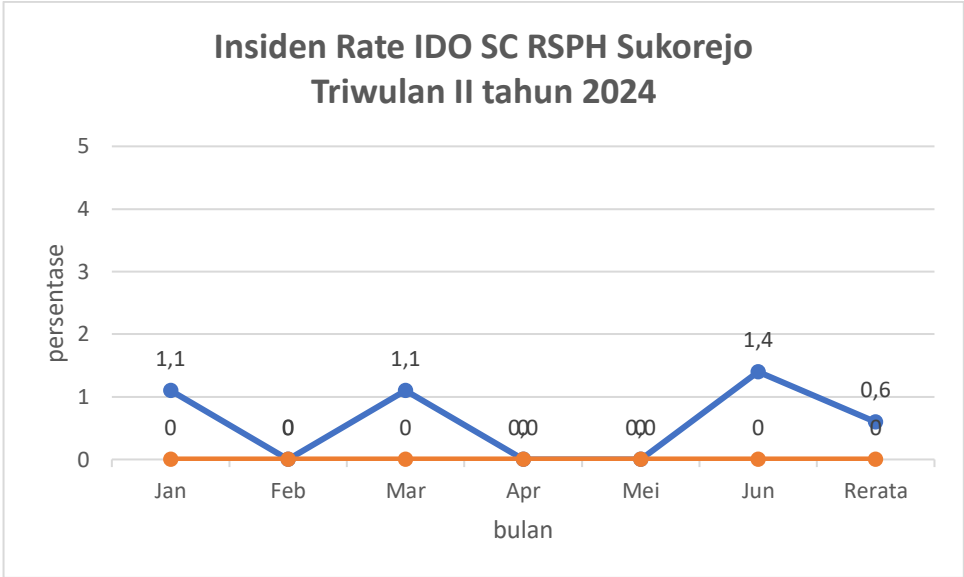
2. Ventilator Associated Pneumonia (VAP)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa di triwulan II tahun 2024 tidak ada kejadian VAP akibat pemasangan ventilator di rumah sakit.

PLAN	1. Melaksanakan bundles VAP sesuai SPO 2. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 3. Supervisi oleh IPCN 4. Mempertahankan angka VAP sesuai standar yaitu 0 %
DO	Surveilans VAP dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	Pemakaian ventilator banyak dilakukan di unit ICU dan pemakaiannya langsung dalam pantauan DPJP anastesi dan pemeliharaan alat langsung dilakukan oleh petugas IPSRS.
ACTION	1. Monitoring pelaksanaan bundles VAP di unit 2. Koordinasi perawatan dan pembersihan alat dengan IPSRS

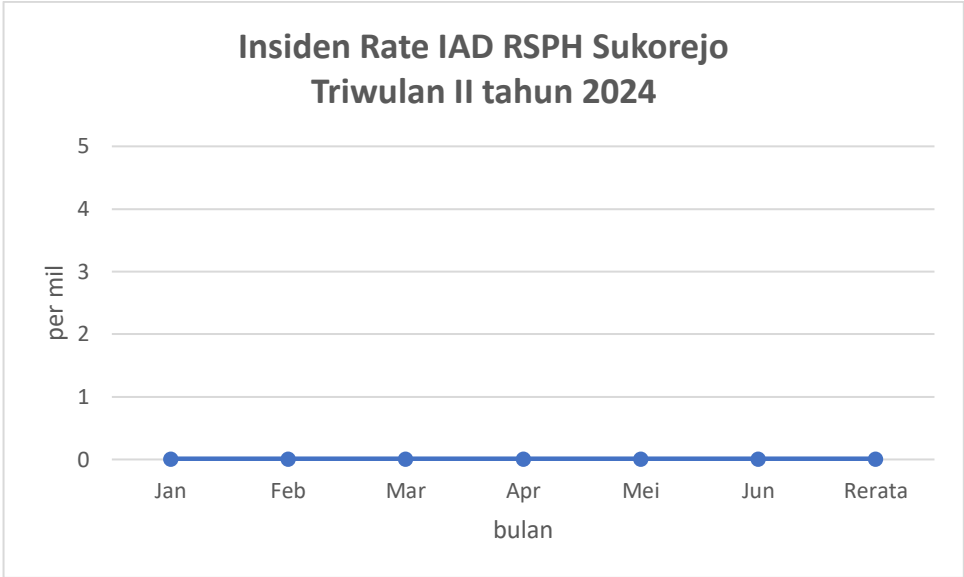
a. Infeksi Daerah Operasi (IDO SC)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rata-rata insiden rate IDO SC di triwulan II tahun 2024 adalah 0,6%.

PLAN	1. Evaluasi bundles IDO pada tahap pre op, intra op, dan post 2. Melaksanakan surveilans dan bundles IDO sesuai prosedur 3. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 4. Supervisi oleh IPCN
DO	Surveilans IDO dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	Hasil penelusuran bahwa 3 pasien pemberian profilaksis t < 1 jam, termasuk pasien yang terkena IDO. IDO diduga karena hasil lab preop leukositnya menunjukkan > 11.000 (pasien dengan IUFD) sehingga kemungkinan untuk terjadinya infeksi sangat tinggi. Pasien operasi cito, tidak mandi saflon.
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan 2. Monitor pelaksanaan bundles IDO pada saat prosedur operasi maupun pada saat prosedur perawatan luka. 3. Tingkatan edukasi perawatan pasien pasca operasi untuk menghilangkan mitos-mitos masyarakat tentang operasi. 4. Koordinasi dengan pengadaan farmasi terkait cairan antiseptik untuk mandi pasien yang akan operasi serta alat cukur yang lebih berisiko rendah untuk cedera. 5. Rencanakan pelatihan khusus CS IKO terkait pembersihan lingkungan IKO 6. Koordinasi dengan dokter operator dan tim IKO lainnya terkait berjalannya bundles operasi SC.

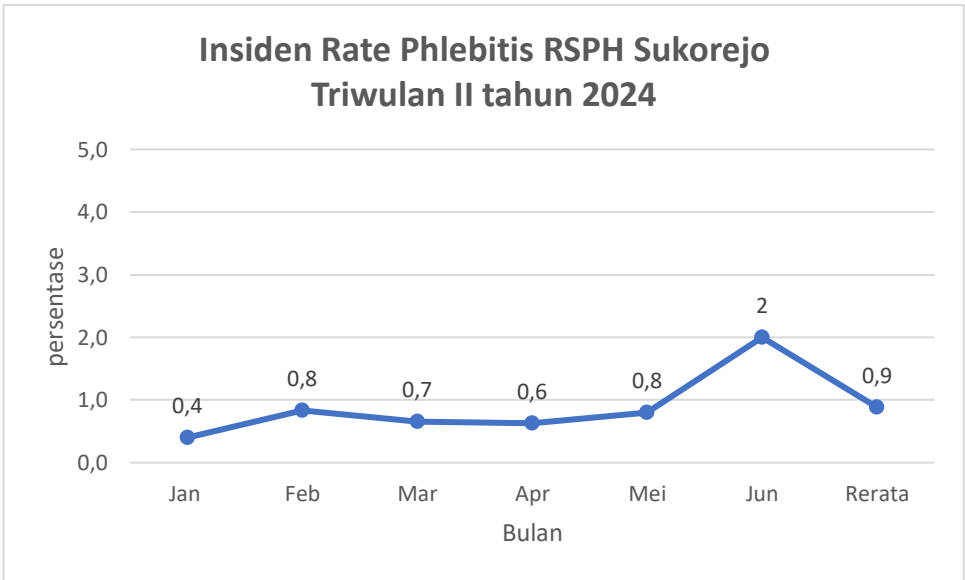
b. Infeksi Aliran Darah (IAD)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa tidak ada kejadian infeksi aliran darah yang diakibatkan pemasangan CVC di triwulan II tahun 2024.

PLAN	1. Melaksanakan bundles IAD sesuai SPO 2. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 3. Supervisi oleh IPCN
DO	Surveilans IAD dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	1. Pemasangan CVC hanya pada unit ICU dengan diagnosa tertentu, sehingga pengawasan bundles insersi maupun maintenance lebih focus terhadap pasien. 2. Pemasangan CVC lebih sering tidak lebih dari 3 hari tergantung kondisi pasien.
ACTION	1. Lakukan sosialisasi kepada perawat tentang bundles insersi dan maintenance IAD 2. Koordinasi dengan komite keperawatan untuk melakukan pelatihan pemasangan CVL dan PVL

c. Phlebitis



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rata-rata insiden rate phlebitis di triwulan II tahun 2024 mencapai 0,9% Dimana angka tersebut belum sesuai standar yaitu 1,5%.

PLAN	1. Melaksanakan bundles phlebitis sesuai SPO 2. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 3. Supervisi oleh IPCN
DO	Surveilans IAD dilakukan menggunakan form surveilans Monitoring kepatuhan bundles dilakukan menggunakan google form
STUDY	Penurunan kasus phlebitis dikarenakan meningkatnya proses perawatan luka infus oleh petugas dan dari sisi internal pasien sendiri yang menjaga agar lokasi infus tidak bengkak. Risiko pembengkakan area insersi meningkat karena semakin tingginya penggunaan obat seperti furosemid, dobutamin, dan nicarpidin yang dimasukkan ketubuh pasien melalui syringepump.
ACTION	1. Lakukan sosialisasi kepada perawat tentang bundles insersi dan maintenance phlebitis. 2. Koordinasi dengan komite keperawatan untuk melakukan pelatihan pemasangan infus serta prosedur perawatan luka infus.

3.6.3 Tim PKRS

Tabel Kinerja Produktifitas PKRS Tahun 2024

No	Hal	Target	Mei 2024	% bulan sebelumnya	Ket
1.	Produksi Leaflet baru	2x/bln	1 buah	$(1/2) \times 100\% = 1\%$ ↓1%	Ditingkatkan
2.	Produksi Poster/Flyer	4x/bln	9 buah	$(9/14) \times 100\% = 2\%$ ↓2%	Ditingkatkan
3.	Pembuatan Video	1x/bln	-	$(0/1) \times 100\% = 0\%$ ↓0%	Ditingkatkan
4.	Pembuatan Podcast/ Audio edukasi	2x/bln	-	$(0/0) \times 100\% = 0\%$ ↓0%	Ditingkatkan
5.	KIE Massa Radio Central	25x/bln tiap hari	10x putar	$(10/5) \times 100\% = 2\%$ ↑2%	Meningkat
6.	KIE WAG Komunitas	25x/bln tiap hari	5	$(5/5) \times 100\% = 1\%$ ↑1%	Meningkat
7.	Edukasi di sosmed (IG, FB)	25x/bln tiap hari	6	$(6/4) \times 100\% = 1.5\%$ ↑1.5%	Meningkat
8.	Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	4x/bln	5	$(5/1) \times 100\% = 5\%$ ↑5%	Meningkat
9.	Pemberdayaan Komunitas (DOLINA)	2x/bln	1	$(1/0) \times 100\% = 0\%$ ↓0%	Ditingkatkan (belum mulai kembali setelah libur hari raya)

Analisis :

1. Pembuatan video dan podcast pada bulan mei belum diproduksi
2. Komunitas Dolina belum sesuai target per bulan
3. Edukasi di sosmed hanya dilakukan dengan memposting poster belum terlaksana live Instagram.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Buat jadwal bulanan terkait program podcast dan pembuatan video, audio edukasi
2. Lakukan koordinasi dengan kepala ruang dan pj PKRS unit untuk menjadwalkan edukasi melalui sosmed dan edukasi langsung menggunakan audio central
3. Evaluasi tim dolina dan menjadwalkan lagi petugas, agar aktif ikut serta dalam pelaksanaan dolina.

Tabel Hasil Kinerja KIE Kelompok tiap Unit di RSPHS pada Bulan April Tahun 2024

No	Unit	Target	Mei
1.	IRNA 2A	8x/bln	-
2.	IRNA 2B	8x/bln	7x
3.	IRNA 3A	8x/bln	5x
4.	IRNA 3B	8x/bln	-
5.	ICU	8x/bln	-
6.	MATERNITAS	8x/bln	-
7.	PERINATOLOGI	8x/bln	-
8.	IRJA	8x/bln	-
9.	IGD	8x/bln	-
10.	GIZI	8x/bln	-
11.	LABORATORIUM	8x/bln	-
12.	RADIOLOGI	8x/bln	-
13.	FARMASI	8x/bln	-
14.	IKO	8x/bln	-

Analisis :

Petugas cenderung tidak melaksanakan edukasi sesuai target, hanya bebrapa unit yang melaksanakan

Rencana Tindak Lanjut :

1. Beri feedback dan followup petugas
2. Menindaklanjut karu dan pic pkrs yang bertugas
3. Menjadwalkan tiap minggu edukasi
4. Membuatkan jenjang peringkat agar petugas lebih semangat lagi untuk edukasi
5. Catat nama petugas/ unit yang tidak patuh dalam melakukan edukasi.

3.6.4 Tim Prognas

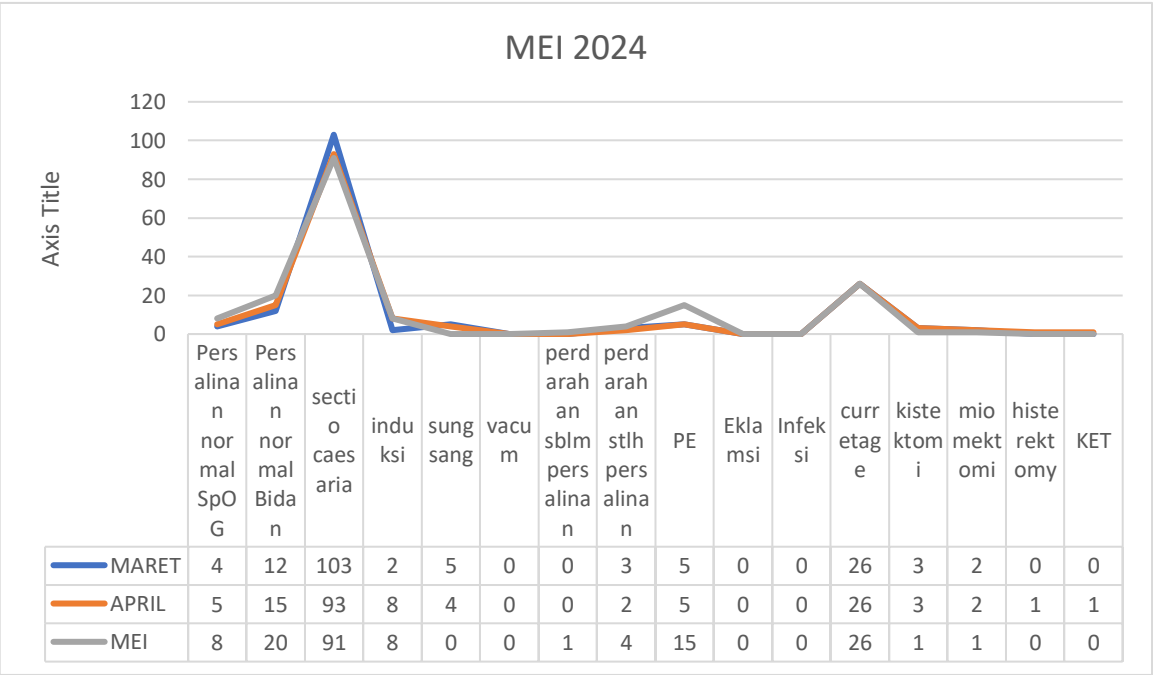
3.6.4.1 PONEK

A. Kegiatan Pelayanan Maternal

Tabel Kegiatan Pelayanan Maternal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	4	5	8
	b. Persalinan Normal Bidan	12	15	20
	c. <i>SectioCaesaria</i>	103	93	91
2	Persalinan dengan tindakan			
	a. Induksi / Drip	2	8	8
	b. Sungsang	5	4	0
	c. Vacum	0	0	0
3	Persalinan dengan Komplikasi			
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	2	4
	c. PE	5	5	15
	e.Eklamsi	0	0	0
	f. Infeksi	1	0	0
4	Kebidanan :			
	a. Curretage	26	26	26
	b. Kistektomi	3	3	1
	c. Miomektomi	2	2	1
	d. Histerectomy	0	1	0
	e. KET	2	1	0

Grafik Kegiatan Pelayanan Maternal



Evaluasi :

- Persalinan normal dengan Sp.Og untuk bulan april jumlahnya naik

- dari bulan kemarin karena persalinan bulan ini banyak dilakukan tindakan SC sesuai dengan indikasi
2. Terjadinya kenaikan persalinan dengan bidan dari bulan sebelumnya dikarenakan rujukan yang datang ke IGD merupakan rujukan yang membutuhkan Tindakan SC kegawatdaruratan
 3. Untuk kasus persalinan sc dalam bulan ini turun dari bulan kemarin, karena rujukan emergency dari IGD turun
 4. Persalinan dengan induksi naik bulan sebelumnya. Untuk induksi sendiri di berikan kalau benar-benar ada indikasi yang sesuai dengan kriteri dilakukan induksi supaya pasiennya aman.
 5. Kasus persalinan sungsang bulan ini turun dari bulan sebelumnya, dan itu lodingan dari poli yang sudah jauh-jauh hari sudah di rencanakan operasi dan ada pula yang dari rujukan.
 6. Tidak ada kasus persalinan dengan tindakan persalinan dengan vacuum tidak pernah dilakukan.
 7. Kasus perdarahan sebelum persalinan untuk bulan ini tidak ada.
 8. Kasus perdarahan setelah melahirkan pada bulan April turun dari bulan sebelumnya dan merupakan pasien post sc yang kontraksinya kurang maksimal.
 9. Pasien dengan Preeklampsia bulan ini jumlahnya sama dengan bulan sebelumnya dan kebanyakan pasien rujukan dari bidan atau klinik.
 10. Infeksi pada bulan ini tidak ada.
 11. Tindakan curretage bulan ini sama dengan bulan sebelumnya
 12. Tindakan miomektomi pada bulan ini sama dengan bulan sebelumnya.
 13. Tindakan kistektomi pada bulan ini sama dengan bulan sebelumnya.
 14. Kasus histerektomi untuk bulan ini naik dari bulan sebelumnya.
 15. Kasus KET pada bulan april lebih banyak dari bulan sebelumnya.

Rencana dan Tindak Lanjut

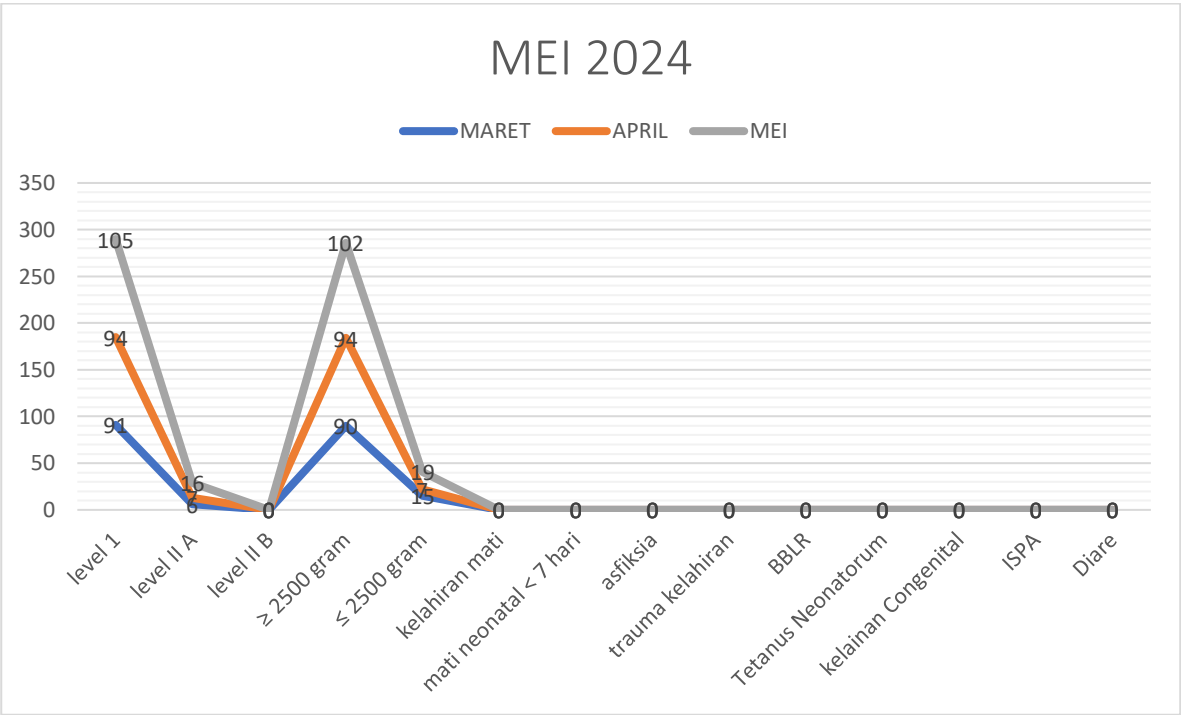
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit untuk melakukan promosi dan mengenalkan dokter-dokter obgyn yang ada di prima husada sukorejo
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya kehamilan di trimester 1, 2 dan 3 kehamilan.
3. Mengadakan kelas ibu hamil dan memberi materi dan edukasi terkait kehamilan dan persalinan

B. Kegiatan Pelayanan Neonatal
Tabel Kegiatan Pelayanan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	Jumlah pasien neonatal			
	d. Level 1	91	94	105
	e. Level II A	6	7	16
	f. Level II B	0	0	0
2	Bayi Lahir Hidup			
	c. ≥ 2500 gram	90	94	102
	d. ≤ 2500 gram	15	7	19

3	Kematian neonatal			
	c. Kelahiran Mati	0	0	0
	d. Mati Neonatal < 7 Hari	0	0	0
4	Sebab Kematian Neonatal			
	a. Asphyxia	0	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	0	0	0
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

Grafik Kegiatan Pelayanan Neonatal



Evaluasi

1. Untuk perawatan bayi level 1 bulan ini naik dari bulan sebelumnya karena jumlah persalinan bulan ini juga naik
2. Perawatan bayi level II A Naik dari bulan sebelumnya dan bayi hanya membutuhkan incubator saja. Hal ini di karenakan rata-rata bayi sehat dan Sebagian besar rawat gabung.
3. Perawatan bayi level II B tidak ada bulan ini.
4. Terdapat kenaikan jumlah di bulan ini untuk bayi yang BB nya lebih dari 2500 karena jumlah persalinan bulan ini juga naik.
5. Untuk bulan ini jumlah bayi lahir hidup dengan berat badan ≤ 2500 gram jumlahnya menurun dengan bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kasus partus prematurus imminens (PPI) pada ibu hamil
6. Untuk kelahiran mati bulan ini tidak ada atau nihil
7. Untuk kematian neonatal < 7 hari pada bulan ini tidak ada sama sekali
8. Bayi yang meninggal dengan untuk bulan ini tidak ada.

Rencana dan Tindak Lanjut

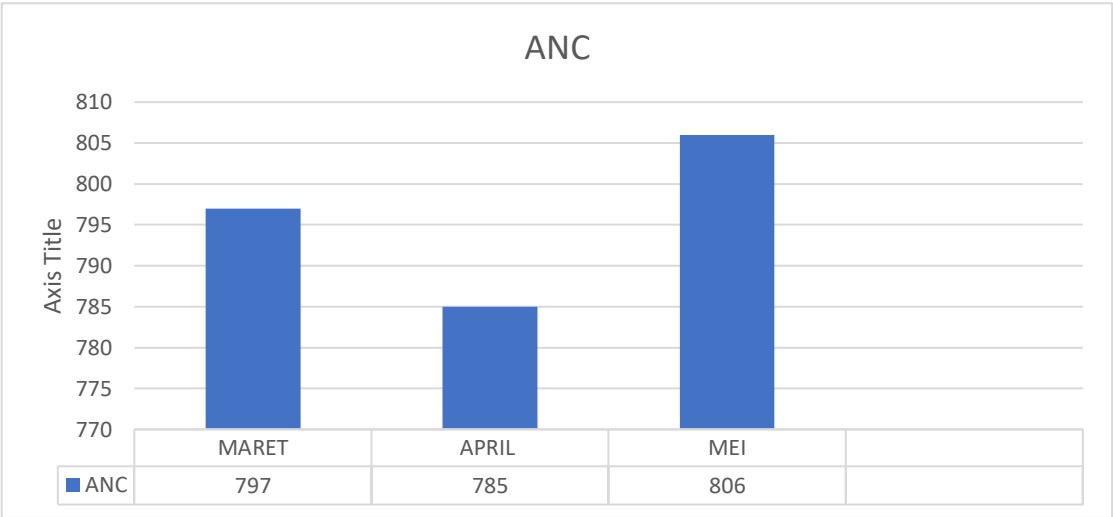
1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi dan persiapan persalinan agar tidak terjadi infeksi neonatus karena ketuban mekonial

C. Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel Pelayanan ANC

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	ANC	797	785	806

Grafik Pelayanan ANC



Evaluasi

Terdapat kenaikan jumlah pelayanan Ante Natal Care, pada bulan Mei 2024 sebanyak 806 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut

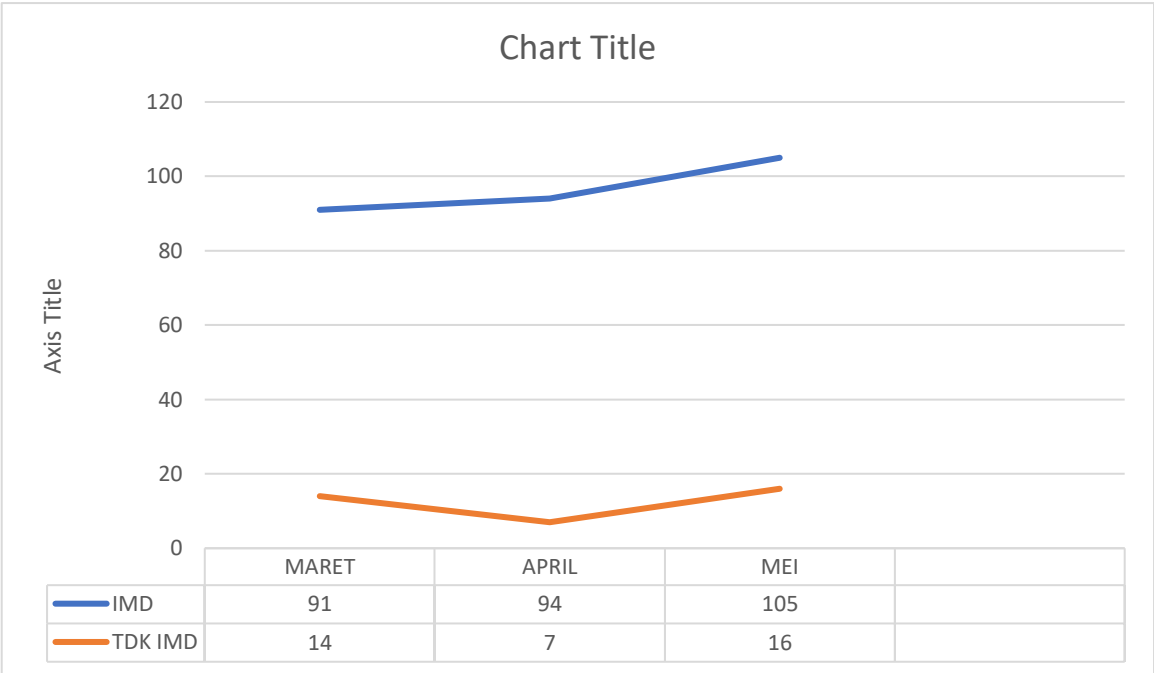
Melakukan promosi terkait senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya

D. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel Data IMD

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		BULAN MEI 2024
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	
1	IMD	91	94	105
2	Tidak IMD	10	7	16

Grafik Data IMD



- Evaluasi**
1. Dalam pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk bulan ini jumlahnya naik dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kelahiran di rumah sakit prima husada Sukorejo dan bayi dalam keadaan sehat sehingga bisa memungkinkan untuk dilakukan IMD.
 2. Terjadi kenaikan dalam pelayan tidak dilakukan IMD. Hal ini dikarenakan bayi tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD atau bayi sakit.

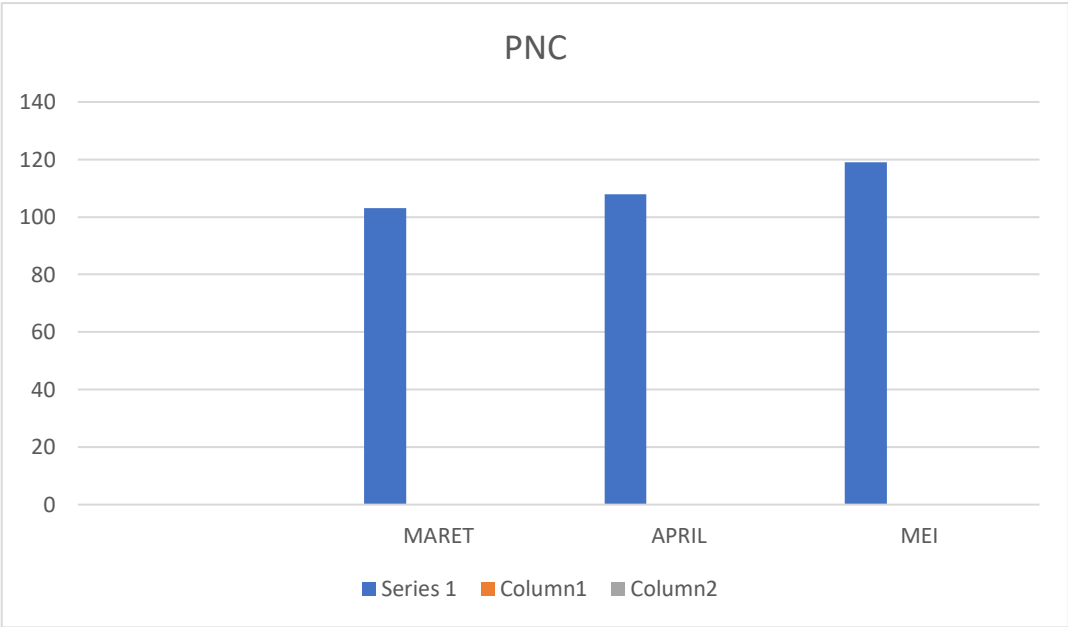
Rencana dan Tindak Lanjut
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak

E. Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel Pelayanan PNC

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	PNC	103	108	119

Grafik Pelayanan PNC



Evaluasi

Terdapat kenaikan jumlah kunjungan pasien PNC pada bulan ini sebanyak 119 pasien. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pasien bersalin di rumah sakit prima husada sukorejo.

Rencana dan Tindak Lanjut

Melakukan promosi kegiatan tentang pelayanan post natal Care, dengan bekerjasama dengan bidan sekitar rumah sakit.

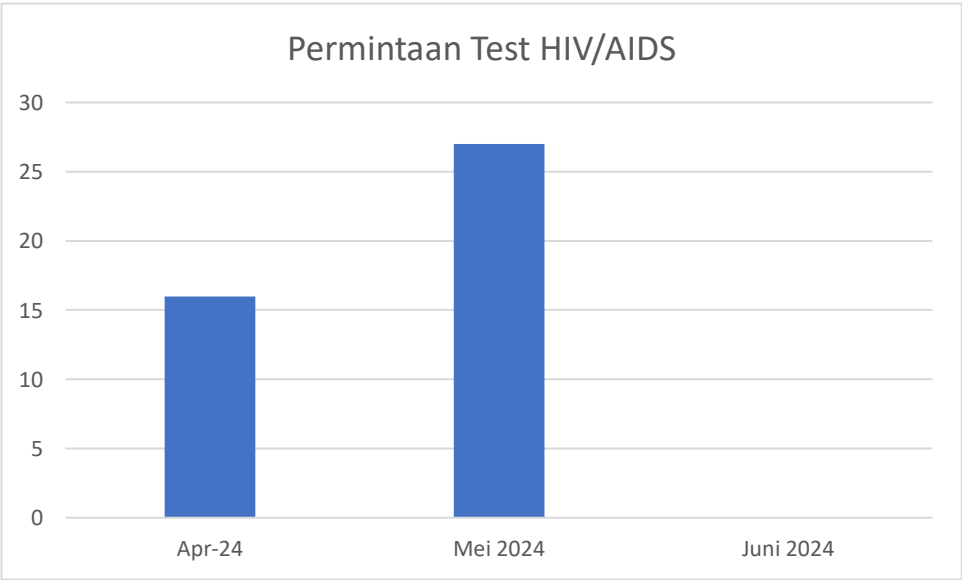
3.6.4.2 HIV

1. Jumlah permintaan Tes HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		April 2024	Mei 2024	Juni 2024
1	Permintaan Test HIV/AIDS	16	27	0

GRAFIK 1

JUMLAH PERMINTAAN TEST HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN MEI 2024



Analisis Jumlah Permintaan Test HIV/AIDS:

Pada bulan April 2024 terdapat 16 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Mei 2024 terdapat 27 permintaan testing HIV/AIDS.

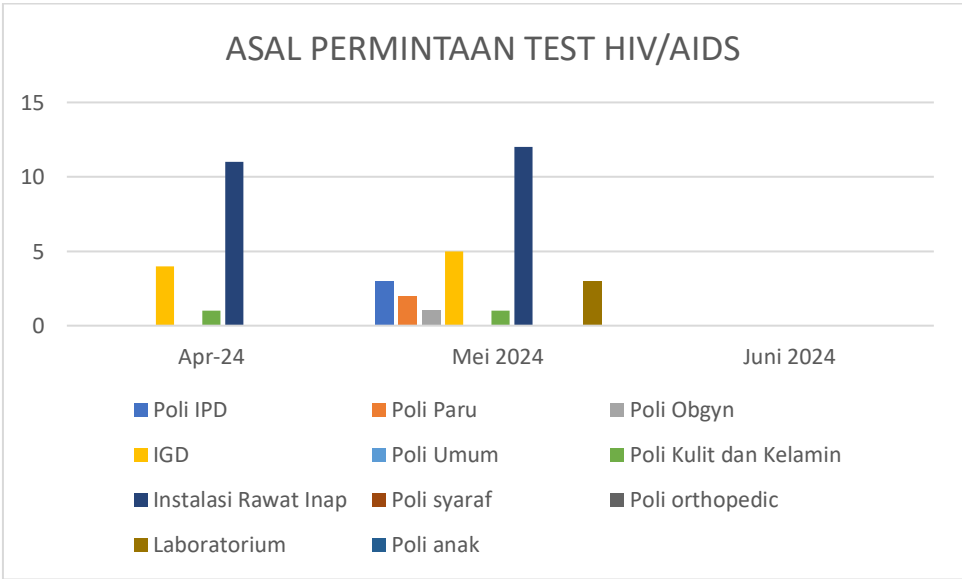
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
- 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
- 4. Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.
- 5. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasien TB yang status HIV nya tidak diketahui
- 6. Melakukan edukasi dan sosialisasi terduga TB yang status HIV nya tidak diketahui.

2. ASAL PERMINTAAN TES HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		April 2024	Mei 2024	Juni 2024
1	Poli IPD	0	3	0
2	Poli Paru	0	2	0
3	Poli Obgyn	0	1	0
4	IGD	4	5	0
5	Poli Umum	0	0	0
6	Poli Kulit dan Kelamin	1	1	0
7	Instalasi Rawat Inap	11	12	0
8	Poli syaraf	0	0	0
9	Poli orthopedic	0	0	0
10	Laboratorium	0	3	0
11	Poli anak	0	0	0

GRAFIK 2
JUMLAH ASAL PERMINTAAN TEST HIV/AIDS



Analisis Asal Permintaan Tes HIV/AIDS

Kenaikan permintaan test HIV/AIDS terdapat di IGD pada bulan Mei 2024.

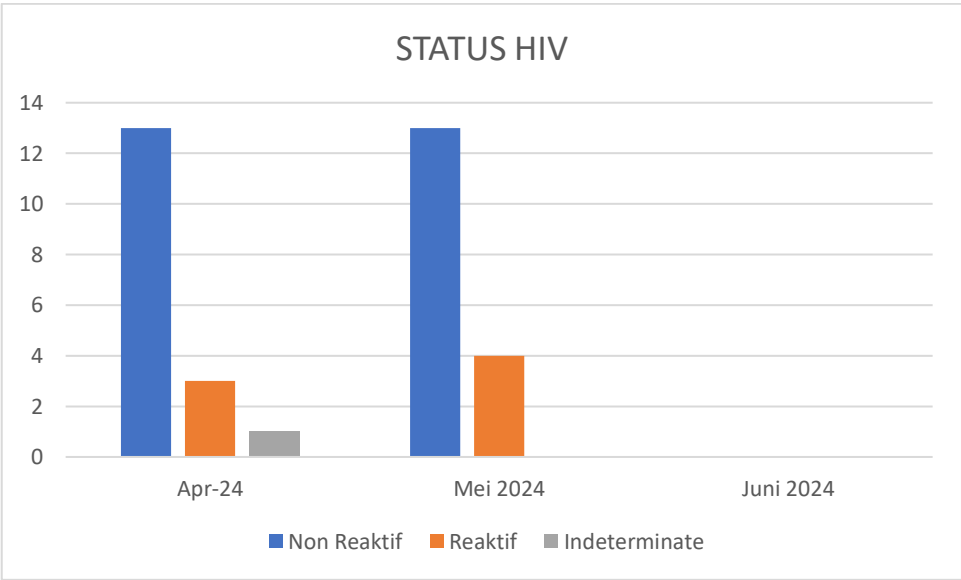
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
- 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
- 4. Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.

3. STATUS HIV

No	URAIAN	BULAN		
		April 2024	Mei 2024	Juni 2024
1	Non Reaktif	13	13	0
2	Reaktif	3	4	0
3	Indeterminate	1	0	0

GRAFIK 3
STATUS HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA



Analisis Status HIV/AIDS:

Pada bulan April 2024 terdapat 13 non reaktif HIV/AIDS, 3 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 indeterminate. Pada bulan Mei 2024 terdapat 13 non reaktif HIV/AIDS, 4 pasien reaktif HIV/AIDS dan 0 indeterminate.

- a. Apabila hasil positif : Bila hasil A1 reaktif. A2 rektif dan A3 reaktif
Apabila hasil Negatif :
 - 1. Bila hasil A1 non reaktif
 - 2. Bila hasil A1 reaktif tapi pada pengulangan A1 dan A2 non reaktif
 - 3. Bila salah satu reaktif tapi tidak berisiko dan apabila Hasil indeterminate

1. Bila dua hasil reaktif
2. Bila hanya 1 tes reaktif tapi berisiko atau pasangan berisiko

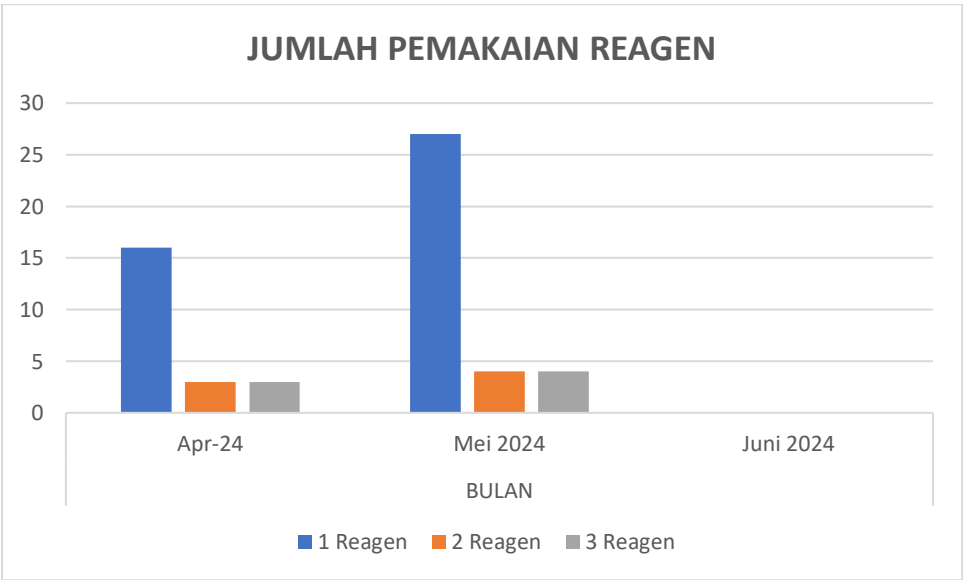
Rencana Tindak Lanjut:

1. Tindak lanjut hasil positif
 - a. Rujuk ke pengobatan HIV
2. Tindak lanjut hasil negatif
 - a. Bila hasil negatif dan berisiko dianjurkan pemeriksaan ulang minimum 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama
 - b. Bila hasil negatif dan tidak berisiko dianjurkan perilaku sehat
3. Tidak lanjut hasil indeterminate
 - a. Tes perlu diulang dengan spesimen baru minimum setelah dua minggu dari pemeriksaan yang pertama
 - b. Bila hasil tetap indeterminate, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR
 - c. Bila tidak ada akses ke pemeriksaan PCR, rapid tes diulang 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama.
 - d. Bila sampai setahun tetap “indeterminate” dan faktor risiko rendah, hasil dinyatakan sebagai negative.

4. JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN

No	URAIAN	BULAN		
		April 2024	Mei 2024	Juni 2024
1	1 Reagen	16	27	0
2	2 Reagen	3	4	0
3	3 Reagen	3	4	0

GRAFIK 4
JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA



Analisis jumlah pemakaian reagen:

Pada bulan April 2024 terdapat 16 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 3 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 3 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan Mei 2024 terdapat 27 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 4 pasien yang menggunakan

jenis reagen 2 dan 4 pasien menggunakan jenis reagen 3.

Rencana tindak lanjut:

- 1. Pemeriksaan dilakukan secara serial dengan menggunakan 3 jenis reagen yang berbeda sesuai dengan pedoman nasional.
- 2. Penyimpanan reagen HIV dilakukan sesuai dengan instruksi yang tertera dilembar informasi dan digunakan sebelum tanggal kedaluwarsa.

5. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		April 2024	Mei 2024	Juni 2024
1	Pelayanan Rujukan	0	0	0

GRAFIK 5
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS
DI RUMAH SAKIT PRIMAHUSADA



Analisis Pelayanan rujukan pasien dengan HIV/AIDS
Pada bulan April 2024 ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV.
Pada bulan Mei 2024 ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV

Rencana Tindak Lanjut:

Penemuan kasus HIV lebih dini meningkatkan akses perawatan dan pengobatan yang memadai sehingga mengurangi angka kematian.

a. KUNCI INDIKATOR MUTU HIV/AIDS

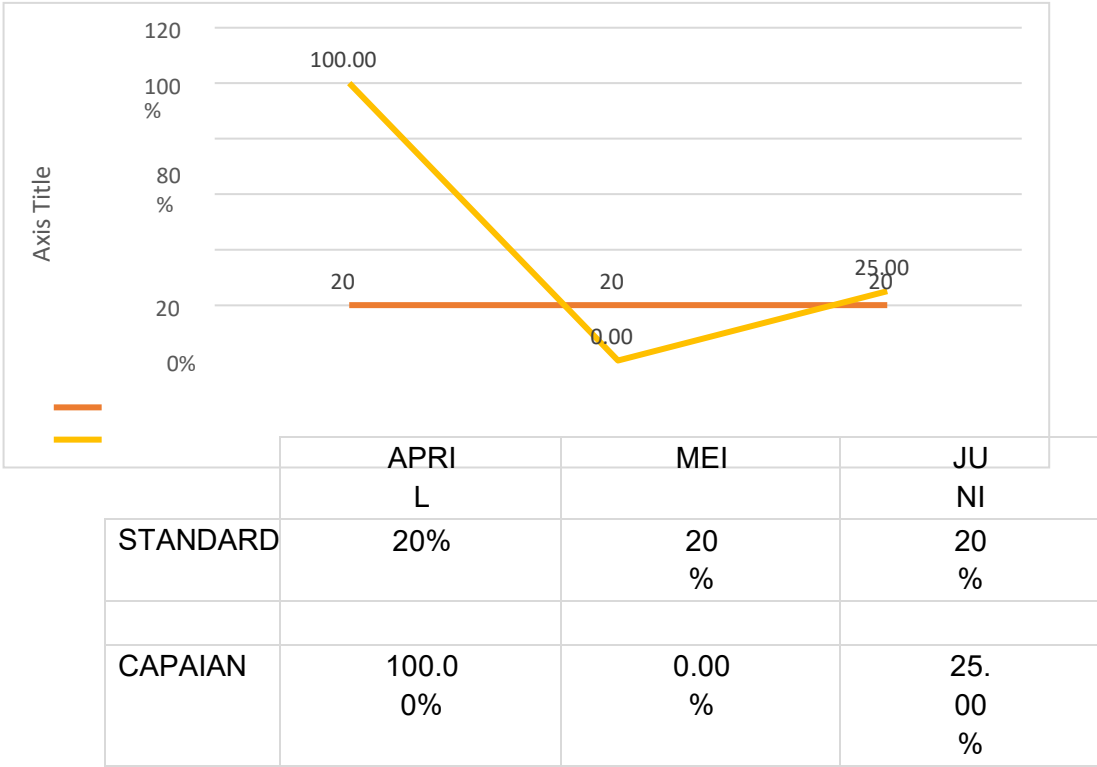
INDIKATOR MUTU	MAR	APR	MEI
Kejadian tidak teridentifikasi pasien HIV pada pasien bedah	0%	0%	0%
Angka kesakitan HIV/ AIDS	100%	0%	0%

GRAFIK 6

KUNCI INDIKATOR MUTU ANGKA KESAKITAN HIV/ AIDS

DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

BULAN **MEI 2024**

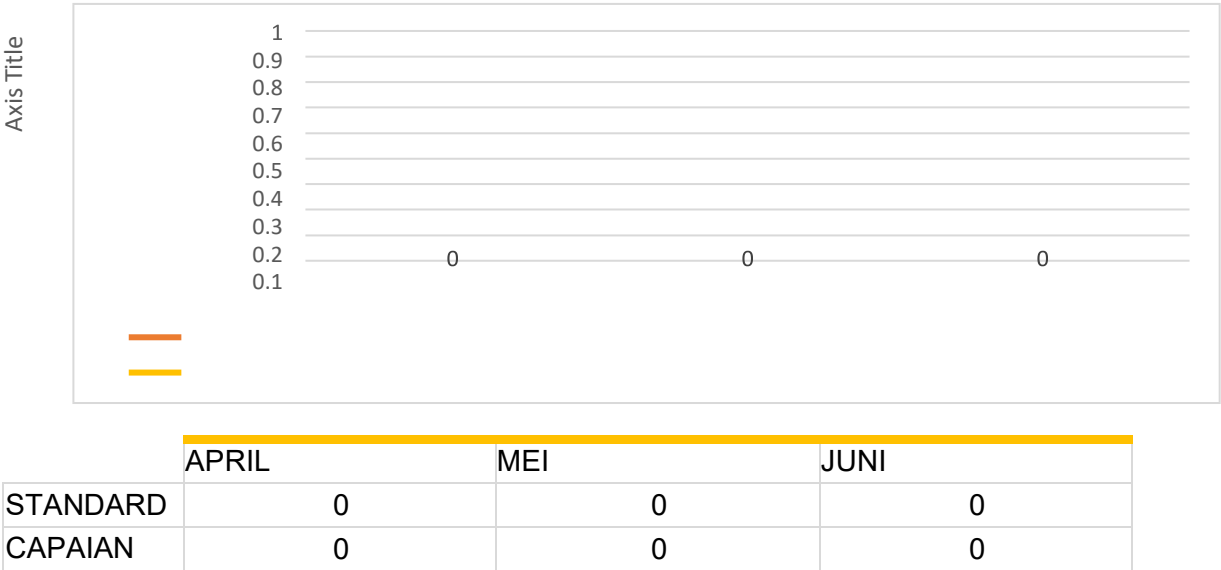


GRAFIK 7

KUNCI INDIKATOR MUTU KEJADIAN TIDAK TERIDENTIFIKASI PASIEN HIV/AIDS

PADA PASIEN BEDAHDI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

BULAN **MEI 2024**



Analisis kunci indikator mutu HIV/AIDS:

Pada bulan April 2024 ada 3 angka kesakitan HIV/AIDS.

Rencana Tindak Lanjut:

- a. Melakuakn upaya pencegahan meliputi beberapa aspek yaitu penyebaran informasi, promosi penggunaan kondom, skrining darah pada donor darah, pengendalian IMS.
- b. Mengedukasi dan penyebaran informasi perlu menekankan manfaat tes HIVdan pengobatan ARV.
- c.

II. KESELAMATAN KERJA

No	Kejadian	Risiko	Upaya mencegah risiko	Bulan		
				Apr 24	Mei 24	Jun 24
1	Petugas Tertusuk jarum	Terinfeksi	Menggunakan one hand untuk menutup spuit	0	0	0

GRAFIK 8

KESELAMATAN KERJA HIV/AIDS DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI-MARET 2024



Analisis Keselamatan kerja:

Pada bulan April 2024 tidak ada petugas yang tertusuk jarum. Pada bulan Mei 2024 tidak ada petugas yang tertusuk jarum.

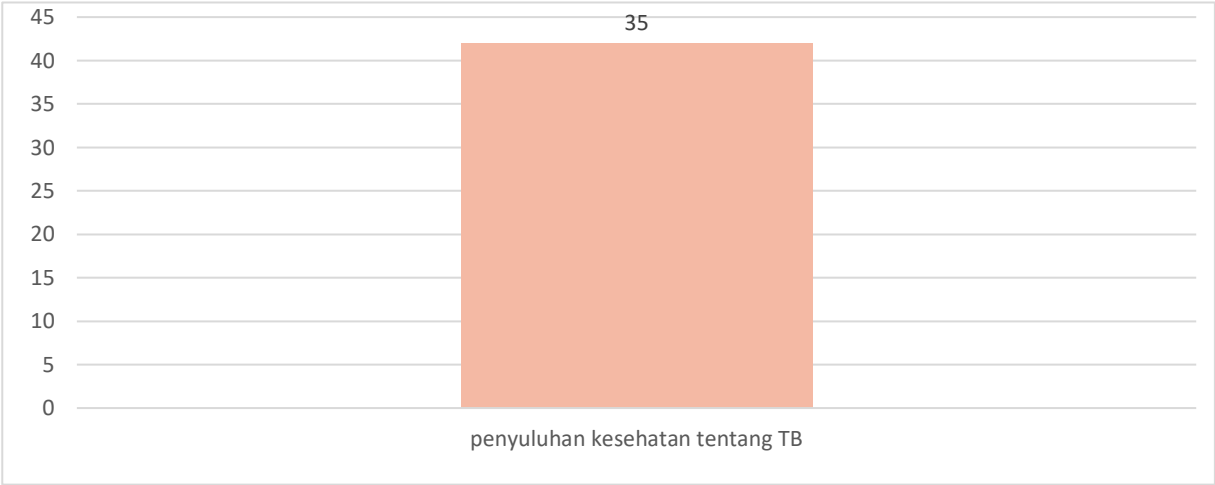
Rencana Tindak Lanjut:

- a. Perlindungan dan kesehatan karyawan dengan melaksanakan tatalaksana pasca pajanan
- b. Praktik penyuntikan yang aman.
- c. Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.4.3 TB DOTS

A. Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien
		Mei
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	35



Evaluasi :

Pada bulan Mei 2024 ini dilakukannya promosi kesehatan dengan cara offline.

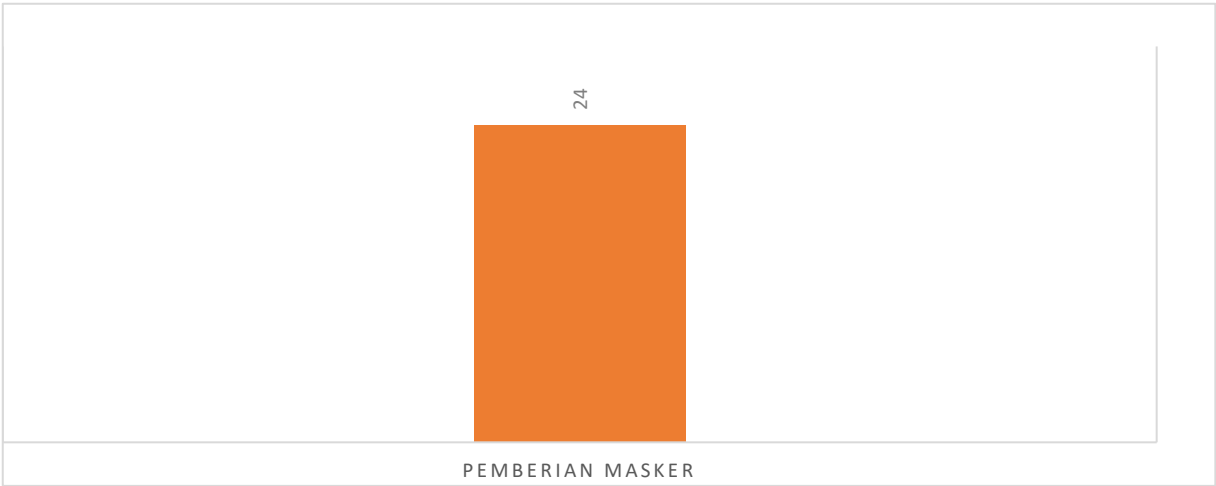
Rencana dan Tindak Lanjut

Meningkatkan promosi Kesehatan pada pasien paru di poli tentang tuberculosis

B. Skrining Pasien

No	Jenis Skrining	Jumlah Pasien
		Mei
1.	Pemberian Masker	24

Grafik 2
Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada
Bulan Mei2024



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Mei 2024 pasien sudah terbiasa memakai masker sehingga pemberian masker pada pasien sebanyak 24 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut

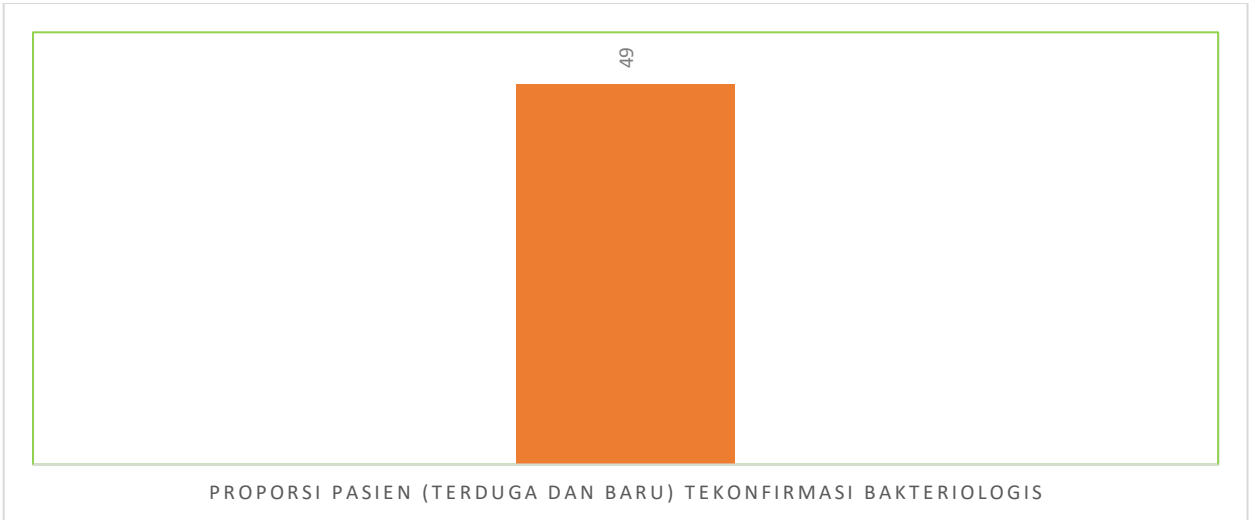
- 1) Memfasilitasi ketersediaan masker

- 2) Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

C. Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

No	Jenis skrining	Jumlah Pasien
		April
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	49 Pasien

Grafik 3
Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Di RS Prima Husada Bulan April 2024



Evaluasi :

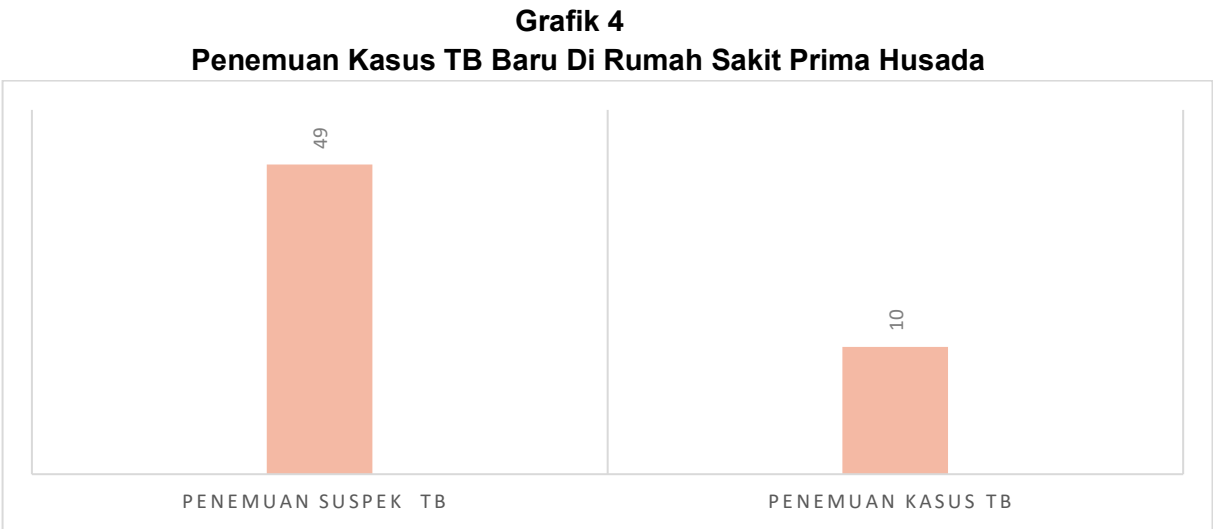
- 1) Pada bulan Mei terjadi penurunan jumlah proporsi Pasien terduga TB dengan Pasien baru TB terkonfirmasi bakteriologis,

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

D. Penemuan Kasus TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		April
1.	Penemuan suspek TB	49
2	Penemuan kasus TB	10



Evaluasi

- 1) Di bulan april terjadi peningkatan Kembali jumlah suspek TB dan kasus TB positif.
- Rencana Dan Tindak Lanjut**
- 1) Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

E. Pemberian Obat Pencegahan

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		April
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0

Grafik 5
Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima Husada Mei 2024



- Evaluasi :**
- 1) Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

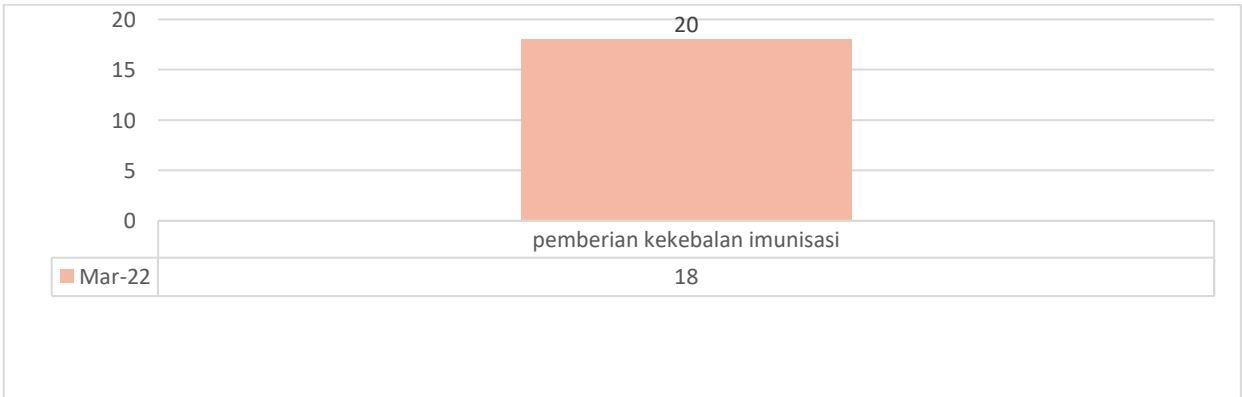
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2) Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

F. Pemberian Kekebalan Imunisasi

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		April
1.	Pemberian kekebalan imunisasi	20

Grafik 6
Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada Bulan April 2024



- Evaluasi :**

- 1) Pemberikan kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi dibulan Mei 2024 meningkat terdapat 20 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
2) Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya.

G. Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		Mei
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%

Grafik 7

Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Evaluasi :

- 1) Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

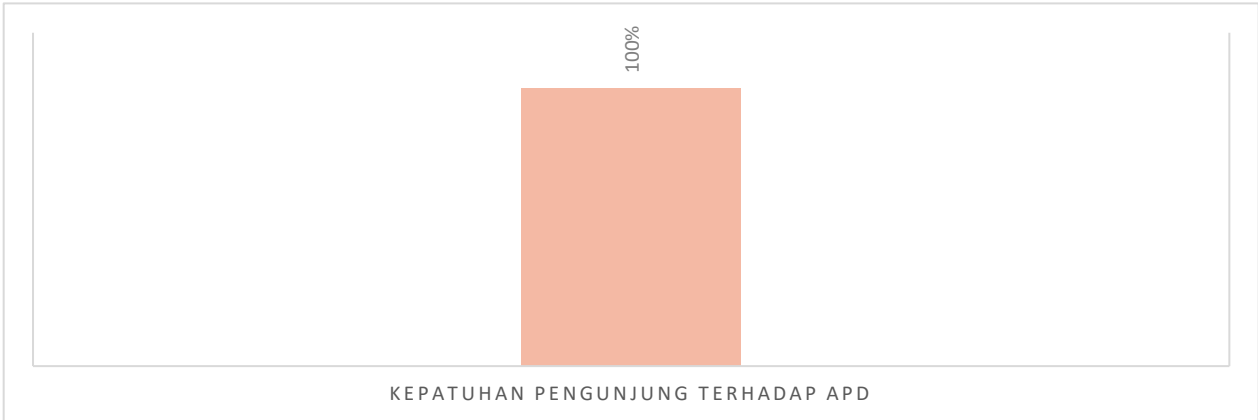
- 1) Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

H. Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		Mei
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%

Grafik 8

Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada Bulan April 2024



Evaluasi :

- 1) Kemudian pada bulan Mei kepatuhan terhadap penggunaan APD terus stabil dalam kepatuhan penggunaan APD

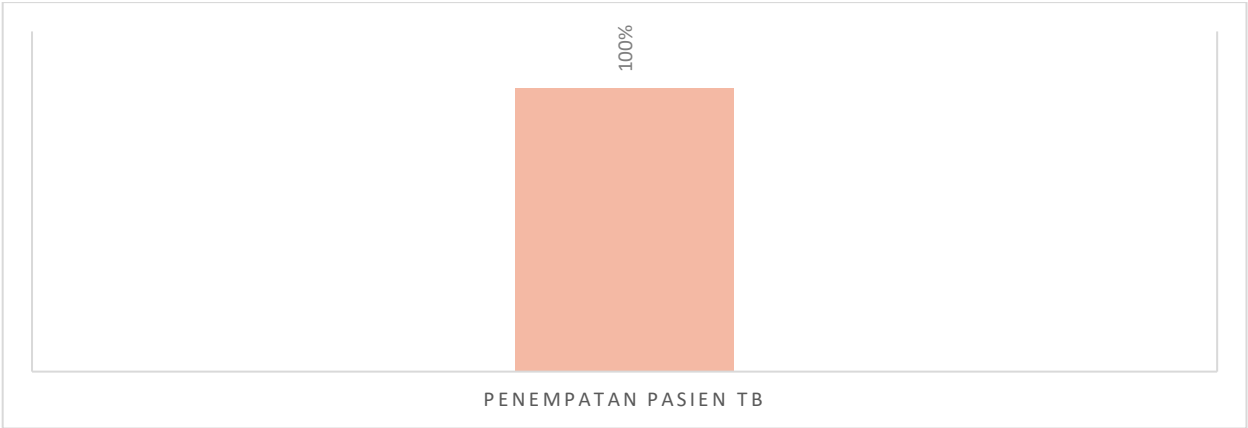
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi.

I. Penempatan Pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		Mei
1.	Penempatan pasien TB	100%

Grafik 9
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Evaluasi :

- 1) Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.
- 2) Dari bulan ke bulan mengalami stabilitas yang baik dalam penempatan pasien TB diruang isolasi.

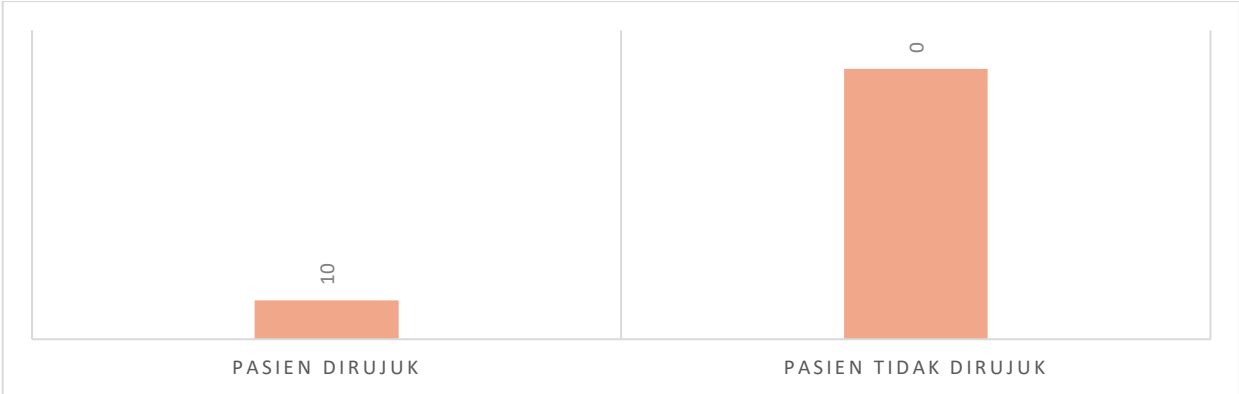
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan penempatan dengan benar

j. Pasien TB Yang Di Rujuk

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		April
1.	Pasien TB yang dirujuk	10
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	0

Grafik 10
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan april 2024



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Mei 2024 tidak pasien yang dirujuk.

Rencana dan Tindak Lanjut :

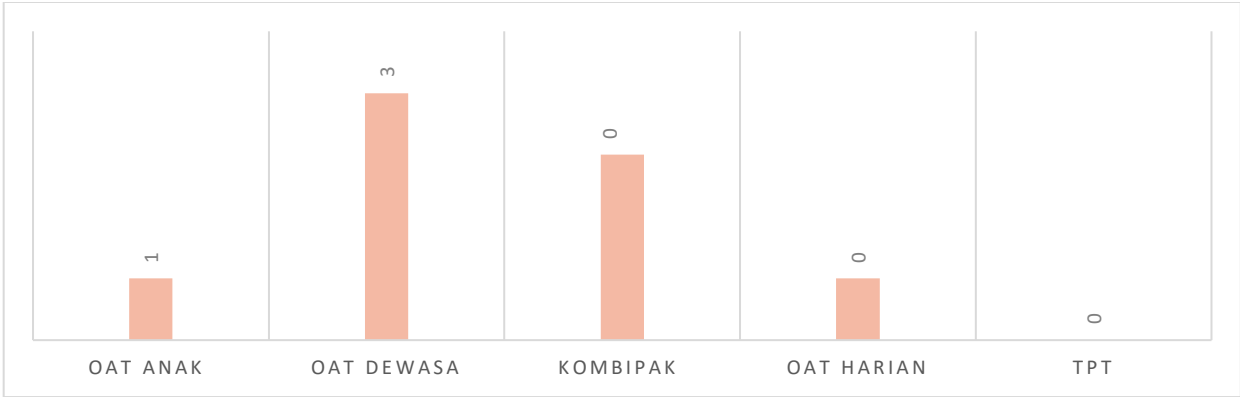
- 1) Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

k. Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		April
1.	OAT Anak	1
2.	OAT Dewasa	3
3.	Kombipak	0
4.	OAT Harian	0
5.	TPT	0

Grafik 11

Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Evaluasi :

- 1) Setiap 3 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinas kesehatan

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Menetapkan pengambilan obat setiap ada pasien tb baru

l. Pasien paru dan ekstra paru

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		maret
1.	Pasien paru	6
2.	Pasien Ekstra paru	4

Grafik 12
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024

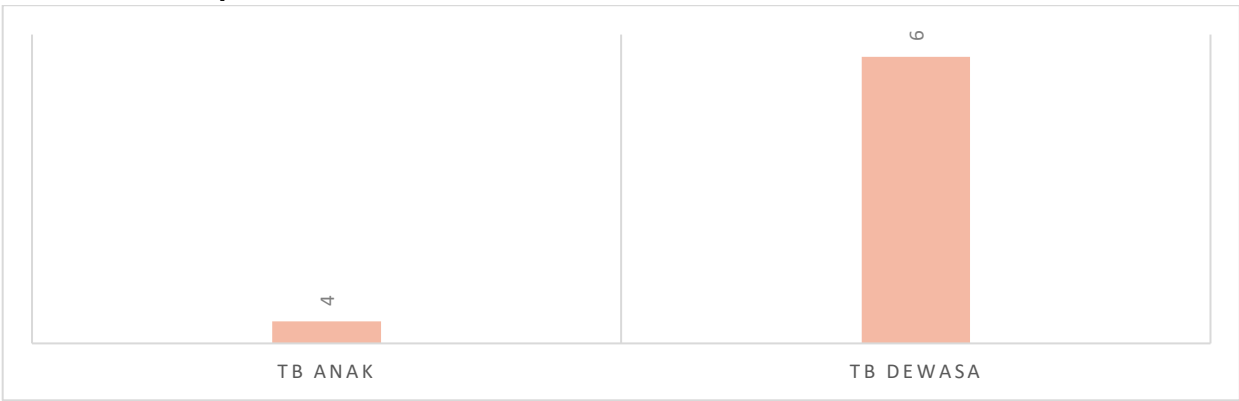


- Evaluasi :
- 1) Di bulan Mei pasien TB paru dan ekstra paru sudah disesuaikan dengan tempat nya
- Rencana dan Tindak Lanjut :
- 1) Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

m. Pasien Anak Dan Pasien Dewasa

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		Mei
1.	Pasien Anak	4
2.	Pasien Dewasa	6

Grafik 13
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024

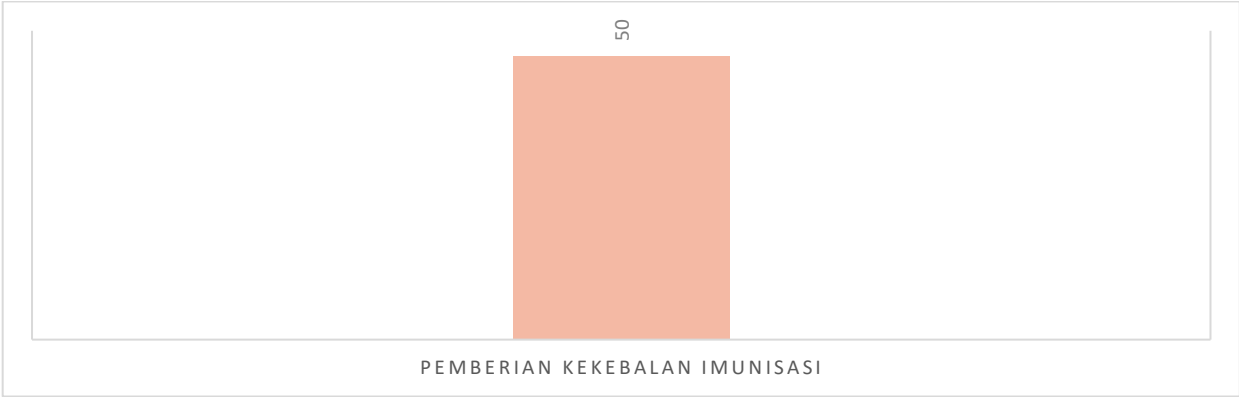


- Evaluasi :
- 1) Pada bulan Mei tidak ada pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien
- Rencana dan Tindak Lanjut :
- 1) Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

n. Pasien TB Keseluruhan Dengan Kategori

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		April
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	50

Grafik 14
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2024



- Evaluasi :**
- 1) Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC
- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1) Mempertahankan penempatan dengan benar

o. Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1	dr. Novita Maulidya, Sp. P	Tn. A	V		
		Tn. R	V		
		Tn. W	V		
2	dr. Fitri Indahyanti, Sp. P	Tn.. H	V		
		Ny. T	V		
		Ny. F	V		
		Ny. S	V		

- Evaluasi :**
- 1) Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan.
- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1) Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Sukorejo

3.7 Permasalahan Rumah Sakit Rumah Sakit

1. Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

No	Permasalahan	Analisa	
1	Tidak tertempelnya stiker penggunaan implant pada rekam medis pasien	P	1. Membuat checklist kelengkapan DRM operasi dengan pemasangan implant 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh staf IKO
		D	1. Melengkapi checklist kelengkapan DRM operasi yang terpasang implant 2. Sosialisasi kepada seluruh staf
		S	Monitoring dan evaluasi.
		A	1. Penempelan checklist kepengkapan DRM operasi yang terpasang implant 2. Sosialisasi kepada seluruh staf IKO
2	Ditemukan barang tidak ada permintaan atau penginputan tapi barang diberikan ke IKO yaitu jenis barang Lidocain	P	1. Berkoordinasi dengan Kabid penunjang dan ka ins farmasi dalam proses cek barang yang akan di serahkan ke unit 2. Berkoordinasi dengan farmasi dalam pengembalian obat yang tida sesuai dengan permintaan IKO
		D	1. Rapat koordinasi dengan kabid dan Ka Inst Farmasi dalam permaikan cek barang sebelum sertim dengan IKO 2. Pengembalian obat yang tidak sesuai dengan penginputan
		S	Monitoring dan evaluasi.
		A	1. Rapat koordinasi dalam perbaikan sistem [engecek kan barang sebelum sertim 2. Pengembalian obat yang tidak sesuai dengan permintaan.

2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Permasalahan	Analisa	
1	Ketidapatuhan dr IGD untuk mengisi ERM RJ	P	1. Mengadakan pelatihan pengisian ERM Irja IGD 2. Koordinasi dengan programmer untuk pembuatan video tutorial cara pengisian ERM irja IGD 3. Mengingatkan dokter IGD untuk mengisi lengkap ERM Irja
		D	1. Pelatihan ERM Irja IGD 2. Pembuatan video tutorial ERM Irja 3. Menegur dokter IGD yang tidak mengisi lengkap
		S	Monitoring dan evaluasi

		A	1. Monitoring Evaluasi kepada dokter untuk pengisian ERM 2. Melakukan zoom dengan dokter review ulang pengerjaan ERM
--	--	----------	---

3. Permasalahan Rawat Inap

No	Unit	Permasalahan	Analisa	
1	2A	IKP petugas tidak memberikan obat sesuai advis DPJP	P	Melakukan sosialisasi ulang terkait pemberian obat sesuai 5 Benar
			D	1. Melakukan koordinasi dengan staf yang ada di Unit setiap hari terkait advice dan penginputan obat 2. Melakukan observasi dalam alur pelayanan resep yang berpotensi muncul medication error sehingga menyebabkan terjadi kesalahan dalam pemberian obat
			S	Monitoring evaluasi
			A	1. Melakukan rapat pelaporan IKP 2. Mensosialisasikan ulang bagaimana pemberian obat yang sesuai 5B
2	2B	Pengunjung dan pasien yg merokok di area IRNA 2B	P	Mengedukasi pengunjung bahaya merokok di area RS dan bagi Kesehatan
			D	1. Mengingatkan pengunjung bahaya merokok di area RS 2. Koordinasi dengan tim security
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	1. Mengingatkan pengunjung bahaya merokok di area RS 2. Koordinasi dengan tim security
3	3A	Kerusakan fasilitas di ruangan	P	Fasilitas (AC, Tv tidak berfungsi dengan baik)
			D	1. Melakukan pendataan berapa kali ditemukan kejadian yang sama 2. Melakukan isi billing , koordinasi dengan tim IPSRS untuk segera perbaikan
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	1. Melakukan pendataan berapa kali ditemukan kejadian yang sama 2. Melakukan isi billing , koordinasi dengan tim IPSRS untuk segera perbaikan
4	3B	Masih ditemukan beberapa hand rel di ruangan yang rusak	P	Meminimalisir kejadian hand rel yang rusak
			D	1. Melakukan pendataan bed ruang mana saja yang rusak

				2. Melakukan koordinasi dengan IPSRS untuk perbaikan
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	1. Melakukan pendataan bed ruang mana saja yang rusak 2. Melakukan koordinasi dengan IPSRS untuk perbaikan

4. Permasalahan Rawat Jalan

No	Permasalahan	Analisa		
1	AC poli sering ditemukan bocor	P	1. Melakukan pendataan poli mana saja yang ac nya bocor 2. Melakukan penginputan billing kerusakan 3. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian sarana RS (IPSRS)	
		D	1. Melakukan penginputan billing kerusakan 2. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian sarana RS (IPSRS)	
		S	Monitoring evaluasi	
		A	1. Melakukan penginputan billing kerusakan 2. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian sarana RS (IPSRS)	
2	Alat dental unit poli gigi sering bermasalah sekalipun sudah sering dilakukan perbaikan	P	1. Melakukan pendataan dari terakhir kali atau berapa kali dental unit rusak 2. Melakukan penginputan billing kerusakan 3. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian sarana RS (IPSRS)	
		D	1. Melakukan penginputan billing kerusakan 2. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian sarana RS (IPSRS)	
		S	Monitoring evaluasi	
		A	1. Melakukan penginputan billing kerusakan 2. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian sarana RS (IPSRS)	

5. Permasalahan ICU

No	Permasalahan	Analisa		
1	Penunggu Keluarga Pasien sering menggelar tikar di depan ruang ICU karena tidak ada ruangan khusus untuk penunggu	P	Mensosialisasikan kepada keluarga pasien ICU bahwa dilarang menggelar tikar di depan ICU Melakukan koordinasi dengan security untuk penertiban tikar Mengingatkan keluarga pasien yan tampak menggelar tikar di depan ICU	
		D	1. Memberi edukasi pada keluarga pasien agar tidak menggelar tikar di area depan ruang ICU 2. Memberi teguran secara halus jika di temukan keluarga yang masih menggelar tikar	

2	Ketidakpatuhan DPJP dalam melengkapi form resume medik pada pasien yang meninggal dunia		3. Koordinasi dengan tim security
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Melakukan edukasi pada keluarga pasien agar tidak menggelar tikar di area depan ruang ICU 2. Melakukan peneguran secara halus jika di temukan keluarga yang masih menggelar tikar 3. Melakukan koordinasi dengan tim security
		P	1. Mendata DPJP siapa yang sering tidak melakukan kelengkapan isi DRM 2. Memberikan tanda (stik note) pada DRM bagian DPJP
		D	1. Mendata DPJP siapa yang sering tidak melakukan kelengkapan isi DRM 2. Memberikan tanda (stik note) pada DRM bagian DPJP 3. Melaporkan kepada Kabid terkait hal ini agar bisa dilakukan teguran melalui Komite Medik
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Mendata DPJP siapa yang sering tidak melakukan kelengkapan isi DRM 2. Memberikan tanda (stik note) pada DRM bagian DPJP 3. Melaporkan kepada Kabid terkait hal ini agar bisa dilakukan teguran melalui Komite Medik

5. Permasalahan NICU

No	Permasalahan	Analisa	
1	Sensor Monitor sering tidak terdeteksi	P	1. Lapor IPSRS by SIM 2. Koordinasi dengan IPSRS terkait sensor monitor sering tidak terdeteksi
		D	1. Melakukan pendataan seberapa sering terjadi kerusakan 2. Melakukan isi billing dan lapor IPSRS untuk segera di tindak lanjut
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Melaporkan kepada IPSRS 2. Berkoordinasi dengan IPSRS terkait maintenance alat 3. Melaporkan kepada Kabid

2	Terdapat staff CS ketika mengepel lantai terlalu basah, sehingga bisa menyebabkan kejadian potensial cidera (KPC) seperti terpleset dan jatuh	P	1. Melakukan pengamatan seberapa sering lantai tampak basah setelah pembersihan 2. Melakukan koordinasi dengan kepala CS dan PPI untuk koseling pada staff terkait
		D	Sering ditemukan lantai yang terlalu basah pada ruang NICU dan ruang pasien sehingga menyebabkan Kejadian Potensial Cidera (KPC)
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	1. Melakukan pengamatan seberapa sering lantai tampak basah setelah pembersihan 2. Melakukan koordinasi dengan kepala CS dan PPI untuk koseling pada staff terkait

6. Permasalahan Maternitas

No	Permasalahan	Analisa	
1	Tidak ada billing tindakan tersendiri untuk pertolongan persalinan patologis dengan bidan seperti Gemelly dan sungsang untuk membedakan jaspel persalinan normal dan patologis	P	1. Melakukan koordinasi dengan kabid dan keuangan untuk dilakukan pengajuan penambahan inputan Tindakan 2. Mengajukan tarif persalinan normal patologis dengan bidan
		D	1. Melakukan koordinasi dengan kabid dan keuangan 2. Mengajukan penambahan inputan tindakan pada billing
		S	Sering ditemukan kasus persalinan patologis dengan bidan tetapi masih belum ada billing tindakan persalinan patologis dengan bidan (untuk pasien umum dan asuransi)
		A	1. Melakukan koordinasi dengan kabid dan keuangan 2. Mengajukan penambahan inputan tindakan pada billing
2	Terdapat staff CS ketika mengepel lantai terlalu basah, sehingga bisa menyebabkan kejadian potensial cidera (KPC) seperti terpleset dan jatuh	P	3. Melakukan pengamatan seberapa sering lantai tampak basah setelah pembersihan 4. Melakukan koordinasi dengan kepala CS dan PPI untuk koseling pada staff terkait
		D	Sering ditemukan lantai yang terlalu basah pada ruang NICU dan ruang pasien sehingga menyebabkan Kejadian Potensial Cidera (KPC)
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Melakukan pengamatan seberapa sering lantai tampak basah setelah

			pembersihan 2. Melakukan koordinasi dengan kepala CS dan PPI untuk koseling pada staff terkait
--	--	--	---

6. Permasalahan SDM

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Kredensial dan Rekredensial belum berjalan	P	Berkoordinasi dengan SDM (bagian komdik) untuk berkoordinasi dengan Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kerja Lain (KTKL) untuk diaktifkan ulang dengan mengaktifkan SK Komite atau melakukan Revisi SK Komite
		D	Melakukan sosialisasi jobdesk terkait masing-masing peran komite dalam pelaksanaan kredensial dan non kredensial dan melakukan telaah terkait form kredensial dan rekredensial yang telah berjalan
		S	Berdasarkan data yang ada kredensial dan rekredensial belum berjalan di Tahun 2024
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait : 1. Jumlah staf yang perlu di kredensial dan yang telah dikredensial 2. Memantau progress bulanan dari SDM dan komite
2	Evaluasi Staf belum berjalan	P	Berkoordinasi dengan SDM dan SDM PT untuk penyelarasan form evaluasi staf yang sudah diupdate dan kriteria atau kategori staf dinyatakan baik atau tidaknya dari form tersebut
		D	SDM melakukan sosialisasi terkait dengan form evaluasi yang telah disepakati bersama
		S	Data evaluasi staf di triwulan I Tahun 2024 belum berjalan
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan evaluasi staf karyawan

7. Permasalahan MFK dan K3RS

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Belum terdapat gudang alkes dan gudang barang umum	P	Berkoordinasi dengan PJ Alkes dan Umum terkait dengan Gudang
		D	Membuat telaah dengan permintaan penambahan Gedung alkes dan non

			alkes
		S	Berdasarkan permasalahan ini bahwa saat ini Gudang umum diletakkan di HD (Ex-ICu lantai 2) dan belakang toilet umum lantai 3, untuk Gudang alkes ditempatkan disebelah pemulasaraan jenazah (ruang komkep)
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penmabhan Gudang alkes dan non alkes
2	Staf di IPSRS dan ATEM kurang dengan proporsi alat yang ada di RS (Total alkes 314 buah)	P	Berkoordinasi dengan SDM dan Karu IPSRS
		D	Melakukan telaah dengan melihat evaluasi beban kerja dan form maintenance yang telah berjalan
		S	Pemeliharaan alkes di Bulan April dari 318 alkes, 234 alkes telah dipelihara (73.58%)
		A	Pengajuan penambahan staf dengan melakukan monitoring terkait jumlah maintenance dan repair alat yang telah berjalan

8. Permasalahan Security

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Layar pemantauan CCTV sebagian ada yang berada di IPSRS	P	Berkoordinasi dengan Karu IPSRS dan PJ Security serta IT untuk pemindahan layar pemantauan CCTV yang ada di IPSRS
		D	Melakukan telaah terkait risiko keamanan yang terjadi dan pengajuan sp pemindahan panel CCTV atau pengajuan SP Alat
		S	Berdasarkan supervisi yang ada dilapangan, bahwa untuk area belakang, CCTV masuk di IPSRS dan belum termonitoring di ruang pemantauan CCTV.
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemindahan CCTV dari panel lama IPSRS ke panel yang ada di ruang security (depan)
2	Angka Monitoring KTR cukup tinggi	P	Membuat punishment dari pengunjung atau penunggu yang merokok di RS minimal dengan 2x peringatan
		D	Melakukan pembuatan SE terkait larangan merokok dengan punishment yang ada
		S	Angka KTR di RS cukup tinggi : Angka perokok di Bulan Januari = 176 orang ; Februari = 100 orang ; Maret

			= 145 orang; April = 266 orang Angka putung rokok di Bulan Januari = 274 putung ; Februari = 165 putung ; Maret = 138 putung rokok dan April = 216 putung
		A	Melakukan monitoring dengan form patroli KTR oleh CCTV dan melakukan evaluasi
3	Pintu akses keluar masuk RS riskan terhadap keamanan	P	Berkoordinasi dengan Karu Security terkait
		D	Melakukan pembuatan SE terkait pembatasan akses pintu keluar masuk RS di jam-jam tertentu
		S	Terdapat angka kehilangan dan berisiko terhadap keamanan RS
		A	Melakukan monitoring evaluasi terhadap SE yang diberlakukan di pintu akses keluar masuk RS

9. Permasalahan Parkir

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Batako yang didaerah parkir banyak yang tidak rata	P	Berkoordinasi dengan Tukang untuk perbaikan batako
		D	Melakukan pencatatan titik progress untuk diperbaiki tukang
		S	Ada sekitar 4 titik yang perlu perbaikan terkait batako
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait progress pengerjaan perbaikan batako oleh tukang
2	Palang pintu masuk parkir motor sering error	P	Berkoordinasi dengan IPSRS dan IT untuk perbaikan
		D	Melakukan pencatatan oleh petugas parkir terkait angka kerusakan yang terjadi di Bulan tertentu
		S	Ada kejadian 3-4x palang membuka sendiri walaupun belum ada motor yang masuk
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait perbaikan palang pintu parkir masuk motor

10. Permasalahan Humas Marketing

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Belum ada Perjanjian Kerjasama	P	Berkoordinasi dengan Humas Marketing

	(PKS) update baik yang proses diperpanjang ataupun yang expired	D	Melakukan rekapan PKS baik yang on progress, yang expired dan berencana untuk diperpanjang ataupun IKS yang masih berlaku
		S	Hanya ada PKS yang masih berlaku sebanyak 63 PKS
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait progress pengerjaan PKS dari Humas Marketing

11. Permasalahan Penjaminan dan Klaim

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Keterlambatan pengiriman berkas resume dan penunjang dari unit	P	Berkoordinasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan
		D	Melakukan pencatatan terkait keterlambatan resume dan berkas penunjang dari unit
		S	Berdasarkan supervisi dari PIC Mutu verifikator terdapat angka resume dari IRNA 2B yaitu 17.53% dan berkas penunjang 1.81% terkait berkas penunjang di IRNA 3B
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait resume dan penunjang untuk kelengkapan berkas klaim

12. Permasalahan Cleaning Service

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1	Area taman banyak rumput liar ada beberapa tanaman yang sudah waktunya dibudidaya ulang	P	Berkoordinasi dengan PJ CS dan CS taman
		D	Melakukan target pembersihan rumput secara berkala setelah daily activity selesai dilakukan per area
		S	Berdasarkan supervisi yang ada dilapangan, area area taman perlu dilakukan perapian dan pemotongan rumput liar
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembersihan area taman
2	Kamar Mandi Umum bau tidak enak	P	Melakukan supervisi asal bau dari kamar mandi umum yang berasal dari BAB dan BAK yang biasanya tidak melalui toilet
		D	Melakukan pembersihan secara berkala minimal 30 menit sekali diluar area pelayanan lainnya
		S	Melakukan checklist toilet secara berkala
		A	Melakukan monitoring dengan PJ CS

3	Tidak ada Gudang untuk barang umum	P	Berkoordinasi dengan PJ Alkes dan Umum terkait dengan Gudang
		D	Membuat telaah dengan permintaan penambahan Gedung alkes dan non alkes
		S	Berdasarkan permasalahan ini bahwa saat ini Gudang umum diletakkan di HD (Ex-ICu lantai 2) dan belakang toilet umum lantai 3, untuk Gudang alkes ditempatkan disebelah pemulasaraan jenazah (ruang komkep)
		A	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penambahan Gudang alkes dan non alkes
4	Jobdesk masing-masing PJ masih belum berjalan maksimal	P	Berkoordinasi dengan coordinator CS
		D	Membuat rapat bulanan dan menjelaskan masing-masing jobdesk CS sesuai tupoksi
		S	Berdasarkan permasalahan ini bahwa terkait inventaris update belum ada, SPO pembersihan belum update dan tupoksi masing-masing CS belum berjalan
		A	Melakukan review terkait form inventaris CS, SPO update, monitoring dari PPI dsb

1.9 Kinerja Produktifitas Profil SDM
1.9.1 Ketenagaan
Distribusi SDM

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
1	Direktur	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
3	Kepala Bidang Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	0	1	0	0	1
4	Kepala Bidang Penunjang Medis	S1 Bidang Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1
5	Kepala Bidang Umum & Keuangan	S1 Bidang Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1
6	Staf Medis	Dokter Umum IGD	9	8	1	8	0	0	0	59
		Dokter Umum MCU	4	4	0	4	0	2	0	
		Dokter Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Emergency	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anak	3	3	0	2	1	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	4	0	3	1	0	0	
		Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Anak	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Plastik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Neurologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis	2	2	0	2	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Paru								
		Dokter Spesialis Mata	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kulit Kelamin	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis THT	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Urologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Gigi Anak	1	1	0	1	0	1	0	
		Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anestesiologi	3	3	0	2	1	0	0	
7	IRNA II A	D3 Keperawatan	23	12	0	11	1	0	0	22
		D4 Keperawatan		2	0	2	0	0	0	
		Profesi Ners		8	1	8	0	0	0	
8	IRNA II B	D3 Keperawatan	22	16	0	16	0	0	0	24
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		8	0	8	0	0	0	
9	IRNA III A	D3 Keperawatan	19	11	0	11	0	0	0	20
		D4		0	0	0	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Keperawatan								
		Profesi Ners		9	0	9	0	0	0	
10	IRNA III B	D3 Keperawatan	18	11	0	11	0	0	0	20
		D4 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		8	0	8	0	0	0	
11	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	3	0	3	0	0	0	4
		S1 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		0	5	0	0	0	0	
12	Maternitas	D3 Kebidanan	15	4	0	4	0	0	0	13
		D4 Kebidanan		7	0	6	2	0	1	
		S1 Kebidanan		2	2	2	0	0	0	
13	ICU	D3 Keperawatan	12	5	0	4	1	0	0	12
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		7	0	8	0	0	1	
14	NICU	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0	0	0	9
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		4	0	3	1	0	0	
15	IGD	D3 Keperawatan	27	12	0	12	0	0	0	27
		D3 Kebidanan		4	0	4	0	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		10	0	10	0	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
16	IKO	D3 Keperawatan	15	9	0	5	4	0	0	13
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		4	2	1	3	0	0	
17	IRJA	D3 Keperawatan	26	15	0	13	2	0	0	24
		D3 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		S1 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		Profesi Ners		6	2	4	2	0	0	
18	Rehab Medik	D3 Fisioterapi	5	1	0	1	0	0	0	5

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		D4/S1 Fisioterapi		4	0	4	0	0	0	
19	Farmasi	SMA/ SMK Farmasi	6	5	0	6	0	0	0	41
		S1 Admin Farmasi	1	1	0	1	0	0	0	
		D3 Farmasi	16	16	0	14	2	0	0	
		D3 Analis Farmasi	1	1	0	1	0	0	0	
		S1 Farmasi	6	6	0	6	0	0	0	
		Apoteker	12	12	0	11	1	0	0	
20	Rekam Medis	D3 RMIK	10	8	0	7	1	0	0	10
		D4 RMIK		2	0	2	0	0	0	
21	Pendaftaran	SMA/SMK	19	1	0	1	0	0	0	19
		D1		1	0	1	0	0	0	
		D3		7	0	7	0	0	0	
		D4		2	0	2	0	0	0	
		S1		8	0	8	0	0	0	
22	Laboratorium	D3 Analis Kesehatan	13	11	0	10	1	0	0	13
		D4 Analis Kesehatan		2	0	2	0	0	0	
23	Radiologi	SMA/SMK	8	0	0	0	0	0	0	8
		D3 Radiologi		8	0	6	2	0	0	
24	CSSD	SMA/SMK	5	3	0	3	0	0	0	5
		D3 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
		S1 Keperawatan		1	0	1	0	0	0	
25	Laundry	SMA/SMK	6	5	0	5	0	0	0	6
		D1		1	0	1	0	0	0	
26	Ahli Gizi	D3 Gizi	5	0	0	0	0	0	0	5
		D4 Gizi		2	0	2	0	0	0	
		S1 Gizi		3	0	2	1	0	0	
27	Dapur	SMA/SMK	10	10	0	9	1	0	0	10
28	Keuangan & Akuntansi	SMA/SMK	10	0	0	0	0	0	0	10
		D1		1	0	1	0	0	0	
		D3		0	0	0	0	0	0	
		S1		9	0	10	0	0	0	
29	SDM & Diklat	S1 Psikologi	3	2	0	2	0	0	0	3
		S1 Manajemen		0	0	0	0	0	0	
		S1 Kesehatan		1	0	1	0	0	0	
		S1 Lainnya		0	0	0	0	0	0	
31	Asuransi	SMA/SMK	13	1	0	1	0	0	0	13

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
	Center	D3 RMIK		7	0	7	0	0	0	
		D3 Asuransi Kesehatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 RMIK		1	0	1	0	0	0	
		D4 Asuransi Kesehatn		1	0	1	0	0	0	
		S1 Kesehatan / Lainnya		3	0	3	0	0	0	
32	Humas Marketing	S2 Manajemen Kesehatan	2	1	0	1	0	0	0	2
		S1 Marketing		1	0	1	0	0	0	
		D3 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
33	Sekretariat	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
35	Security	SMA/SMK	11	11	0	10	1	0	0	11
36	Parkir	SMA/SMK	0	11	0	11	0	4	0	12
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
37	Driver	SMA/SMK	7	6	1	6	0	0	0	6
38	Cleaning Service	SMA/SMK	42	41	0	40	1	0	0	42
		D3		1	0	1	0	0	0	
39	Tukang Operasional & Tukang Kebun	SMA/SMK	4	2	0	2	0	0	0	4
		SMP		1	0	1	0	0	0	
		SD		1	0	1	0	0	0	
40	IPAL/B3	SMA/SMK	3	3	0	3	0	0	0	3
41	IPSRs	SMA/SMK	4	3	1	2	1	0	0	4
		D3 ATEM	2	1	1	1	0	0	0	
42	Gudang Umum	S1	1	1	0	1	0	0	0	1
43	IT & SIMRS	D4 Teknologi Informasi	3	0	0	0	0	0	0	3
		S1 Teknologi Informatika		2	0	2	0	0	0	
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
44	PKRS	DIV Promosi Kesehatan	1	1	1	1	0	0	0	1
45	Mutu	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	2	0	0	1	2
46	PPI	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	0	1
47	K3RS	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	0	1
48	MOD/PIPP	D3 Keperawatan	5	1	0	1	0	0	0	4
		D3 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	1	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Profesi Ners		1	1	1	0	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
TOTAL			500	497	20	466	35	7	2	498

Keterangan : Diketahui dari tabel diatas diketahui bahwa pada Bulan Mei terdapat jumlah staf sebanyak 498 orang, terdapat 2 orang yang resign yaitu dari unit maternitas dan ICU, serta terdapat 3 jumlah penambahan staf yaitu 2 dokter umum yang di tempatkan di klinik Perusahaan dan 1 orang dokter speasialis gigi anak.

1.9.2 Pendidikan dan Pelatihan

Pada bulan Mei terdapat 7 diklat, dengan rincian 5 diklat internal dan 2 diklat eksternal, sebagaimana terlampir :

a. Diklat Internal

lo.	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Sasaran	Peserta Undangan	Staf Hadir	Staf Tidak Hadir
1	Pelatihan MFK Susulan	04 Mei 2024	Absen MFK 1 + Staf Orientasi	157	53	104
2	Refresh Training Alat Ventilator	06 Mei 2024	ATEM, IKO, ICU (PJ Alat, KARU, dan KaTim)	23	18	5
3	Pelatihan Pemeliharaan dan Pengoperasian Genset dan Panel Listrik	15-16 Mei 2024	IPSRS	4	3	1
4	Refreshment Training Bank Mandiri	21 Mei 2024	KABID, KARU, PJ Gudang Farmasi	37	31	6
5	Pelatihan Eco Enzyme 1	24 Mei 2024	Tim Eco Enzyme	5	5	0

b. Diklat Eksternal

No.	Nama Diklat	Metode	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1	Pelatihan HD bagi Perawat	Luring	22 Januari 2024 – 17 Mei 2024	Allamul Angga Gilang N. R., S.Kep., Ns
2	Pelatihan ICU Dasar	Luring	26 Februari 2024 – 28 Juni 2024	Refi Andi Alamsyah, S.Kep., Ns

c. Tabel Pelaksanaan Diklat Internal dan Eksternal SDM RS PHS

No	Tanggal	Jenis Diklat (Internal /Eksternal)	Nama Diklat	Target Peserta	Capaian Target	Analisis dan RTL
1.	22 Januari – 17 Mei 2024	Eksternal	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	Allamul Angga Gilang, S.Kep., Ns	1 orang yang diberangkatkan dengan target 4 orang yang dikutkan pelatihan	Pelatihan Dialis bagi Perawat dilaksanakan guna menunjang proses pengembangan pelayanan hemodialisa di Rumah Saki Prima Husada Sukorejo. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah

No	Tanggal	Jenis Diklat (Internal /Eksternal)	Nama Diklat	Target Peserta	Capaian Target	Analisis dan RTL
						memberangkatkan staf selanjutnya di gelombang kedua untuk mengikuti pelatihan.
2.	26 Februari – 28 Juni 2024	Eksternal	Pelatihan ICU Dasar	Refi Andi alamsyah, S.Kep., Ns	8 dari jumlah staf ICU	Pelatihan ICU Dasar dilaksanakan guna menunjang kemampuan dan kompetensi staf serta memenuhi persyaratan akreditasi terkait dengan standar jumlah staf yang telah mengikuti pelatihan ICU pada unit ICU di Rumah Saki Prima Husada Sukorejo. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memberangkatkan staf selanjutnya apabila dibuka kembali pelatihan untuk staf yang belum mempunyai sertifikasi ICU Dasar.
3.	29 April – 9 Agustus 2024	Eksternal	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	Linda Saputri, A.Md.Kep	1 orang yang diberangkatkan dengan target 4 orang yang diikuti pelatihan	Pelatihan Dialisis bagi Perawat dilaksanakan guna menunjang proses pengembangan pelayanan hemodialisa di Rumah Saki Prima Husada Sukorejo. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memberangkatkan staf selanjutnya di gelombang kedua untuk mengikuti pelatihan.
4.	04 Mei 2024	Internal	Pelatihan MFK Susulan	Staf yang tidak mengikuti pelatihan MFK	Jumlah undangan 157 dengan kehadiran peserta 53 orang (33,76%)	Dari undangan sejumlah 157 orang diketahui yang hadir untuk mengikuti diklat adalah 53 orang. 104 orang lainnya tidak hadir dalam pelatihan. Tindak lanjut untuk staf yang tidak mengikuti pelatihan adalah terdapat pengurangan poin dalam tunjangan kinerja staf yang bersangkutan.
5.	06 Mei 2024	Internal	Refresh Training Alat Ventilator	ATEM, Kepala Ruang, Perawat PJ Alat	Jumlah undangan 23 dengan kehadiran peserta 18 orang (78,26%)	Dari undangan sejumlah 23 orang diketahui yang hadir untuk mengikuti diklat adalah 18 orang. 9 orang lainnya tidak hadir dalam pelatihan. Tindak lanjut untuk staf yang tidak mengikuti pelatihan adalah terdapat pengurangan poin dalam tunjangan kinerja staf yang bersangkutan.
6.	15 – 16 Mei 2024	Internal	Pelatihan Pemeliharaan dan Pengoperasian Genset dan Panel Listrik	IPSRS	Jumlah undangan 4 dengan kehadiran peserta 3 orang (75%)	Dari undangan sejumlah 4 orang diketahui yang hadir untuk mengikuti diklat adalah 3 orang. 1 orang lainnya tidak hadir dalam pelatihan. Tindak lanjut untuk staf yang tidak mengikuti pelatihan adalah terdapat pengurangan poin dalam tunjangan kinerja staf

No	Tanggal	Jenis Diklat (Internal /Eksternal)	Nama Diklat	Target Peserta	Capaian Target	Analisis dan RTL
						yang bersangkutan.
7.	15 – 17 Mei 2024	Eksternal	Seminar dan Workshop PERSI	Direksi	3 peserta yang diajukan, 2 peserta yang diberangkatkan	Seminar dan workshop mengenai “Memaksimalkan Profit Rumah Sakit, Berdayakan Manajemen Operasional” dan “Pelaksanaan Audit Klinis Berdasarkan RME untuk Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit” dilaksanakan guna menunjang proses pengembangan pelayanan di Rumah Saki Prima Husada Sukorejo.
8.	21 Mei 2024	Internal	Refreshment Training Bank Mandiri	Kepala Bidang dan Kepala Ruang	Jumlah undangan 37 dengan kehadiran peserta 31 orang (83,78%)	Dari undangan sejumlah 37 orang diketahui yang hadir untuk mengikuti diklat adalah 31 orang. 8 orang lainnya tidak hadir dalam pelatihan. Tindak lanjut untuk staf yang tidak mengikuti pelatihan adalah terdapat pengurangan poin dalam tunjangan kinerja staf yang bersangkutan.
9.	24 Mei 2024	Internal	Pelatihan Eco Enzyme 1	K3RS, ATEM, IPAL/B3, CS	Jumlah undangan 5 dengan kehadiran peserta 5 orang (100%)	Dari undangan sejumlah 5 orang diketahui yang hadir untuk mengikuti diklat adalah 5 orang. Akan terdapat diklat di tanggal selanjutnya pada : 16 Agustus 2024 dan 13 September 2024.

1.9.3 Evaluasi Kinerja Staf

No.	Kriteria	Indikator	Jumlah	Keterangan
1	Reward dan Proses Pembelajaran	Reward	0	
		Teguran Lisan	0	
		Teguran Tertulis	0	
		SP-1	2	Legalitas
		SP-2	0	
		SP-3	0	
		PHK	1	Tukang operasional yang beragnti menjadi tukang harian lepas
2	Mangkir Kerja	Staf Sakit	56	Dengan Surat Dokter
		Cuti Diluar Tanggungan	1	
		Staf Tidak Masuk tanpa Alasan (Alpha)	8	
		Cuti Melahirkan	10	Terkondisikan
		Cuti Menikah	4	

1.9.4 Staf SIP N-ED

Tabel Hasil Rekapitulasi Jumlah Staf yang SIP Near Expired Date (N-ED) Pada Bulan Mei Th 2024

No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
Proses					
1	dr. Adni Kautsari Ismini	Dokter Umum	400.722.2/SIP-DUA/559/424.072/2024	14 Mei 2024	08 Mei 2029
2	dr. Reka Vikaria Anggreli	Dokter Umum	400.722.2/SIP-DU/563/424.072/2024	31 Mei 2024	15 Mei 2029
3	drg. Syafrini Farrahdebi	Dokter Gigi Umum	400.7.22.2/SIP-DRG/164/424.072/2024	14 Mei 2024	08 Mei 2029
4	dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K)	Dokter Spesialis Bedah Plastik	400.722.2/SIP-DS/332/424.072/2024	02 Mei 2024	24 April 2029
5	drg. Normayanti, Sp.KG	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	400.722.2/SIP-DS/337/424.072/2024	14 Mei 2024	07 Mei 2029
6	Rachmad Venus Andika, A.Md.Kes	Fisioterapis	500.16.7.2/002/SIK-F/V/424.086/2024	06 Mei 2024	29 April 2029
7	Yuyun Dianita, Amd. Kep	Perawat	500.16.7.2/237/SIP-P/V/424.086/2024	17 Mei 2024	06 Mei 2026
8	Putri Aliviah Kurniawati, A.md.,Kep	Perawat	500.16.7.2/212/SIP-P/V/424.086/2024	06 Mei 2024	29 April 2029
9	Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb	Bidan	500.16.7.2/170/SIP-B/V/424.086/2024	30 Mei 2024	21 Mei 2029
10	Nabila Avliyatul Faizah, S.Farm.Apt	Apoteker	500.16.7.2/073/SIP-A/V/424.086/2024	06 Mei 2024	24 April 2029
11	Umus Salamah, AMd.Farm	TTK	500.16.7.2/040/SIP-TTK/V/424.086/2024	17 Mei 2024	08 Mei 2029
12	Nur Aini, S.Kep., Ns	Perawat	500.16.7.2/256/SIP-P/V/424.086/2024	30 Mei 2024	18 Juni 2027
Masa Berlaku Kurang dari 6 Bulan					
1	Siti Mas Miranda Anggraeni, S.Kep., Ns	Perawat	503/122/SIP-P/III/424.086/2023	09 Maret 2023	19 Juni 2024
2	Indri Ayu Wandhani, Amd. Kep	Perawat	46/SIP/320/424.072/2020	2 Desember 2020	26 Juni 2024
3	Siti Khumairoh, Amd. Kep	Perawat	46/SIP/213/424.072/2020	05 Agustus 2020	9 Agustus 2024
4	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	Dokter Jantung dan Pembuluh Darah	46/SIP-DS/77/424.072/2019	8 Desember 2019	10 Oktober 2024
5	Ayu Indra Irmia, Amd. Farm	TTK	46/SIP TTK /9/424.72/2019	01 April 2019	6 Oktober 2024
6	Debi Firmanasia, Amd. Kep	Perawat	46/SIP/214/424,072/2020	28 Agustus 2020	13 November 2024
7	Novi Lianti Indra., S. Keb.Bd	Bidan	503/118/SIP-B/VI/424.086/2022	16 Juni 2022	15 November 2024
8	Antika Setya Narutama, S.Kep., Ns	Perawat	503/338/SIP-P/VI/424.086/2022	07 Juni 2022	16 November 2024
9	Ida Nihayatul Afifa, S.Kep., Ns	Perawat	503/052/SIP-P/II/424.086/2023	03 Februari 2023	19 November 2024
10	Eko Puji Pangestu, Amd. Kep	Perawat	6/SIK-P/104/424.072/2021	15 Februari 2021	9 Januari 2025
11	Yesy Fitri Eka Firdaus, A.Md.Kes	Analisis Kesehatan	503/018/SIP-ATLM/III/424.086/2023	03 April 2023	7 Januari 2025

1.10 Kemajuan Piutang																
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c= d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
	PERIODE JUNI 2024 :															
1	Asuransi	423.112.210	260.089.386	4.768.235	158.254.589	239.100.473	56.802.125	2.360.507	179.937.842	338.192.430	285.732.271	44.948.132	3.920.452	1.258.420	2.333.156	338.192.430
2	Perusahaan	229.701.849	170.002.250	7.009.898	52.689.701	150.564.719	29.502.944	1.050.000	120.011.775	172.701.477	164.000.703	3.630.049	1.155.725	3.915.000	-	172.701.477
3	Mandiri Inhealth	65.356.661	9.427.712	2.810.629	53.118.320	18.536.780	-	-	18.536.780	71.655.100	34.857.664	24.463.708	12.333.728	-	-	71.655.100
4	Jasa Raharja	188.877.052	188.271.992	1	605.059	259.656.229	23.768.622	0	235.887.607	236.492.665	236.492.665	-	-	-	-	236.492.665
5	Kantin	12.854.670	5.036.500	-350	7.818.520	6.112.350	-	-	6.112.350	13.930.870	8.273.000	2.149.100	1.150.450	1.079.500	1.278.820	13.930.870
6	BPJS Ketenagakerjaan	2.188.756.654	239.893.990	-101	1.948.862.765	698.214.149	-	-	698.214.149	2.647.076.913	1.242.205.329	437.390.906	432.467.486	505.438.587	29.574.654	2.647.076.963
									Total Saldo	3.480.049.455	1.971.561.631	512.581.895	451.027.841	511.691.507	33.186.630	3.480.049.504

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

RS Prima Husada Sukorejo yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Letak Geografis yang strategis dekat dengan banyak Perusahaan mengharuskan RS Prima Husada Sukorejo berinovasi memberikan pelayanan yang prima dan diminati kalangan sekitar.

Pemanfaatan Gedung semaksimal mungkin ditujukan untuk dapat memberikan pelayanan yang nyaman untuk Masyarakat daerah Pasuruan. Pemenuhan layanan-layanan Kesehatan juga dijadikan daya Tarik dalam mencapai pasar. Pengembangan layanan penunjang dimaksimalkan untuk menambah daya Tarik rumah sakit.

Penambahan pelayanan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang ada. Pengupayaan berupa refresh pelatihan berkala menjadi agenda rumah sakit. Ketersediaan pemenuhan jabatan diharap akan berdampak positif dalam peningkatan kegiatan supervise berjenjang.

4.2 SARAN

- 4.2.1.1 Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta menerbitkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
- 4.2.1.2 Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
- 4.2.1.3 Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Sukorejo

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan Bulan Juni 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Sukorejo, 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS